

Guia Prático de Implantação da Terapia Comunitária Integrativa na Atenção Primária à Saúde



Construindo Pontes e
Integrando Saberes

Venda Proibida

EDITORA ABRATECOM
2025

Guia Prático de Implantação da Terapia Comunitária Integrativa na Atenção Primária à Saúde: Construindo Pontes e Integrando Saberes

Organizadores

Milene Zanoni da Silva
Marcos Fábio Turra
Giovana Daniela Pecharki
Suely Ruiz Giolo
Maria Lucia de Andrade Reis
Greice Mara Mendes

Colaboradores

Abrahão Nunes da Silva
Adalberto de Paula Barreto
Adalberto Kioshi Agueimi
Álamo Augusto Maia Bezerra
Carlos Eduardo Cantusio Abrahão
Cristian da Cruz Silva
Franciele Delurdes Colatusso
Francisco Torres Troccoli
Flávia Placeres Parravicini
Karen Berenice Denez
Júlia Feldmann Uhry Reis
Leni Silva de Araújo
Maria Henriqueta Camarotti
Mirna Barros Teixeira
Patricia Pássaro da Silva Toledo
Sabrina Stefanello
Solena Ziemer Kusma Fidalski
Tissiane Paula Zem Igeski
Vitória Figueiredo Barreto

Revisão de texto

Suely Ruiz Giolo
Franciele Delurdes Colatusso
Tissiane Paula Zem Igeski

Capa

Sabrina Ferreira de Lima Czornobay
Natasha Sabrina dos Santos
Michele Portela da Luz

Presença nas Oficinas

Danielle Talita dos Santos Fogarolli
Mari Elaine Leonel Teixeira
Selma Hinds
Thassiane Terre de Meira
Claudia Botelho de Oliveira Moreira
Gisele Gallant
Jussara Otaviano
Solange Rothbart Bara
Mariana Cabral Schweitzer
Luciano Duarte Medeiros
Doralice Oliveira Gomes
Elis Fernanda Moreira
Maria do Carmo de Amorim
Márcia Naomi Santos Higashijima
Aldiney José Doreto
Josefa Emília Lopes Ruiz
Deivisson Vianna Dantas dos Santos
Rubia Carla Formighieri Giordani
Pollyanna Kássia de Oliveira Borges
Gisléa Kândida Ferreira da Silva
Cleunice Castorina de Souza
Márcia Nascimento Caiaffo
Vitória Caroline Gonçalves
Maria Anita Arland
Fabíola Damas de Carvalho e Silva
Mayara Natale Araújo
Anna Carolina Batista de Moura
Amanda Carolina Fontoura
Danieh Diniz
Fabíola Angelita C. B. Martins
Fernanda Cruz Vieira Ferreira
Thaysa Acosta Rebonato
Silvia de Azevedo Barreto Fix
Dora Mariela Salcedo Barrientos
Maria Goretti Cruz
Luciana Querino

Guia prático de implantação da terapia comunitária integrativa na atenção primária à saúde: construindo pontes e integrando saberes

© 2025 Milene Zanoni da Silva, Marcos Fábio Turra, Giovana Daniela Pecharki, Suely Ruiz Giolo, Maria Lucia de Andrade Reis, Greice Mara Mendes. Todos os direitos reservados.

Editora ABRATECOM

Produção editorial: Suely Ruiz Giolo

Imagem da capa: Milene Zanoni da Silva, utilizada com o consentimento de todos.

É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização dos autores. É permitido o uso de trechos da obra para fins não comerciais, desde que os autores e a obra original sejam devidamente citados.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Guia prático de implantação da terapia comunitária integrativa na Atenção Primária à Saúde [livro eletrônico] : construindo pontes e integrando saberes / organização Milene Zanoni da Silva...[et al.]. -- 1. ed. -- Fortaleza, CE : ABRATECOM, 2025.
PDF

Vários autores.

Outros organizadores: Marcos Fábio Turra, Giovana Daniela Pecharki, Suely Ruiz Giolo, Maria Lucia de Andrade Reis, Greice Mara Mendes.

Vários colaboradores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-986830-0-9

1. Atenção Primária à Saúde 2. Medicina integrativa 3. Saúde pública 4. Serviços de saúde 5. Sistema Único de Saúde (Brasil) 6. Terapia comunitária 7. Terapias complementares
I. Silva, Milene Zanoni da.

25-263584

CDD-615.53

Índices para catálogo sistemático:

1. Terapia integrativa 615.53

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

CONTEÚDO

Prefácio	6
Nota Introdutória	9
Reflexões do Criador da Terapia Comunitária Integrativa	11
1 Terapia Comunitária Integrativa	18
1.1 Histórico da Terapia Comunitária Integrativa	18
1.2 Caracterização da Terapia Comunitária Integrativa	21
1.2.1 O Que é Terapia Comunitária Integrativa	21
1.2.2 O Que não é Terapia Comunitária Integrativa	22
1.3 Metodologia da Terapia Comunitária Integrativa	23
1.4 Terapia Comunitária Integrativa e o SUS	25
1.5 Terapia Comunitária Integrativa e a APS	28
2 Capacitação em Terapia Comunitária Integrativa	35
2.1 Curso de Capacitação em TCI	35
2.2 Requisitos para a Capacitação em TCI	37
2.3 Sobre a Atuação do Terapeuta Comunitário	37
2.4 Polos Formadores em TCI	38
2.5 O Que é a ABRATECOM	40
2.6 Como Filiar-se à ABRATECOM	41
2.7 Quem Pode Participar das Rodas de TCI	41
2.8 Recursos Necessários	42
2.9 Benefícios da TCI	42
3 Mapeamento da TCI na Atenção Primária à Saúde	44
3.1 Introdução	44
3.2 Cenário de Acordo com o CNES	45
3.3 Cenário de Acordo com o SISAB	48
4 Financiamento da Terapia Comunitária Integrativa	50
4.1 Financiamento	50
4.2 Possíveis Fontes de Financiamento da TCI	54
5 Registro nos Sistemas de Informação em Saúde	59
5.1 Importância do Registro	59
5.2 Onde Realizar o Registro da TCI	59
5.3 Incentivo para a Realização do Registro da TCI	61

5.4	Quem pode Realizar o Registro da TCI	61
5.5	Como Proceder o Registro da TCI	62
5.5.1	Passos Iniciais: Registro no CNES	62
5.5.2	Registro da TCI no e-SUS APS	63
5.5.3	Registro da TCI em Sistemas de Informação Próprios	66
5.5.4	Registro de Procedimentos de Telessaúde no e-SUS APS	67
5.5.5	Sub e Super-registros	68
6	Indicadores de Monitoramento e Avaliação da TCI	70
6.1	Introdução	70
6.2	Indicadores de Monitoramento da TCI	72
6.3	Indicadores de Avaliação da TCI	73
6.4	Monitoramento da TCI	75
6.4.1	Indicador 1: Número de Rodas de TCI na APS	76
6.4.2	Indicador 2: Número de Atendimentos nas Rodas de TCI na APS	78
6.4.3	Indicador 3: Percentual de Estabelecimentos com Cadastro em TCI	81
6.5	Obtenção de Relatórios de Acesso Público	85
6.5.1	Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB)	85
6.5.2	Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde (CNES)	89
7	Legislação e Documentação	93
7.1	Instrumentos Normativos	93
7.2	Políticas Estaduais de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde	96
7.3	Documentos Relevantes	99
8	Competências Institucionais dos Gestores	101
8.1	Competências Institucionais	101
8.1.1	Competências Federais - Governo Federal	101
8.1.2	Competências Estaduais - Governo Estadual	102
8.1.3	Competências Municipais - Governo Municipal	102
8.2	Integração entre os Níveis de Gestão	103
9	Regulamentação das Profissões da Área da Saúde	104
9.1	Resolução dos Conselhos de Classe	104
10	Sensibilização de Gestores, Profissionais de Saúde e Comunidade	108
10.1	Introdução	108
10.2	Estratégias de Sensibilização	108

11	Controle Social/Participação Social	111
11.1	Introdução	111
11.2	Controle Social e a TCI	112
11.2.1	Participação Comunitária Integrativa: Proposta para Fazer Diferente	114
12	Instrumentos de Gestão da TCI	116
12.1	Introdução	116
12.2	Instrumentos de Gestão da TCI	116
13	Passo a Passo para a Implantação da TCI na APS	119
13.1	Passos para a Implantação da TCI	119
14	Evidências Científicas	127
14.1	Introdução	127
14.1.1	Acesso a Recursos e Pesquisas	127
14.1.2	Cuidados na Divulgação de Informações sobre a TCI	128
Anexo A		130
Referências		134

Prefácio

O Conselho Nacional de Saúde (CNS), por intermédio da Comissão Intersetorial de Promoção, Proteção e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CIPPPICS), Gestão 2021-2025, tem a honra de redigir o prefácio do *Guia Prático de Implantação da Terapia Comunitária Integrativa na Atenção Primária à Saúde: Construindo Pontes e Integrando Saberes*.

Parabenizamos a todos os seus organizadores e colaboradores pela iniciativa e comprometimento com a produção deste guia altamente relevante, que visa expandir o alcance da Terapia Comunitária Integrativa (TCI).

O processo de construção do guia ocorreu de forma colaborativa, envolvendo cerca de 60 pessoas de diversas instituições e movimentos sociais. Para viabilizar a participação de todos, três oficinas coletivas foram realizadas no formato on-line, criando um espaço de cooperação e troca de saberes entre diferentes setores, dentre eles, universidades e centros de pesquisa, escolas de saúde pública, secretarias de saúde municipais e estaduais, referências técnicas em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), associações do terceiro setor, movimentos sociais e redes comunitárias, e entidades de âmbito municipal, estadual e nacional. Como resultado desse processo colaborativo, foi produzido um material sólido, representativo das necessidades e potencialidades da TCI na Atenção Primária à Saúde (APS).

Em termos gerais, o guia apresenta os fundamentos da metodologia da TCI, os passos práticos para a sua implantação na APS e os impactos positivos que a TCI pode gerar na vida das pessoas e das comunidades.

Em essência, o propósito do guia é apoiar gestores municipais e estaduais, profissionais de saúde, conselheiros, lideranças comunitárias e outros atores do controle social, na implementação da TCI como estratégia inovadora e sustentável. O guia consiste, assim, em uma ferramenta essencial para a difusão, popularização e consolidação da TCI no SUS, contribuindo para a transformação do cuidado em saúde mental no país.

A saúde mental representa um dos grandes desafios da atualidade, impactando indivíduos, famílias e comunidades. Ademais, a sobrecarga dos serviços de saúde, a insuficiência de profissionais especializados e a medicalização excessiva do sofrimento humano tornam urgente a adoção de estratégias eficazes, acessíveis e humanizadas. Nesse contexto, a TCI destaca-se como uma tecnologia social inovadora, de baixo custo e alta efetividade, promovendo acolhimento, escuta qualificada e fortalecimento dos vínculos comunitários. Ao integrar a TCI às políticas públicas de saúde do Brasil, fortalece-se um modelo de cuidado que respeita a singularidade dos indivíduos, promove autonomia e amplia a construção de redes solidárias.

A TCI contribui diretamente para a consolidação dos princípios e diretrizes do SUS, pois amplia o acesso ao cuidado em saúde mental e fortalece a atenção primária com base na participação comunitária e na valorização dos saberes locais. Sua metodologia está alinhada aos eixos condutores da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, pois integra conhecimentos acadêmicos e saberes tradicionais, resultando em uma prática inovadora e sustentável.

Inserida na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, a TCI também se alinha a outras políticas públicas, como a Política Nacional de Humanização, de Promoção da Saúde, de Educação Popular em Saúde, de Educação Permanente em Saúde e de Atenção Básica. Essa integração permite expandir e qualificar o cuidado em saúde mental, priorizando a prevenção e promovendo maior autonomia dos indivíduos em relação ao próprio bem-estar.

Além de sua importância como estratégia de inovação para o SUS, a TCI apresenta viabilidade comprovada para aplicação em larga escala e incorporação de novas tecnologias sociais no setor público, em especial na Atenção Primária à Saúde.

Atualmente, os transtornos mentais figuram entre as principais causas de incapacidade no mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta a depressão como a principal causa de afastamento do trabalho. No Brasil, cerca de 10% da população sofre com transtornos mentais comuns, impactando significativamente a qualidade de vida das pessoas e sobrecarregando os serviços de saúde. A TCI oferece uma solução acessível e eficaz, sendo possível atender um grande número de pessoas com um investimento reduzido.

Os benefícios em investir na TCI vão além do alívio do sofrimento emocional. Seus impactos incluem: a) promoção da saúde mental (fortalecimento das redes de apoio, prevenção de agravos e redução da dependência de medicalização); b) fomento ao autocuidado e à autoestima (empoderamento dos participantes para lidarem com desafios da vida de maneira mais consciente e ativa); c) resiliência comunitária (fortalecimento dos laços sociais e incentivo a soluções coletivas para desafios locais); d) autonomia e protagonismo social (valorização dos recursos internos e culturais de cada indivíduo para a superação de adversidades); e) integração da cultura como recurso terapêutico (inclusão de saberes ancestrais e práticas culturais no cuidado em saúde); sustentabilidade e inovação no SUS (expansão de estratégias eficazes e sustentáveis na rede pública de saúde); e f) fortalecimento da cultura de paz (promoção de um ambiente baseado no respeito, na solidariedade e na construção coletiva).

Que a leitura deste guia inspire novas práticas e fortaleça a inovação e a sustentabilidade na saúde pública!

Brasília, 27 de fevereiro de 2025.

Conselho Nacional de Saúde (CNS)

Comissão Intersetorial de Promoção, Proteção e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CIPPPICS) – Gestão 2021-2025

Nota Introdutória

Terapia Comunitária Integrativa como estratégia de fortalecimento da APS e do SUS

A OPAS/OMS Brasil tem o prazer e considera uma honra escrever a nota introdutória deste guia de Implantação da Terapia Comunitária Integrativa (TCI) na Atenção Primária à Saúde (APS), por cuja elaboração parabenizamos aos autores.

As Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas (MTCI) têm ganhado crescente reconhecimento no cenário internacional como componentes relevantes para a promoção da saúde, prevenção de doenças e atenção integral às populações. A Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio de sua *Estratégia Global de Medicina Tradicional Complementar e Integrativa 2025–2034*, propõe como um de seus objetivos estratégicos integrar práticas seguras e eficazes de MTCI aos sistemas nacionais de saúde. Essa diretriz reforça a importância de reconhecer, regulamentar e incorporar tais práticas com base em evidências e em diálogo com os saberes tradicionais e comunitários.

Nesse contexto, a Terapia Comunitária Integrativa (TCI), uma prática criada no Brasil e que já alcançou outros países (MISMEC-CE, 2020), se destaca como uma tecnologia leve que promove o cuidado coletivo, o fortalecimento de vínculos e a escuta qualificada em espaços comunitários. A TCI se insere de forma coerente nas recomendações da OMS ao propor uma abordagem centrada nas pessoas, valorizando saberes populares e promovendo o autocuidado, o apoio mútuo e o protagonismo comunitário — elementos fundamentais para um modelo de atenção centrado na integralidade.

A TCI também se alinha aos princípios da *Estratégia para o Acesso Universal à Saúde e a Cobertura Universal de Saúde* da OPAS/OMS, especialmente no que tange ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) como ordenadora do cuidado e coordenadora das redes de atenção. Ao ser adotada em unidades básicas de saúde, escolas, espaços culturais e territórios

vulnerabilizados, a TCI contribui para ampliar o acesso, reduzir barreiras psicossociais, humanizar os serviços e fomentar práticas intersetoriais e comunitárias, em consonância com os atributos da APS e com o modelo de Redes Integradas de Serviços de Saúde (RISS).

Entretanto, um dos principais desafios para a consolidação das Práticas Integrativas e Complementares como modelo de cuidado no Brasil reside na sua efetiva incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS). A institucionalização dessas práticas exige o reconhecimento de sua relevância pelas gestões locais, a formação de profissionais, a alocação de recursos e, sobretudo, a transferência de tecnologias como a TCI de forma qualificada e sustentável. O caminho para essa consolidação demanda um esforço coordenado entre gestores, trabalhadores, movimentos sociais e usuários, com vistas a superar barreiras culturais, institucionais e operacionais.

A integração de práticas como a TCI ao sistema de saúde, especialmente ao SUS, representa uma oportunidade concreta de transformação do modelo de cuidado, com foco na escuta, vínculo, equidade e participação social. Ao reconhecer e incorporar saberes comunitários e práticas integrativas com base em princípios de segurança, eficácia e respeito cultural, o Brasil avança na consolidação do direito à saúde como expressão de cidadania e justiça social. Assim, o fortalecimento das MTIC no SUS, ancorado em marcos internacionais como os da OMS e OPAS, representa não apenas uma inovação em saúde, mas um aprofundamento da democracia sanitária e do compromisso com a vida.

Brasília, 04 de abril de 2025.

Julio Pedroza

Coordenador de Sistemas e Serviços de Saúde e Capacidades Humanas para Saúde
Representação da OPAS/OMS no Brasil

Rafael Dall Alba

Consultor de Sistemas e Serviços de Saúde OPAS Brasil

Reflexões do Criador da Terapia Comunitária Integrativa

Dr. Adalberto de Paula Barreto¹

TCI: A arte de cuidar de si, dos outros, da comunidade e do planeta

Vivemos em uma sociedade cada vez mais individualista, que exclui muitas pessoas e provoca problemas emocionais que afetam não só o indivíduo, mas também as relações sociais e a saúde mental de todos. Quando as pessoas são excluídas e impedidas de desenvolver seus talentos, elas se tornam mais frágeis e dependentes. Isso gera um sentimento de incapacidade e insegurança, o que pode levar à marginalização e a uma falta de autoconfiança. A confiança em si é fundamental; quando ela é abalada, a pessoa se sente perdida, sem fé em si, nos outros e em seu futuro. Esse cenário pode fazer com que as pessoas se sintam angustiadas e incertas sobre seus vínculos sociais, afetando as bases simbólicas da cultura e a identidade delas.



O cuidar que prejudica

Quando comecei meu trabalho como psiquiatra e psicoterapeuta no projeto 4 varas, na favela do Pirambu em Fortaleza, percebi que muitas pessoas que atendia sofriam mais de problemas emocionais que precisavam ser ouvidos e acolhidos do que de doenças psiquiátricas que precisavam ser tratadas com medicamentos. Muitas vezes, esses sofrimentos são rotulados como depressão, fobia social ou isolamento, e acabam sendo tratados apenas com remédios. O paradoxo é que, quanto mais medicamentos são dados, mais o paciente vai mal.

¹Professor Emérito da Faculdade de Medicina da UFC; Doutor em Psiquiatria pela Universidade René Descartes de Paris; Doutor em Antropologia pela Universidade de Lyon 2, França; Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Social e Criador da metodologia da Terapia Comunitária Integrativa.

O cuidado deve considerar a pessoa na totalidade, considerando o que temos em comum, como água, ar e florestas. Focar apenas na parte biológica dos problemas mentais é uma visão limitada e apenas alivia o sofrimento temporariamente, sem realmente ajudar. O objetivo não é apenas eliminar os sintomas, mas auxiliar a pessoa a entender o que está sentindo, dar sentido ao que está acontecendo, sempre considerando seu contexto histórico, familiar e social. Ignorar isso é uma irresponsabilidade.

Devemos lembrar que existe vida além da doença. A pessoa é um ser humano com habilidades e potenciais que precisam ser despertados para que ela possa se recuperar e construir sua identidade. A medicalização do sofrimento pode prejudicar o paciente, provocando “maltrato”, ao criar uma resposta que não está conectada à realidade dele e pode causar mais problemas.

Para cuidarmos de outras pessoas, precisamos usar diferentes abordagens — biológica, psicológica, social, espiritual, quântica. Reduzir o ser humano a apenas uma delas é uma visão limitada. A medicina, a psicologia, a sociologia, a filosofia e a teologia, entre outras, são recursos valiosos para promover a saúde. Qualquer fanatismo, seja ele de natureza biológica, psicológica, sociológica ou religiosa, é um obstáculo ao desenvolvimento de ações que promovam a vida. Precisamos superar preconceitos que limitam nossa visão e nossas ações.

Ao cuidar dos outros, devemos deixar de lado a ideia de que precisamos mudar os valores e crenças da outra pessoa. Tentar impor nossa visão é uma forma de violência, mesmo que feita com boas intenções. Precisamos respeitar a maneira de ser e os valores dos outros. Como cuidadores, abrimos portas, mas cabe ao outro decidir atravessar.

Cada um tem sua forma de acolher e ajudar o outro a descobrir o que já possui. Essa ideia é importante porque, se consideramos alguém como “vítima”, podemos acabar nos colocando como salvadores, criando uma relação de dependência. Se eu for insistente em impor meus valores e crenças,

estou negando a diversidade e empobrecendo o potencial terapêutico. Impor uma única maneira de ver e cuidar em um mundo tão diverso é uma visão limitada. O campo do cuidado está cheio de armadilhas, e é fácil se deixar levar por ideologias que excluem outras abordagens. Muitas pessoas buscam mestres ou gurus e esquecem de procurar dentro de si mesmas, perdendo a riqueza cultural que herdaram.

Os melhores cuidadores são aqueles que acreditam na capacidade do outro de superar seus desafios. Muitas vezes, a relação de ajuda é desigual, onde um especialista dá e o outro recebe, o que pode fazer com que o profissional perca a oportunidade de aprender com a experiência de vida do outro. Paulo Freire nos ensina que aprender é um processo compartilhado. Assim como na educação, na arte de cuidar também existe uma troca: ensino e aprendo com o outro, dou e recebo, cuido e sou cuidado.

Quando cuidamos sem perceber os benefícios dessa troca, criamos relações de dependência. “Dar” pode fazer com que quem oferece se sinta superior e quem recebe se sinta devedor, o que pode levar a desentendimentos. O “provedor” passa a ser visto como um salvador, o que pode criar expectativas irreais. Reconhecer que dependemos de alguém pode diminuir a autoestima e fazer a pessoa se sentir passiva.

Se a relação não atende às expectativas, o “devedor” pode se revoltar contra o “provedor”, mudando os papéis e acusando quem tentou ajudar. Isso pode resultar em conflitos, e muitas vezes vemos aqueles que ajudamos se tornarem nossos críticos os mais cruéis.

Toda superproteção é um atestado de incapacidade que dou ao meu protegido. Falta de confiança nas capacidades recíprocas de um e do outro. Muitas vezes, quem protege tem medo de ficar sozinho ou de perder a pessoa que está ajudando. Shakespeare já nos alertava sobre essa ambiguidade do cuidar, dizendo: “Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar a alma.”

O dar que nos liberta

Para evitar que todo gesto de doação e cuidado se torne fonte de conflito, é essencial oferecer ao beneficiado uma “carta de alforria”. Isso significa libertá-lo da sensação de dívida em relação ao cuidador, dizendo: “Você não me deve nada. O que faço por você é algo que já fizeram por mim. Espero que você faça o mesmo quando encontrar alguém que precise.” Assim, o cuidador elimina um possível inimigo.

É importante lembrar da circularidade no cuidar: ao cuidar do outro, também estou cuidando de mim. Estender a mão não me torna superior; não tenho o direito de transformar a outra pessoa em um seguidor do meu método ou crença. O cuidado deve ser pautado pelo respeito à individualidade, aceitando as diferenças que nos tornam únicos. Essa é uma habilidade que precisamos aprimorar a cada interação.

A consciência do encontro com o outro é a chave para o autoconhecimento. O outro se torna um colaborador essencial em nosso processo de evolução. Não existe “eu” sem “tu”, assim como não há “tu” sem “eu”. Esse entendimento é fundamental para nosso crescimento pessoal e profissional: reconhecermos que somos “precários”. A arte de cuidar se transforma em uma experiência gratificante para o cuidador, quando ele vê o cuidar do outro como uma oportunidade de também cuidar de si e crescer juntos.

Princípios do cuidar na Terapia Comunitária

A arte de cuidar envolve receber tanto quanto dar, acolhendo o outro sem a intenção de mudá-lo. Hermann Hesse exprime essa ideia ao afirmar: “Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir outro mundo além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Ajudarei a tornar visível, e isso é tudo.” Essa humildade é essencial para que a ajuda não se transforme em uma relação de dominação.

Quando tentamos impor nosso ponto de vista e nossos valores ao outro, arriscamos colonizá-lo, tornando-nos protagonistas de suas vidas. Ao oferecer ajuda, podemos nos tornar guias, mas isso pode levar a uma dinâmica de controle, onde a pessoa se sente dominada. Conselhos e julgamentos podem criar dependência, limitando a autonomia e a vitalidade do outro.

O verdadeiro cuidado deve ser um espaço que empodera, permitindo que cada pessoa explore suas próprias capacidades e encontre suas soluções. O papel do cuidador é facilitar esse processo, ajudando a revelar as potencialidades que já existem dentro de cada um.

Damos hoje o que recebemos ontem, e o que recebo hoje posso dar amanhã. Isso é natural no ser humano. Todos temos necessidades que nos levam a buscar conexão com os outros. Hoje ajudamos, e amanhã podemos precisar de ajuda. Essa troca é essencial, pois todos somos vulneráveis. A consciência de estar em contato com o outro nos ajuda a conhecer melhor a nós mesmos. O outro é um parceiro importante no nosso crescimento. Não existe “eu” sem “tu” e vice-versa. O segredo do nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, é entender que somos todos interdependentes. Cuidar do outro é também uma oportunidade de cuidar de si e crescer juntos.

Cuidados solidários

A vida é uma verdadeira escola que nos ensina a cuidar. Muitas pessoas, sem formação acadêmica, se tornam especialistas nesse cuidado, transformando o sofrimento em sensibilidade e apoio. Esses cuidadores ajudam a criar uma nova ordem social, renascendo das dificuldades. Eles são cuidadores porque cuidam da dor.

Aprenderam a converter feridas em lições e pérolas e sofrimento em crescimento. As experiências dolorosas do passado se tornam fontes de força e empatia. O que antes era um lamento se transforma em uma motivação para ajudar os outros.

Em nosso projeto “4 Varas” em Fortaleza, é fundamental que o cuidador comunitário entenda seu papel. Seu trabalho difere do de psicólogos ou médicos, que fazem diagnósticos e tratam doenças. O cuidador comunitário foca na promoção da saúde e na prevenção, encaminhando aqueles que precisam de ajuda profissional.

Esses cuidadores acolhem o sofrimento com os recursos da cultura local. Acolher a dor da alma é uma ação solidária que qualquer pessoa pode fazer, mas o tratamento de doenças deve ser feito por profissionais de saúde. Se os cuidadores tentarem fazer diagnósticos ou tratamentos, podem enfrentar problemas legais. Os dois papéis são diferentes, mas se complementam.

Existem muitas maneiras de acolher e cuidar do outro, ajudando a despertar suas capacidades criativas, essenciais para a recuperação. Muitas pessoas buscam respostas fora de si, esquecendo-se de olhar para dentro. Essa busca externa pode levar ao fracasso.

Uma ideia central do nosso trabalho é que a primeira escola é a família e a primeira lição vem da criança que fomos. Muitas vezes, valorizamos o conhecimento adquirido em livros e cursos, mas esquecemos das lições que a vida nos ensina. A verdadeira força vem da aceitação de nossa história e da compreensão de que a carência pode gerar competência. Por exemplo, podemos expressar amor não apenas porque o recebemos, mas também porque superamos a dor do abandono.

Nos últimos 40 anos, tenho estudado como algumas pessoas conseguem transformar suas experiências difíceis em algo positivo. A vida é uma universidade, e o conhecimento não vem apenas da academia, mas também das experiências vividas. O importante é unir esses saberes de forma complementar.

É com esse propósito que o Guia Prático de Implantação da Terapia Comunitária Integrativa na Atenção Primária à Saúde foi desenvolvido: para construir pontes e integrar saberes entre os diferentes setores da sociedade. Ele reúne a contribuição de usuários, gestores municipais e estaduais, profissionais

da saúde, referências técnicas em PICS, escolas de saúde pública, universidades e movimentos sociais. Essa diversidade de olhares fortalece a construção coletiva de práticas de cuidado mais acessíveis, eficazes e enraizadas na realidade de cada comunidade.

Fortaleza, 2 de fevereiro de 2025.

Adalberto de Paula Barreto

1

TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA

1.1 Histórico da Terapia Comunitária Integrativa

A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) surgiu na década de 80, em Fortaleza, na comunidade do Pirambu, considerada a maior favela do estado, em meio a um cenário de precária presença de políticas públicas. A população vivenciava alta vulnerabilidade social e carência de seus direitos mais básicos, como saúde, segurança pública, acesso a emprego, renda, bens e serviços dignos, criando um ambiente marcado pela baixa autoestima, desigualdades sociais, insegurança e abandono, e procuravam na medicalização a solução para seus sofrimentos (Silva *et al.*, 2020). Somando-se a isso, a década de 1980 foi marcada pelas lutas sociais, luta pelos direitos humanos, em meio a um cenário que adentrava na democracia, após anos de ditadura militar. Grandes conquistas foram obtidas com a promulgação de uma nova Constituição Federal em 1988, que, em seu artigo 196, garantia a saúde como um direito do povo e dever do Estado, ao mesmo tempo em que uma luta pela reforma psiquiátrica se levantava. Este cenário ansiava por mudanças em saúde, não de caráter assistencialista, de alienação social, verticalizado, mas sim centrado na pessoa, nas suas raízes e cultura, influenciado pela educação de Paulo Freire, com saúde humanizada, sem enfoque medicalizante (Silva *et al.*, 2020).

Foi nesse terreno de ausência do Estado e necessidade de garantia de direitos humanos que, em 1987, nasceu o movimento social de saúde mental da TCI, fruto de um trabalho coletivo realizado na comunidade do Pirambu pelos irmãos José Airton de Paula Barreto e Adalberto de Paula Barreto.

José Airton foi pioneiro na história da luta da comunidade do Pirambu. Por volta de 1981, mudou-se para o Pirambu para viver a experiência de morar sozinho, junto aos pobres. À época, era estudante de direito e trabalhava como estagiário da arquidiocese. Em decorrência de um conflito social por posses de terra ocorrido em meados de 1985 no Pirambu, a Arquidiocese de Fortaleza implantou na comunidade uma ação em defesa dos direitos humanos. Nesta ação, José Airton atuou como advogado, prestando auxílio jurídico aos moradores em casos de regularização de documentos dos lotes, violência, prisões ilegais, dentre outros (Giffoni, 2008).

Durante os atendimentos jurídicos, Airton, como era mais conhecido na comunidade, deparou-se com o desafio de lidar com outros problemas, como o sofrimento decorrente de relações familiares conturbadas, além de situações geradas pelas péssimas condições de vida. Diante desse cenário, Airton passou a organizar um sistema informal de encaminhamento de consultas para o ambulatório de psiquiatria, onde seu irmão Adalberto, psiquiatra, teólogo, antropólogo e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), ministrava aulas práticas aos alunos da Faculdade de Medicina. Devido ao aumento da demanda por consultas, Adalberto decidiu fazer o caminho inverso, passando a atender na própria comunidade, com os alunos da UFC (Giffoni, 2008).

Em seus atendimentos, Adalberto começou a observar que as pessoas sofriam cada vez mais de “Dores da Alma”, e buscavam cada vez mais o alívio para suas dores na medicalização que resultava em pouca resolutividade, mas o que mais precisavam era o acolhimento do seu sofrimento, falar sobre suas dores e buscar na própria comunidade e em si mesmos o caminho para a solução dos seus problemas.

Iniciava-se, assim, a TCI, que valoriza o conhecimento popular e a experiência de vida de cada indivíduo, assim como sua cultura e de seus ancestrais, unindo o saber científico com o popular (Barreto, 2008).

Segundo Adalberto de Paula Barreto: Quando a boca cala, os órgãos falam; e quando a boca fala, os órgãos saram.

Figura 1.1 – José Airton de Paula Barreto e Adalberto de Paula Barreto



Fonte: Ilustração de autoria de Marina Figueiredo Barreto (2025).

Atualmente, a TCI está presente no Brasil e em diversos países do Continente Africano, Américas e Europa. No Peru, foi reconhecida pelo Centro Colaborador de Medicinas Tradicionais Integrativas e Complementares da Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma ferramenta de fortalecimento do autocuidado e promoção da saúde mental mundial. Esse reconhecimento internacional se pauta na relevância, sustentabilidade, replicabilidade e interculturalidade entre saberes promovida pela TCI.

Em 2024, a TCI foi certificada pela Fundação Banco do Brasil como Tecnologia Social, que compreende "um conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida." (ITS Brasil, 2004, p. 26).



Em 2024, a TCI também foi uma das vencedoras da 12ª Edição do Prêmio Fundação BB Tecnologia Social. Segundo a Fundação Banco do Brasil, o prêmio concedido às vencedoras visa certificar, premiar e difundir Tecnologias Sociais já aplicadas e em atividade, que se constituam em efetivas soluções para questões relativas à alimentação, educação, energia, geração de renda, habitação, meio ambiente, recursos hídricos e saúde (Fundação BB, 2024).

1.2 Caracterização da Terapia Comunitária Integrativa

1.2.1 O Que é Terapia Comunitária Integrativa

A TCI fundamenta-se em cinco pilares: o pensamento sistêmico, a pragmática da comunicação humana, a antropologia cultural, a pedagogia de Paulo Freire e a resiliência. Através da troca de experiências e sabedorias, cria vínculos e resgata a autonomia dos indivíduos, transformando carências em competências, estimulando a resiliência comunitária, que os tornarão capazes de ressignificar momentos de dores e perdas (Barreto, 2008).

Trata-se de uma prática terapêutica coletiva, genuinamente brasileira, para todos os ciclos de vida, que atua em espaços abertos e envolve os membros da comunidade em atividades de construção de redes sociais solidárias para a promoção da vida e mobilização de recursos e competências dos indivíduos, famílias e comunidades. Baseia-se em princípios de inclusão, participação, solidariedade e autonomia, sendo aplicada em comunidades que enfrentam vulnerabilidades psico-socioeconômicas, sendo os saberes individuais os elementos para a construção de laços sociais, apoio emocional, troca de experiências e diminuição do isolamento social (DECS, 2024).

É uma tecnologia social que empodera as pessoas, impulsiona a resiliência e o resgate da autoestima, incentivando a cooperação mútua e os cuidados solidários, com a valorização dos recursos culturais para o enfrentamento das vulnerabilidades. A TCI é uma forma de ajudar o outro a se curar, e é uma forma de curar a si mesmo (Brasil, 2008). Todos que participam das

rodas tornam-se corresponsáveis na busca de soluções e superação dos desafios cotidianos, em um ambiente acolhedor e caloroso (Barreto, 2008).

O conceito ampliado de saúde/doença depende de diversos fatores além dos componentes biológicos, como as condições do local em que se vive, acesso a lazer, boas condições de vida e de trabalho, acesso a alimentação de qualidade, meios de transporte, estresse do cotidiano, as desigualdades sociais, pobreza, exclusão social, as características do território em que se vive, o apoio social disponível (vizinhos, grupos de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos etc.). A TCI é um auxílio no enfrentamento dos determinantes sociais que influenciam a saúde, principalmente a saúde mental, por meio do apoio familiar, incentivando atividades associativas a fim de evitar o isolamento, contribuir com a reinserção social, promover as capacidades de enfrentamento dos problemas cotidianos, a construção de redes de apoio social e relações interpessoais sadias, apoiar ações que favoreçam o sentimento de pertencimento, de participação e de valorização do indivíduo. Tudo isso tem efeito positivo sobre a promoção da saúde (Brasil, 2008; Barreto, 2008).

Desse modo, é importante que políticas de saúde pública, que promovam ações de enfrentamento no processo de adoecimento e que sejam promotoras de saúde no seu contexto mais ampliado, sejam incentivadas e desenvolvidas; e, nesse contexto, a TCI se enquadra perfeitamente como uma ação nesse sentido.

1.2.2 O Que não é Terapia Comunitária Integrativa

A TCI não é uma psicoterapia, realizada por psicólogos e psiquiatras, mas sim um ato terapêutico de abordagem psicossocial com metodologia própria construída com e para a comunidade, que não pode ser confundida com terapia de grupo, grupos operativos ou psicodrama. A TCI não é centrada na patologia ou na patologização do sofrimento, da vida e da morte,

como ocorre no modelo biomédico. Ela foca na vida, na pessoa, na história de vida individual e familiar e nos recursos comunitários.

1.3 Metodologia da Terapia Comunitária Integrativa

Segundo Barreto (2008) e Silva *et al.* (2020), a metodologia da TCI envolve a criação de rodas de conversa onde os participantes, guiados por um ou mais terapeutas comunitários integrativos, compartilham suas experiências, problemas e soluções. A TCI segue um protocolo específico, que pode ser dividido em seis etapas:

- 1) Acolhimento: O Acolhimento é considerado a "alma" da roda de TCI, no qual os participantes são recebidos com alegria e de forma acolhedora pelo terapeuta comunitário que conduzirá a roda, criando um ambiente seguro e de confiança. É ainda realizado um momento de celebração, no qual os participantes podem expor suas conquistas ou celebrar alguma data especial em suas vidas. Nesse momento, pode-se propor uma música ou uma dinâmica corporal para "quebrar o gelo". O objetivo é que todos se sintam à vontade para participar. Nesta etapa, explica-se as regras para a condução da roda.
- 2) Escolha da Inquietação: Os participantes são convidados a apresentar suas inquietações, dificuldades e desafios. A partir dessas falas, o grupo escolhe democraticamente um tema para ser trabalhado na sessão.
- 3) Contextualização: O terapeuta comunitário ajuda a contextualizar o problema apresentado, incentivando os participantes a explorarem suas raízes e implicações. Nesta fase, utiliza-se a técnica de "desfocar o problema", ampliando a visão dos participantes sobre suas dificuldades e promovendo uma perspectiva mais abrangente.
- 4) Partilha de Experiências: Os membros do grupo compartilham suas próprias experiências e soluções relacionadas ao tema em questão. Esta etapa é crucial para a construção coletiva do conhecimento e para o for-

talecimento dos vínculos comunitários. O terapeuta pergunta: Quem já viveu algo parecido e o que fez para superar?

- 5) Finalização: A sessão é encerrada com o terapeuta agradecendo a presença e coragem de todos e com um ritual que pode incluir músicas, poemas, ou outros gestos simbólicos. O objetivo é consolidar os aprendizados e reforçar a sensação de pertencimento e apoio mútuo.
- 6) Apreciação: Após o término da roda, é realizada apreciação entre os terapeutas para avaliar os resultados e possibilidades de melhora.

Figura 1.2 – Roda de TCI com Adalberto de Paula Barreto



Fonte: Ilustração de autoria de Marina Figueiredo Barreto (2025).

Regras da Terapia Comunitária Integrativa

- 1) Fazer silêncio quando alguém está falando: Para respeitar a fala do outro e para exercitar a escuta ativa.
- 2) Falar apenas de si próprio, na primeira pessoa ("eu"): Os participantes são incentivados a falar sobre suas próprias experiências e sentimentos, utilizando a primeira pessoa. Isso ajuda a evitar julgamentos e generalizações, focando nas vivências individuais.
- 3) Não julgar nem dar conselhos, sermões ou fazer discurso: Os participantes são encorajados a não julgar, criticar ou dar conselhos diretos aos outros. Em vez disso, eles compartilham suas próprias experiências e aprendizados, permitindo que cada um tire suas próprias conclusões.
- 4) Regra da Cultura: Uso de metáforas, histórias, músicas, piadas, provérbios que tenham a ver com o tema. O terapeuta comunitário pode utilizar metáforas, histórias e elementos culturais para ilustrar pontos importantes e facilitar a compreensão e a reflexão dos participantes.

1.4 Terapia Comunitária Integrativa e o SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS), implantado no Brasil em 1990 pela Constituição Federal de 1988, possui diretrizes e princípios que o regulamentam, a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Brasil, 1990a). Os princípios do SUS, que incluem a universalidade, integralidade e equidade, estão profundamente interligados com a promoção da saúde e prevenção de doenças, elementos fundamentais das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). As PICS, ao integrar métodos terapêuticos, como a TCI, fortalecem a abordagem holística do SUS, enfatizando a atenção integral ao indivíduo e à comunidade.

A TCI promove espaços de escuta e acolhimento, alinhando-se ao princípio da integralidade do SUS ao considerar as dimensões física, mental e social da saúde. Conforme evidenciado em estudos, essas práticas reduzem a

medicação excessiva e melhoram a qualidade de vida das pessoas, sendo uma estratégia eficaz na prevenção de doenças e promoção da saúde (Brasil, 2018; Macedo *et al.*, 2020). Ao integrar essas práticas, o SUS reforça seu compromisso com uma assistência integral e humanizada, promovendo a saúde de maneira equitativa e acessível a toda a população.

A TCI é uma prática coletiva que ajuda a fortalecer esses princípios do SUS. É caracterizada como tecnologia leve, que, segundo Merhy (2002), compõe-se de tecnologias de relações, através de produção de vínculo, busca da autonomia, acolhimento, diálogo aberto, escuta qualificada, dinâmica de grupos com linguagem e abordagens adequadas. É também de baixo custo e de fácil logística, que pode ser desenvolvida em diversos espaços como: Unidades Básicas de Saúde (UBS), hospitais, Centros de Atenção Psicossociais (CAPS), escolas e universidades, associações de bairro, corporações, cooperativas, salas de espera, pastorais de igrejas, pontos de cultura, empresas, redes de saúde, Centros de Referência de Assistência Psicossocial (CRAS), penitenciárias, praças públicas, instituições públicas e privadas, redes de apoio não governamental, como a rede Alcoólicos Anônimos (AA), Narcóticos Anônimos (NA), bem como em ambientes virtuais em contextos de crises e calamidades, como foi o caso da pandemia de Covid-19.

É uma Prática Integrativa e Complementar em Saúde genuinamente brasileira, que, desde 2017, integra o rol das 29 PICS reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Portaria nº 849, de 27 de março de 2017 (Brasil, 2017). Está inserida na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), e é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma ferramenta de fortalecimento do autocuidado e promoção da saúde mental mundial (Silva Franco *et al.*, 2020). Para saber mais sobre a PNPIC e a Portaria nº 849, consulte os links fornecidos a seguir.

PNPIC	https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpic.pdf
Portaria nº 849	https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt0849_28_03_2017.html

É fundamental ressaltar que a TCI vem para somar-se à Rede de Atenção em Saúde (RAS) do SUS, e não para substituir nenhum modelo vigente. Visa auxiliar no enfrentamento de situações da saúde mental, agindo de forma responsável, sempre reconhecendo os limites de atuação e tendo a noção de que os casos mais complexos, que extrapolam as dimensões do acolhimento solidário, devem ser encaminhados às demais unidades ou equipamentos de saúde da RAS.

Nos últimos anos, a incidência e a prevalência de problemas de saúde mental na população vêm aumentando consideravelmente, e nem sempre o modelo biomédico promove a redução de sintomas e prevenção de agravos, tornando, assim, a inserção da TCI relevante para preencher essa lacuna, propiciando tanto a recuperação quanto a prevenção de doenças, sejam elas de ordem física ou mental, fortalecendo a integralidade das ações de enfrentamento dos agravos em saúde. A TCI tem a vantagem de ser um método não medicamentoso, voltado para o autocuidado, que privilegia a escuta acolhedora, o vínculo e a integração com o meio ambiente e a comunidade (Barreto, 2008; Silva *et al.*, 2020).

Esta prática pensa o ser humano como possuidor de recursos e saberes úteis aos outros, competências estas advindas de dificuldades superadas e dos recursos culturais. A partilha dessas experiências de forma horizontal e circular ajuda a ressignificar o sofrimento do outro. Muitos autores consideram que os assuntos que são trazidos pelas pessoas nos encontros coletivos, chamados de rodas de TCI, podem ser um parâmetro para se avaliar quais os determinantes sociais de saúde (DSS) mais prevalentes e que são causadores de sofrimentos na comunidade, além de auxiliar no seu enfrentamento, podendo ser um norteador para formulações de políticas públicas eficazes (Barreto *et al.*,

2011). A TCI contribui para evidenciar o impacto da dimensão coletiva do adoecimento provocado pelo estresse contínuo relacionados às questões sociais, econômicas, culturais, políticas e ambientais, que individualmente são vivenciados por meio das patologias físicas e psíquicas.

No momento da roda de TCI, as realidades parecem com sentido de desesperança, abandono, revolta e insegurança, configurando o que Barreto chama de síndrome da miséria psíquica, resultado de uma tríplice perda: perda de confiança em si, nos outros e no futuro. A pessoa não crê mais no seu potencial, desvaloriza-se nos diversos ambientes, seja na sua família ou na sociedade, não se sente mais merecedora de afeto, de felicidade e de sucesso (Barreto, 2008).

1.5 Terapia Comunitária Integrativa e a APS

O SUS organiza-se em níveis de atenção, de acordo com a sua complexidade, na forma de prestação do atendimento à população. A Atenção Primária à Saúde (APS) é definida como o primeiro nível de contato dos indivíduos, famílias e comunidades com o sistema de saúde. É caracterizada por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, buscando alto grau de resolutividade, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na saúde das populações (Brasil, 2012).

Segundo Giovanella e Mendonça (2012), a APS constitui os serviços de primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde de fácil acesso, com direcionamento de cobrir as principais afecções e condições mais comuns e a resolver a maioria dos problemas de saúde de uma população.

A APS é organizada de forma descentralizada e hierarquizada, baseada nos princípios da universalidade, integralidade e equidade, buscando atender de forma contínua e integral às necessidades de saúde da população. Os servi-

ços são ofertados preferencialmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde equipes multiprofissionais (compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde) atuam de maneira integrada para proporcionar um atendimento de qualidade e resolver a maioria dos problemas de saúde da população (Brasil, 2012).

Na APS, está inserida a Estratégia Saúde da Família (ESF), modelo assistencial que atua com equipes multiprofissionais, trabalhando com definição de territórios de abrangência e acompanhamento da população residente na área, realizando cadastramento das famílias e atendimento da clientela adscrita, além dos demais preceitos inerentes à APS no SUS.

Compete à ESF conhecer as famílias e as características do seu território de abrangência para poder identificar os problemas de saúde e as situações de risco existentes na comunidade e, a partir disso, elaborar programas de atividades para enfrentar os determinantes do processo saúde/doença. As equipes de ESF devem desenvolver ações educativas e intersetoriais relacionadas aos problemas de saúde identificados e promover assistência integral às famílias do território de sua responsabilidade (Giovanella; Mendonça, 2012; Brasil, 2006).

Segundo o Ministério da Saúde, três tipos de equipes compõem a ESF. São elas: eSF – equipe de saúde da família (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde), eSB – equipe de saúde bucal (dentistas e auxiliares e/ou técnicos de saúde bucal), eMulti – equipe multiprofissional (psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais, e médicos especialistas: psiquiatras, pediatras, ginecologistas, geriatras etc.).

Considerando os conceitos e contextos da APS e ESF, a TCI pode ser inserida como estratégia de cuidado comunitária, bem como pode ser inserida nos demais níveis de atenção do SUS.

A APS e a ESF possuem a maior demanda de enfrentamento das doenças e o maior contato com a população, onde a resolutividade precisa ser a maior possível, reduzindo o número de encaminhamentos para os outros níveis de atenção do SUS, os quais encarecem o tratamento e sobrecarregam os outros níveis de atenção.

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a APS pode atender de 80 a 90% das necessidades de saúde de uma pessoa ao longo de sua vida. É principalmente neste contexto que a TCI pode dar sua maior contribuição, trabalhando com os recursos próprios do indivíduo e os recursos disponíveis ao seu redor, atuando na inclusão e valorização das diferenças (Brasil, 2008). Vem para somar-se às demais práticas da APS, e não para substituir o modelo biomédico prevalente, mas promover uma cooperação, trabalhando em sinergia com os demais equipamentos de saúde do SUS, de forma integrativa e complementar.

No contexto histórico do surgimento da TCI, a população buscava a solução dos seus problemas de saúde mental, ansiedade e depressão na medicalização, e não fazia relação entre seus sofrimentos com o contexto sócio-político-econômico em que estava inserida, com o cenário de precária presença de políticas públicas, imerso em alta vulnerabilidade social, restrição de direitos humanos, desigualdades sociais, baixa autoestima, insegurança, abandono, precariedade de empregos ou desemprego, baixa renda, pouco acesso a bens e serviços. Achavam que a solução para suas dores viria de fora, trazida por especialistas, gerando assim relações de dependência e assistencialismo (Silva *et al.*, 2020). Para saber mais sobre o cenário da Terapia Comunitária Integrativa no Brasil: história, panorama e perspectivas, consulte o link a seguir: <https://periodicos.fclar.unesp.br/tes/article/view/14316>.

De modo geral, a TCI atua como opção eficaz no enfrentamento dos problemas de saúde mental, ajudando a desafogar os profissionais da APS, assim como os da atenção secundária e terciária, já tão sobrecarregados com a

grande demanda de problemas de saúde geral e com a alta incidência e prevalência de problemas de saúde mental. Devido a esta alta demanda, estes profissionais muitas vezes não conseguem oferecer uma atenção humanizada, centrada na pessoa, na família, na comunidade, no território e contexto em que a pessoa está inserida.

A TCI se mostra como uma importante ferramenta em saúde, com baixo custo, e com grande capacidade de enfrentamento desses problemas, com alívio dos sintomas, ressignificação do sofrimento, intensificação ao autocuidado, atuando dentro dos princípios do SUS e ajudando o trabalho da ESF, favorecendo o acolhimento e suprimindo a lacuna de um serviço centrado na pessoa e na família, contribuindo com a integralidade da APS e com a resolutividade dos casos.

Além disso, a TCI propõe reforçar a rede de apoio, criar espaços de inclusão e valorização da diversidade resgatando a herança cultural e a história pessoal de cada um (Barreto *et al.*, 2011). Apenas os casos de maior complexidade são encaminhados para a atenção secundária para atendimento por especialistas. Sentimento de rejeição, solidão e abandono são amenizadas com a rede solidária criada com a TCI.

A APS deve ser orientada pelos seguintes princípios para a prestação de serviços de saúde eficazes e acessíveis (Starfield, 2002; Giovanella; Mendonça, 2012): primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, abordagem familiar e enfoque comunitário.

O Quadro 1.1 apresenta os atributos da APS e suas interfaces com a Terapia Comunitária Integrativa.

Quadro 1.1 – Atributos da Atenção Primária à Saúde (APS) e suas interfaces com a TCI, Brasil, 2024

(continua)

Atributos da APS	Interfaces com a Terapia Comunitária Integrativa (TCI)
Primeiro contato: A atenção primária deve ser o ponto de primeiro contato dos indivíduos com o sistema de saúde, oferecendo acesso fácil e imediato.	A TCI, ao ser implementada em unidades básicas de saúde e comunidades, facilita o acesso imediato dos usuários a suporte emocional e psicológico, muitas vezes reduzindo barreiras que impedem a busca por ajuda tradicional.
Longitudinalidade do cuidado: Os pacientes devem ter acesso a cuidados contínuos ao longo do tempo com uma equipe de saúde familiar ou um profissional de saúde.	A TCI promove a continuidade do cuidado ao criar vínculos duradouros entre a comunidade e equipe de saúde, assegurando que o suporte emocional esteja sempre disponível ao longo do tempo.
Integralidade: A atenção primária deve atender a uma gama completa de necessidades de saúde, abrangendo prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos.	A TCI contribui para a integralidade ao abordar não apenas os aspectos físicos da saúde, mas também os emocionais, sociais e espirituais, integrando diferentes saberes e práticas terapêuticas. Além disso, promove redes de cuidado solidários e aponta para as equipes de saúde acerca das reais necessidades de saúde da comunidade, com tomadas de decisão mais assertivas no acesso e assistência às pessoas e comunidades.
Coordenação: Deve haver uma coordenação eficiente dos cuidados entre diferentes níveis e tipos de serviços de saúde.	A TCI atua como uma ponte, facilitando a coordenação entre diferentes serviços de saúde, pois os facilitadores muitas vezes identificam necessidades que podem ser encaminhadas para outros serviços, promovendo uma abordagem holística e integrada.

Quadro 1.1 – Atributos da Atenção Primária à Saúde (APS) e suas interfaces com a TCI, Brasil, 2024 (conclusão)

Atributos da APS	Interfaces com a Terapia Comunitária Integrativa (TCI)
Abordagem familiar: Os cuidados devem considerar o contexto familiar e comunitário, envolvendo-os ativamente no processo de saúde e bem-estar.	A TCI potencializa o modelo comunitário, focado no território, pois é lá que está o seu viver, é lá onde as pessoas amam, trabalham, sofrem e constroem suas vidas, apresentando-se como uma forma efetiva e promissora para atuar sobre a imensa demanda por serviços de atenção à saúde mental (Ferreira Filha; Lazarte; Barreto, 2015). Descobrem que têm problemas, mas que também têm soluções. Tornam-se parceiros na busca de solução e de superação das dificuldades, ou seja, deixam de ser assistidos e passam a ser corresponsáveis na busca de soluções (Barreto <i>et al.</i> , 2011).
Enfoque comunitário: Os serviços de saúde devem ser culturalmente apropriados e sensíveis às necessidades e valores das diversas populações atendidas.	É uma estratégia de promoção de saúde que valoriza o saber popular e a cultura local com o saber acadêmico, cria canais de expressão do sofrimento emocional do ser humano, promove rodas de acolhimento comunitário, com escuta do sofrimento e das inquietudes do indivíduo, favorecendo um ambiente de trocas de experiências entre os participantes das rodas, promovendo e estimulando o autocuidado (Brasil, 2008).

Fonte: Elaborado por Milene Zanoni da Silva (2024), considerando os atributos da APS em Giovanella e Mendonça (2012).

Por isso, enfrentar o estresse de forma adequada é uma estratégia de promoção da saúde. Nesse sentido, deve-se reconhecer a importância de uma política pública consistente, para apoiar as atividades associativas, combater o isolamento, promover a reinserção social e estimular as capacidades desses indivíduos para enfrentar os problemas do cotidiano. Pensar em ações que viabilizem, a nível comunitário, o cuidado e o acolhimento dos transtornos sem medicalizá-los, e do sofrimento difuso no cotidiano, de modo integral (corpo social, físico e mental) pode contribuir para a diminuição de filas, de espaços segregadores, promovendo o encontro da diversidade pela partilha e resgate da memória coletiva (Barreto *et al.*, 2011).

Após o período da pandemia de Covid-19, em que a população precisou se proteger, mantendo-se em isolamento social, longe de seus familiares, de seu trabalho e de sua rotina, os indicadores de saúde mental pioraram muito.

Historicamente, a TCI sempre teve um caráter grupal e presencial, mas, durante a pandemia de Covid-19, as rodas presenciais não puderam ser realizadas. Iniciou-se, assim, outra modalidade de realização da TCI — a modalidade on-line — com oferecimento de rodas virtuais, mas que também obtiveram resultados positivos na saúde mental (Barreto *et al.*, 2020).

Durante o período conturbado de isolamento social, a TCI no formato on-line pôde atuar para diminuir os efeitos do estresse, do medo, da solidão, do luto, do desamparo e da desesperança.

2

CAPACITAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA

2.1 Curso de Capacitação em TCI

O processo formativo na maioria das 29 Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) reconhecidas no sistema público de saúde brasileiro, acontece por meio de curso de oferta livre, caso da TCI, da reflexologia, da shantala, do reiki, da meditação, dentre outras. De acordo com o artigo 42 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cursos livres são formações abertas à comunidade, sem carga horária preestabelecida e com matrícula condicionada à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade (Brasil, 1996). Visto que o processo formativo em TCI é classificado como Curso Livre, não cabe aos Ministérios da Saúde e da Educação reconhecer e validar cursos dessa natureza.

A capacitação em TCI segue a metodologia proposta pelo idealizador da TCI, Adalberto Barreto. No Brasil, o curso de capacitação é ofertado pela Rede de Polos Formadores reconhecidos e credenciados pela ABRATECOM.

Até o advento da pandemia de Covid-19, o curso de capacitação era realizado totalmente no formato presencial, com carga horária de, no mínimo, 240 horas/aula, divididas em 50 horas/aula de módulos teóricos, 50 horas/aula em vivências para o resgate da autoestima pautadas em Branden (1994), 60 horas/aula de estágio prático, em que o Terapeuta Comunitário em formação necessita realizar 30 rodas de TCI em diferentes populações e contextos a fim de apropriar-se da metodologia e do “ser terapeuta”, e 80 horas/aula de inter-

visão, que objetiva estabelecer um diálogo entre a teoria e a prática, necessária à construção dessa nova forma de atuar nas comunidades.

Contudo, em razão da pandemia de Covid-19, a Rede de Polos Formadores brasileira e latino-americana se reuniu a fim de repensar a capacitação em TCI — considerando a modalidade híbrida — em detrimento das necessidades sanitárias e epidemiológicas de isolamento social, mas que não podem representar isolamento afetivo e emocional (Silva *et al.*, 2020).

Para a modalidade híbrida, estabeleceu-se (ABRATECOM, 2021) carga horária de, no mínimo, 240 horas/aula, divididas em 50 horas/aula de módulos teóricos (em até 100% no formato on-line), 50 horas/aula em vivências terapêuticas (desenvolvidas integralmente no formato presencial), 60 horas/aula de estágio prático (em até 50% no formato on-line, correspondendo à condução de, no máximo, 15 rodas de TCI on-line), e 80 horas/aula de intervenção (em até 100% no formato on-line).

Obedecidos os limites descritos, fica a critério de cada Polo Formador definir os percentuais de aulas on-line e presenciais. Atualmente, os Polos Formadores podem optar em oferecer a capacitação em TCI no formato totalmente presencial ou no formato híbrido.

Os cursos de capacitação em TCI podem ser realizados a partir de convênios ou licitações com o setor público e de parcerias com o setor privado ou terceiro setor. Também podem ocorrer por demanda espontânea de pessoas interessadas em realizar a referida capacitação.

Considerando a atuação do profissional no sistema público de saúde brasileira, fica explícito no art. 200, inciso III, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 (Brasil, 1988), que cabe ao SUS a competência de ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

Desde a criação do SUS, em 1990, ocorreram três convênios do Ministério da Saúde com a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura/UFC, executados pela Rede de Polos Formadores da ABRATECOM. São eles:

- a) 2007 - Convênio nº 3363/2007,
- b) 2008 - Convênio nº 3363/2007 e nº 2397/2008,
- c) 2012 - P26203/11-74 - TC 101 FNS / UFC.

Em decorrência desses convênios, estima-se que tenham sido capacitados mais de quatro mil trabalhadores da saúde e lideranças comunitárias pelo SUS (Tesser; Souza; Nascimento, 2018).

2.2 Requisitos para a Capacitação em TCI

Para a condução de rodas de TCI em qualquer setor de atuação (primeiro, segundo e terceiro setores), é imprescindível que ocorra a capacitação em TCI em cursos promovidos pelos Polos Formadores vinculados à Rede ABRATECOM.

Para realizar o curso de capacitação em TCI deve-se ter idade igual ou superior a 18 anos e ter interesse em adquirir conhecimentos sobre uma abordagem de saúde comunitária. Ademais, dentre as características desejáveis para realizar a capacitação estão: gostar de trabalhar em equipe, ter conhecimento sobre a rede de apoio na sua comunidade, e estar engajado em trabalhos comunitários.

Para realizar a capacitação não há restrições quanto ao nível de escolaridade. Contudo, para atuar, por exemplo, como terapeuta comunitário no setor público, nível mínimo de escolaridade é geralmente exigido nos editais de concursos públicos ou de processos seletivos.

2.3 Sobre a Atuação do Terapeuta Comunitário

A oferta das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no SUS, o que inclui a TCI, deve ser realizada, preferencialmente, por profissionais de saúde capacitados e vinculados ao SUS, respeitando as competências profissionais de cada área (Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006, diretriz 3.1).

A contratação de profissionais para atuar nas PICS dentro do SUS geralmente ocorre por meio de concursos públicos ou processos seletivos, variando conforme o município ou o estado. A modalidade de contratação pode ser CLT, estatutária ou temporária, dependendo das políticas locais de gestão de pessoal. Em algumas localidades, como no município de São Paulo, existe ainda a possibilidade de atuação de voluntariado no SUS, conforme legislação federal.

Os profissionais de saúde do SUS, com capacitação em TCI, habilitados a realizar rodas de TCI presencial e/ou on-line e registrá-las nos sistemas de informação em saúde estão listados no Quadro A.1 (Anexo A), de acordo com o código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Para informações adicionais, consulte o link a seguir.

<http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0101050020/01/2025>

2.4 Polos Formadores em TCI

Os Polos Formadores são as instituições responsáveis pela capacitação em TCI e certificação de Terapeutas Comunitários Integrativos. No Brasil, e em outros países da América Latina, a formação em TCI é realizada pelos Polos Formadores credenciados à ABRATECOM.

Em 2024, a ABRATECOM relatou a existência de 48 Polos no Brasil, dois no Chile, dois no Peru, um no Equador e um na República Dominicana.

O Quadro 2.1 mostra a identificação dos 48 Polos localizados no Brasil, sendo 39 Polos Formadores e 9 Polos de Cuidado, e a Figura 2.1 a distribuição geográfica dos mesmos.

A lista de Polos Formadores e de Cuidado localizados no Brasil e demais países da América Latina é atualizada periodicamente pela ABRATECOM, podendo ser visualizada no endereço <https://abratecom.org/npolos/>.

Quadro 2.1 – Identificação dos Polos Formadores (PF) e de Cuidado (PC) por região do Brasil, 2024

Região	Identificação do Polo (Classificação do Polo)	Localidade do Polo
Norte (1 polo)	Associação Uaki*ara (PF)	Belém-PA
Nordeste (14 polos)	AQUARIUS (PF) AQUARIUS NAC Saúde Integral (PF) CEFCOM (PF) Espaço Família (PF) Espaço Korihé (PF) Instituto Bem Viver (PC) Instituto Comunidades Positiva (PC) MISC-BA (PF) MISC-PB (PF) MISMEC 4 Varas (PF) MISMEC-VDC (PF) Movimento Saúde Comunitária Bom Jardim (PF) Movimento Tear (PF) MISC-PI (PC)	Maceió-AL Olinda-PE Fortaleza-CE Recife-PE Coroa Vermelha-BA Cratêus-CE São Luís-MA Salvador-BA João Pessoa-PB Fortaleza-CE Vitória da Conquista-BA Fortaleza-CE Aracaju-SE Teresina-PI
Centro-Oeste (7 polos)	Casa de Cuidados Valparaíso (PC) Centrar (PC) Correnteza (PF) Escola Pública de TCI - UnB (PF) MISMEC-DF (PF) MISMEC-GO (PF) Teia Conexões Sustentáveis (PF)	Valparaíso de Goiás-GO Brasília-DF Brasília-DF Brasília-DF Brasília-DF Goiânia-GO Brasília-DF
Sudeste (20 polos)	ASF Associação Saúde da Família (PF) Centro de Estudos e Assistência à Família (PF) CENPE Unesp (PF) CETS Campinas (PF) Centro de Estudos e Vivências Interpessoais (PF) Centro de Estudos de Práticas Integrativas (PC) Espaço Ciranda de Cuidados (PC) Instituto Caifcom (PF) Instituto Afinado Vidas (PF) Instituto Nutrindo a Vida (PC) Interfáci (PF) Intercamp (PF) Liga Solidária (PF) MISC Minas (PF) MISC dos Vales (PF) MISC-RJ (PF) NAC Núcleo de Apoio e Cuidado (PF) Nós Te Apoiamos (PF) Semear Prosec (PF) TCENDO - SP (PF)	São Paulo-SP São Paulo-SP Araraquara-SP Campinas-SP Belo Horizonte-MG Unaí-MG Ipatinga-MG Sul de MG, Zona da Mata e Santos São Paulo-SP e Guaxupé-MG Araxá-MG São Paulo-SP Campinas-SP São Paulo-SP Caratinga-MG Governador Valadares-MG Rio de Janeiro-RJ Araraquara-SP São Paulo-SP Carbonita-MG São Paulo-SP
Sul (6 polos)	Eqlibre (PC) Instituto Caifcom (PF) Instituto Nefesh (PF) MISC-PR (PF) Movimento Terapêutico Graça Martini (PF) Shanti Instituto (PF)	São José dos Pinhais-PR Porto Alegre-RS Maringá-PR Ponta Grossa-PR Londrina-PR Curitiba-PR

Fonte: Os autores (2024) – Elaborado com dados fornecidos pela ABRATECOM.

Figura 2.1 - Número de polos credenciados à Abratecom por região do Brasil, 2024



Fonte: Os autores (2024) – Elaborado com dados fornecidos pela ABRATECOM.

2.5 O Que é a ABRATECOM

A ABRATECOM — Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa — completou 20 anos de sua fundação em 2024. Foi instituída em Brasília, em 1º de maio de 2004, com a autorização do criador da TCI, Adalberto de Paula Barreto, durante o 2º Congresso Brasileiro de Terapia Comunitária Integrativa. À época, estabeleceu-se como uma de suas missões a expansão da capacitação em TCI, congregando, para isso, os Polos Formadores, que são as instituições responsáveis pela capacitação em TCI.

Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, que objetiva fortalecer o desenvolvimento da Terapia Comunitária Integrativa, congregando pessoas e instituições, promovendo e criando redes (Ruiz *et al.*, 2021). Sua função é reconhecer, credenciar e legitimar terapeutas comunitários integrativos e insti-

tuições, além de polos de cuidado e formadores que realizam ações de cuidado e/ou cursos e capacitações em TCI (Silva Franco *et al.*, 2020).

A ABRATECOM já reconheceu e credenciou dezenas de Polos Formadores e de Cuidado no Brasil e em alguns países da América Latina, existindo, em 2024, 48 Polos credenciados no Brasil (Quadro 2.1) e seis em outros países da América Latina.

Conforme prevê o Estatuto e Regimento Interno da ABRATECOM, a capacitação em TCI cabe exclusivamente aos Polos Formadores credenciados. Encontram-se também regulamentados pela ABRATECOM: o conteúdo programático, a carga horária, a certificação, e os requisitos para assumir o papel de facilitador na formação dessa prática (Ruiz *et al.*, 2021).



Para mais informações sobre a ABRATECOM, acesse:

<https://abratecom.org>

<https://www.instagram.com/abratecomoficial/>

https://www.facebook.com/abratecom/?locale=pt_BR

2.6 Como Filiar-se à ABRATECOM

Para filiar-se, é necessário preencher os dados solicitados no formulário de cadastro disponível no link <https://abratecom.org/polos/registrar/>.

2.7 Quem Pode Participar das Rodas de TCI

Seguindo o princípio da universalidade do SUS, a população em geral pode participar das rodas. Pede-se, apenas, que as regras da TCI sejam seguidas, dentre elas, não julgar o outro, não dar conselhos, não dar sermões e falar sempre na primeira pessoa, visto ser um espaço coletivo/comunitário.

As rodas podem ser ofertadas para a comunidade em geral, bem como para grupos específicos, como crianças, jovens, adolescentes, mulheres, idosos, gestantes, famílias de baixa renda, pessoas com deficiência (PcD), povos origi-

nários, LGBTQIAPN+, afrodescendentes, povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, hipertensos ou com outras doenças crônicas, assim como para grupos de alcoólicos anônimos (AA), grupos com dependência química, dentre outros que o município eleja como prioridade.

2.8 Recursos Necessários

Para o desenvolvimento da tecnologia, faz-se necessário um espaço acolhedor e confortável, com pelo menos 2 terapeutas comunitários por grupo, onde a quantidade de participantes não é limitada, podendo reunir-se 10, 100 pessoas ou mais.

Pode ser aplicado em diversos contextos e públicos, como escolas, igrejas, instituições, associações, presídios, ruas, parques e unidades de saúde, sem distinção de idade, gênero ou etnia.

Em termos de custo-efetividade, considerando as questões: valores financeiros e tempo médio das capacitações, número de rodas que cada terapeuta comunitário integrativo em formação necessita realizar (30 rodas) e média de pessoas participando nas rodas, estima-se que o custo unitário para cada participante seja em torno de 2 reais ou 0,4 dólares (junho/2024), ou seja, uma estratégia extremamente custo-efetiva (Fundação BB, 2024).

2.9 Benefícios da TCI

A TCI pode ser implantada para:

- a) Promover o desenvolvimento da autoconsciência, impulsionando para que a pessoa consiga perceber o seu lugar no mundo, e ampliando o senso de solidariedade na busca de soluções para questões sociocomunitárias;
- b) Criar oportunidades para as pessoas se conectarem, compartilharem experiências e construir vínculos significativos;

- c) Favorecer o autocuidado, a promoção da saúde, o alívio do sofrimento, além de ser coadjuvante no tratamento convencional dos transtornos mentais leves e moderados;
- d) Reduzir a violência e a criminalidade;
- e) Fortalecer os laços sociais saudáveis e promover a mediação de conflitos e a cultura para a paz; e
- f) Minimizar o estigma e a discriminação, promovendo empatia e respeito às diferenças.

3

MAPEAMENTO DA TCI NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

3.1 Introdução

O Brasil, formado pela união de 26 estados federados, 5.568 municípios e dois municípios-equivalentes (Brasília e Fernando de Noronha), totalizando 5.570 cidades, possui um dos maiores sistemas de informação em saúde do mundo, e isso se estende também na produção de dados das PICS.

Dados relacionados aos registros, atuação profissional e recursos direcionados às PICS, podem ser consultados nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) do Ministério da Saúde (MS).

Utilizando dados desses sistemas, dentre eles, o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), o MS publicou em 2024 o Relatório de Monitoramento Nacional das PICS nos Sistemas de Informação em Saúde do SUS para o período de 2017 a 2023. De acordo com este relatório, foram registrados na APS, em 2023, um total de 932 estabelecimentos e 363 municípios relacionados ao código SIGTAP da Terapia Comunitária Integrativa (Ministério de Saúde, 2024, p. 196).

O relatório também apresenta outras informações sobre a TCI, como o número de procedimentos de código SIGTAP da TCI e o de participantes nas rodas de TCI registrados na APS, bem como o registro da TCI nas categorias profissionais e equipes de saúde da APS. Para visualizar essas informações, pode-se acessar o relatório utilizando o link a seguir.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/2024/relatorio-de-monitoramento-nacional-das-praticas-integrativas-e-complementares-em-saude.pdf>

Outras informações relacionadas ao monitoramento das rodas de TCI e participação nas mesmas são apresentadas no Capítulo 6 deste guia.

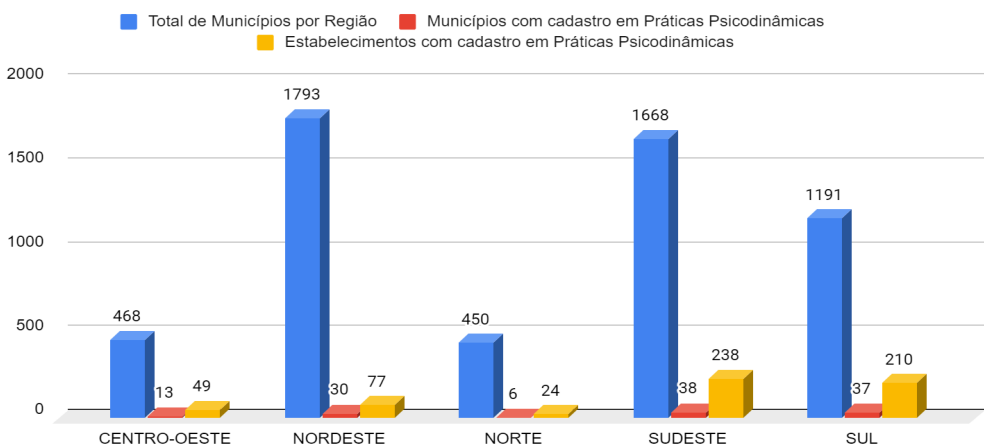
3.2 Cenário de Acordo com o CNES

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), criado pelo MS em 1999, registra informações sobre todos os locais de atendimento de saúde no Brasil e serve de base para operacionalizar os Sistemas de Informação em Saúde do SUS.

Segundo dados do CNES de 2023, havia 598 estabelecimentos com cadastro em Práticas Psicodinâmicas, estando eles localizados em 124 municípios das cinco regiões do Brasil (Figura 3.1 e Tabela 3.1).

Atualmente, quatro PICS estão classificadas no CNES como Práticas Psicodinâmicas: Terapia Comunitária Integrativa, Bioenergética, Constelação Familiar e Hipnoterapia.

Figura 3.1 – Estabelecimentos e municípios com cadastro em Práticas Psicodinâmicas



Fonte: Os autores (2024) – Elaborada com dados de 2023 extraídos do CNES.

Tabela 3.1 - Estabelecimentos e municípios com cadastro no CNES em Práticas Psicodinâmicas, 2023

Unidade da Federação por Região	Total de Municípios	Estabelecimentos com cadastro em PICS	Estabelecimentos com cadastro em Práticas Psicodinâmicas	Municípios com cadastro em Práticas Psicodinâmicas
Centro-Oeste	468	1.636	49	13
DF	1	309	5	1
GO	246	380	5	5
MS	79	664	35	3
MT	142	283	4	4
Nordeste	1.793	3.999	77	30
AL	102	133	3	3
BA	417	1.020	17	7
CE	184	434	3	3
MA	217	674	43	7
PB	223	474	2	1
PE	184	490	3	3
PI	224	201	3	3
RN	167	338	2	2
SE	75	235	1	1
Norte	450	669	24	6
AC	22	47	0	0
AM	62	347	22	4
AP	16	20	1	1
PA	144	158	0	0
RO	52	31	0	0
RR	15	11	0	0
TO	139	55	1	1
Sudeste	1.668	8.823	238	38
ES	78	126	0	0
MG	853	3.948	119	26
RJ	92	1.571	9	4
SP	645	3.178	110	8
Sul	1.191	5.537	210	37
PR	399	414	4	3
RS	497	2.690	105	18
SC	295	2.433	101	16
Brasil	5.570	20.664	598	124

Fonte: Os autores (2024) – Elaborada com dados de 2023 extraídos do CNES.

A Tabela 3.2 apresenta os 124 municípios com cadastro em Práticas Psicodinâmicas no ano de 2023 por Unidade da Federação (UF).

Tabela 3.2 - Municípios do Brasil com cadastro no CNES em Práticas Psicodinâmicas no ano de 2023

UF	Estabelecimentos N = 598	Municípios com Cadastro no CNES em Práticas Psicodinâmicas (Número de Estabelecimentos por Município)
DF	5	Brasília (5)
GO	5	Aparecida de Goiânia (1), Formosa (1), Planaltina (1), Posse (1), Quirinópolis (1)
MS	35	Deodápolis (2), Dourados (32), Iguatemi (1)
MT	4	Campo Novo do Parecis (1), Cuiabá (1), Diamantino (1), Peixoto de Azevedo (1)
AL	3	Maceió (1), Pindoba (1), Porto de Pedras (1)
BA	17	Canudos (1), Ibirapuã (4), Jucuruçu (5), Lajedão (3), Miguel Calmon (2), Salvador (1), Saubara (1)
CE	3	Brejo Santo (1), Juazeiro do Norte (1), Mucambo (1)
MA	43	Bacabeira (2), Bela Vista do Maranhão (1), Grajaú (1), Santa Luzia (3), São Bento (1), São Luís (34), São Vicente Ferrer (1)
PB	2	Brejo dos Santos (2)
PE	3	Araripina (1), Cortes (1), Igarassu (1)
PI	3	Barras (1), Nazaria (1), Teresina (1)
RN	2	Canguaretama (1), Ielmo Marinho (1)
SE	1	Barra dos Coqueiros (1)
AM	22	Manaus (1), Manicore (14), Tabatinga (1), Tefé (6)
AP	1	Macapá (1)
TO	1	Darcinópolis (1)
MG	119	Açucena (2), Águas Formosas (8), Cachoeira de Pajeu (1), Carmo do Paranaíba (1), Congonhal (3), Esmeraldas (1), Francisco Badaró (1), Goiabeira (1), Itabira (25), Janaúba (5), Januária (1), Montes Claros (11), Natércia (1), Ouro Fino (1), Pedra Azul (1), Piedade do Rio Grande (1), Pote (2), Santa Fé de Minas (1), Santa Maria de Itabira (2), Santo Antonio do Itambé (1), São Francisco (1), Simão Pereira (3), Teófilo Otoni (41), Timóteo (1), Umburatiba (1)
RJ	9	Cabo Frio (1), Maricá (1), Rio das Ostras (6), São João da Barra (1)
SP	110	Getulina (1), Guapiara (1), Limeira (11), Mococa (1), São Paulo (92), São Vicente (1), Tatuí (1), Ubatuba (2)
PR	4	Paula Freitas (1), Pinhais (1), Rio Azul (2)
RS	105	Aceguá (1), Arroio do Tigre (2), Cachoeira do Sul (8), Canoas (1), Dom Feliciano (1), Doutor Ricardo (1), Erechim (1), Girua (2), Ivoti (1), Passo Fundo (42), Rio Grande (34), Santo Cristo (2), São Luiz Gonzaga (4), Soledade (1), Taquari (1), Três Coroas (1), Vera Cruz (1), Vila Nova do Sul (1)
SC	101	Agrolândia (3), Antonio Carlos (1), Ascurra (3), Brusque (1), Capivari de Baixo (1), Criciúma (41), Doutor Pedrinho (1), Imaruá (1), Itaiópolis (8), Itapema (11), Itapoá (1), Palhoça (23), Riqueza (2), Santa Terezinha do Progresso (1), São Bento do Sul (2), São Miguel do Oeste (1)

Fonte: Os autores (2024) – Elaborada com dados de 2023 extraídos do CNES.

A partir da Tabela 3.1, nota-se que dos 598 estabelecimentos com cadastro no CNES em Práticas Psicodinâmicas, 448 (75%) estão nas regiões Sudeste e Sul, com destaque para os estados de MG, SP, RS e SC. Considerando que há 5.570 municípios no Brasil (Tabela 3.1), tem-se o seu cadastro no CNES, no ano de 2023, para aproximadamente 2,2% deles.

Apesar da existência de subnotificação de cadastros no CNES, em que esforços são necessários para incentivá-los, pode-se notar que há muito ainda a avançar quanto à expansão da TCI para outros municípios do Brasil.

Embora a TCI tenha sido incluída na PNPIC em 2017 (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017), os primeiros cadastros de estabelecimentos no CNES em Práticas Psicodinâmicas ocorreram somente em 2019. Desde então, pode-se notar (Tabela 3.3) que, no decorrer dos anos, ocorreu um aumento no número de estabelecimentos cadastrados, atingindo 598 em 2023.

Tabela 3.3 - Estabelecimentos com registro no CNES em Práticas Psicodinâmicas, 2019 a 2023

Ano	Centro-Oeste	Nordeste	Norte	Sudeste	Sul	Brasil
2019	0	42	6	2	18	68
2020	2	45	6	9	25	87
2021	38	50	8	15	74	185
2022	44	75	23	54	156	352
2023	49	77	24	238	210	598

Fonte: Os autores (2024) – Elaborada com dados extraídos do CNES.

3.3 Cenário de Acordo com o SISAB

A Tabela 3.4 apresenta o total de municípios por ano e região do país que, de acordo com dados do SISAB, realizaram registros de TCI na APS do SUS no período de 2017 a 2024.

Neste período, nota-se a ocorrência de registros da TCI em 1.524 municípios distintos, o que corresponde a 27,4% dos municípios do Brasil com oferta de TCI pelo SUS em um ou mais anos de 2017 a 2024.

Em termos de número de municípios, a região Sudeste apresentou 591 (35,4%) dos seus 1.668 municípios com registro de TCI no período de 2017 a 2024, e a região Centro-Oeste em 158 (33,8%) dos seus 468 municípios.

Tabela 3.4 – Municípios com registro de TCI na APS do SUS por ano e região do Brasil

Região	Total de municípios	Municípios com registro	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Norte	450	109	29	42	39	12	11	18	10	16
Nordeste	1.793	345	96	130	146	37	32	52	45	45
Centro-Oeste	468	158	32	64	56	18	14	25	35	25
Sudeste	1.668	591	143	238	210	79	56	133	184	178
Sul	1.191	321	78	90	120	29	21	55	89	93
Brasil	5.570	1.524	378	564	571	175	134	283	363	357

Fonte: Os autores (2025) – Elaborada com dados extraídos do SISAB.

4

FINANCIAMENTO DA TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA

4.1 Financiamento

Na Atenção Primária à Saúde (APS) não há um financiamento específico para as PICS, mas elas podem compor as ações de cuidado conforme a necessidade e a capacidade do município. Desse modo, para implementá-las, os gestores terão que aportar do modelo orçamentário brasileiro estabelecido pela Constituição Federal de 1988, composto de três instrumentos: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). No âmbito da saúde, os Planos de Saúde (PS), as Programações Anuais de Saúde (PAS) e os Relatórios de Gestão (ReG), são os instrumentos de planejamento e programações locais essenciais para que os gestores estaduais e municipais tenham a garantia de seus financiamentos previstos na peça orçamentária, na sua esfera de governo.

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o financiamento da APS deve ser tripartite, sendo as transferências financeiras federais regulamentadas por normas decorrentes do pacto federativo e alocadas em dois blocos de financiamento: o de Manutenção e o de Investimento, como prevê a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017.

Atualmente, o modelo de financiamento da APS vigente é regido pela Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024, que possui 3 componentes:

- Componente fixo para manutenção de equipes e recurso para implantação de novas equipes: valor mensal fixo por equipe transferido para os

municípios, referente ao número de eSF e eAP homologadas e válidas. O valor do componente fixo por equipe depende da classificação do município pelo Índice de Equidade e Dimensionamento (IED).

- Componente vínculo e acompanhamento territorial: valor mensal por equipe transferido aos municípios referente ao número de eSF e eAP homologadas e válidas. Avaliará critérios demográficos (pessoas menores de 5 anos e maiores de 60 anos) e de vulnerabilidade (beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada - BPC e do Programa Bolsa Família - PBF), completude do cadastro, acompanhamento e atendimento das pessoas vinculadas pelas equipes, satisfação do usuário. O valor do componente de vínculo e acompanhamento considerará a classificação da equipe.
- Componente de qualidade com indicadores de cuidado clínico da equipe e ações no território: valor mensal transferido aos municípios referente ao número de eSF e eAP homologadas e válidas. O valor do componente de qualidade considerará o alcance dos resultados nos indicadores pactuados e a classificação da equipe.

Sendo a PNPIC uma política nacional transversal, as PICS, neste novo modelo de financiamento, podem ser contempladas na Estratégia Saúde da Família (ESF), que orienta o acesso e integralidade do sistema de saúde, o cuidado da saúde da mulher, gestante e puérpera, no desenvolvimento infantil, da pessoa com diabetes, da pessoa com hipertensão e da pessoa idosa. Assim como na composição de profissionais habilitados em PICS nas equipes multiprofissionais, contribuindo no cuidado compartilhado da pessoa acompanhada e nas ações interprofissionais realizadas e, também na resolutividade do cuidado na equipe eMulti.

Importante mencionar que para Média e Alta Complexidade (MAC), somente três procedimentos das PICS possuem financiamento específico pelo Teto MAC (Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade).

O teto MAC é um grupo de financiamento que integra um único bloco de custeio, incluindo o que se destina às ações e serviços ambulatoriais e hospitalares. O Teto MAC é transferido de forma regular e automática aos fundos de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios, conforme o estabelecido pela Portaria de Consolidação MS nº 6, de 28 de setembro de 2017. Os três procedimentos mencionados e seus respectivos códigos SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS) são: Sessão de Acupuntura aplicação de ventosas/moxas (03.09.05.001-4), Sessão de Acupuntura com inserção de agulhas (03.09.05.003-0) e Sessão de eletroestimulação (03.09.05.003-0).

O financiamento da TCI, principalmente na Atenção Primária à Saúde (APS), é importante para que sejam viabilizados a implantação, implementação e manutenção deste serviço na Atenção Básica (AB). Para tanto, os instrumentos de planejamento e programações locais são essenciais para que os gestores estaduais e municipais viabilizem recursos financeiros para a TCI, potencializando sua oferta (ou manutenção), com disponibilidade financeira para a contratação de recursos humanos, formação e capacitação de terapeutas comunitários integrativos, recursos estruturais e insumos, provendo o necessário para a realização dessa prática.

É importante destacar que a prática da TCI não envolve custo elevado para os municípios. Segundo a categorização proposta por Merhy (2002), a TCI é classificada como uma tecnologia leve, que pode ser definida como práticas e ferramentas que valorizam as interações humanas e as relações interpessoais no cuidado em saúde. Esse tipo de tecnologia, concentra-se na comunicação, no vínculo, na escuta ativa, na acolhida e no respeito aos valores e contextos dos pacientes. Além disso, esse tipo de tecnologia é essencial para um atendimento mais humanizado e personalizado, contrastando com as tecnologias leve-duras e duras, que envolvem equipamentos, procedimentos técnicos e protocolos estabelecidos.

Desse modo, o principal investimento para a implantação da TCI concentra-se, essencialmente, na capacitação de recursos humanos, ou seja, nos profissionais que atuarão como Terapeutas Comunitários Integrativos. Os demais materiais necessários consistem em elementos para a realização das rodas, considerados de baixo custo para manutenção mensal (por exemplo: espaço, cadeiras e insumos para a realização das rodas, como lenços de papel, copos, álcool em gel etc.).

De acordo com o que orienta o Manual de Implantação dos Serviços das PICS do Ministério da Saúde (Brasil, 2018), o município pode realizar parcerias para a utilização de espaços e recursos básicos de instituições presentes no território, como, por exemplo, grupos e associações comunitárias, instituições da sociedade civil (ex.: associações, escolas e creches), fundações, espaços de núcleos religiosos, salões e espaços coletivos de fácil acesso para a comunidade, dentre outros. As possibilidades de parcerias, que podem ser avaliadas após o diagnóstico situacional e análise organizacional, têm sido extremamente benéficas, tanto pela facilidade de divulgação quanto pela facilidade de acesso para participação nas rodas pela comunidade.

Além dos instrumentos que compõem o modelo orçamentário brasileiro citados previamente, o financiamento regular das PICS, que inclui a TCI, depende também da atuação do controle social, como as deliberações das conferências de saúde realizadas, incluindo a oferta da TCI como prioridade.

Uma vez aprovada no Plano Municipal de Saúde, através das Conferências de Saúde, a TCI ganha visibilidade e, como política pública municipal, pode permitir planejamento orçamentário, especialmente no que se refere à formação de servidores.

Para facilitar a implantação da TCI no município, é importante destacar o custo-efetividade da TCI, que pode refletir na redução dos internamentos ao permitir um espaço de acolhimento e suporte nos casos de baixa e média complexidade. Além disso, a TCI oferece aos profissionais que atuam na aten-

ção primária um recurso complementar que pode reduzir a medicalização do sofrimento e, em consequência, os custos relacionados à promoção de saúde mental. A seguir, são apresentadas possíveis fontes de financiamento da TCI.

4.2 Possíveis Fontes de Financiamento da TCI

- 1) Recursos Federal, Estadual (fundo a fundo) e Municipal destinados a custeio de ações da Atenção Básica. Podem ser por dois blocos de financiamento: Bloco de Custeio (Piso de Atenção Básica em Saúde) e Bloco de Investimento (destinado à construção e ampliação de UBS, estruturação das Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, sendo que, neste caso, o gestor municipal deverá programar o financiamento da TCI em relação ao montante total de custeio, de acordo com o Plano de Saúde Local, conforme pactuado nos respectivos Conselhos de Saúde. Os recursos federais são transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados e Municípios, conforme a Programação Pactuada e Integrada, publicada em ato normativo específico (Manual de Implantação de Serviços de PICS no SUS do MS);

Link do Manual	https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pics/publicacoes/manual_implantacao_servicos_pics.pdf/view
----------------	---

- 2) Recursos vindos de parcerias com ONGs;
- 3) Recursos advindos de convênios firmados entre o município e instituições privadas de ensino, como o Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino Saúde (COAPES), em que universidades particulares pagam para o município para que os alunos possam realizar estágios nos equipamentos de saúde do SUS. Este recurso financeiro pode ser utilizado para financiar a formação de Terapeutas no município, como os exemplos dos municípios de São Paulo e de Araçatuba;

Link do COAPES	https://www.cosemssp.org.br/downloads/manual-coapes-22-01-2016.pdf
----------------	---

- 4) Recursos do próprio município, quando se dispõe a este financiamento, por entender a importância da TCI para a promoção de saúde dos seus munícipes, além de promover um paradigma complementar, diferente do medicalizante e hospitalocêntrico, que torna o sistema de saúde ainda mais oneroso e sobrecarregado, promovendo a dependência dos usuários com a UBS, não estimulando o autocuidado;
- 5) Recursos de emendas parlamentares. A emenda parlamentar é um dispositivo constitucional que interfere positivamente na lei orçamentária do executivo. Através das emendas parlamentares, os legisladores agem para complementar a lei orçamentária, para que não fique dependente exclusivamente do poder executivo. Um membro do poder legislativo (das 3 esferas de governo) pode acionar as emendas parlamentares, que são um dispositivo legal financeiro, podendo usá-la para implantação, estruturação e manutenção da TCI na APS. Para tanto, é importantes munir-se de fortes argumentos, indicadores, registros que mostrem a importância da TCI e os impactos positivos que são gerados na saúde mental da população usuária do SUS, diminuindo a medicalização, o encaminhamento para especialistas da Atenção Secundária, hospitalizações, incentivando a promoção de saúde e do autocuidado, a criação de vínculos entre os profissionais de saúde e a comunidade, e entre a comunidade em si, atuando no fortalecimento dos princípios do SUS, por incentivo à universalidade, à integralidade das ações, e à equidade, atuando como um importante recurso para desafogar a Atenção Primária;
- 6) Se o município contar com profissionais no seu quadro de funcionários que já são Terapeutas Comunitários, a Gestão poderá liberar carga horária desses profissionais para desenvolverem a prática da TCI aos usuários do SUS;

- 7) O município pode realizar parcerias com o setor privado via licitação/ chamada pública. Para esse fim, o município pode basear-se juridicamente na nova lei de contratos e licitação, a Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, transição da Lei nº 8.666, que traz mais modernidade ao financiamento (Brasil, 2021);

Lei nº 14.133	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
---------------	---

- 8) Financiamento via consórcio intermunicipal para capacitação e formação de Terapeutas Comunitários Integrativos. O Consórcio Intermunicipal representa um tipo de acordo celebrado entre municípios, de caráter diferente do convênio, e previsto na Lei nº 8.080/1990;

Links sobre consórcios intermunicipais	https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4020/6/PPP_n22_Regionalizacao.pdf ⇒ Ribeiro e Costa (2000) . https://cnm.org.br/storage/biblioteca/2023/Cons%C3%B3rcios%20P%C3%ABlicos%20Intermunicipais%20Como%20e%20para%20que%20cooperar_publicada.pdf ⇒ Alvarez e Henrichs (2020).
--	--

- 9) Financiamento do município via recursos da Educação Permanente do SUS;
- 10) Termo de Fomento, que é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros (Brasil, 2021). O município pode basear-se, juridicamente, nas Leis nº 13.019 e 13.204. A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), passou a regulamentar as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, revogando a antiga legislação que tratava da declaração de utilidade pública. A Lei nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015 (Brasil, 2015a), que alterou a Lei nº 13.019, regulamenta as parcerias, com três

dispositivos, sendo um deles o Termo de Fomento, o qual pode auxiliar no financiamento da TCI (Brasil, 2014). Essas leis modernizam e estruturam de forma mais abrangente o relacionamento entre o poder público e as organizações da sociedade civil no Brasil;

Termo de fomento	https://www.gov.br/cnpq/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/parcerias/nacionais-1/termo-de-fomento
Lei nº 13.019	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113019.htm
Lei nº 13.204	https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13204-14-dezembro-2015-782094-publicacaooriginal-148943-pl.html

- 11) Parcerias público-privadas, através de isenção fiscal, tornando a instituição de utilidade pública e, com isso, deve ofertar serviços ao município. Uma entidade privada que trabalhe com a TCI pode receber isenção fiscal e, em contrapartida, pode ofertar a prática da TCI aos usuários do SUS no município. Isso também é regulamentado pelas Leis nº 13.019 e 13.204, já citadas. Uma instituição de utilidade pública é uma organização geralmente sem fins lucrativos, que presta serviços de interesse coletivo ou comunitário e, por isso, recebe reconhecimento formal do Estado. Esse reconhecimento pode conferir à instituição certos benefícios, como isenções fiscais, acesso a subvenções públicas, e facilidades para obter recursos. O objetivo é incentivar e apoiar atividades que promovam o bem-estar social, cultural, educacional, científico, esportivo ou ambiental.

O reconhecimento de utilidade pública pode ser concedido a associações, fundações ou organizações não governamentais (ONGs) que demonstrem cumprir critérios específicos, que podem variar conforme a legislação do país ou região. Em geral, esses critérios incluem: atuação por um período mínimo, transparência na gestão, e realização de atividades que beneficiem a sociedade de maneira significativa;

- 12) Fundos privados destinados a patrocinar áreas sociais, de caráter social, esportivo, cultural, defesa e proteção da pessoa humana, saúde etc.;
- 13) Ação em conjunto com a ABRATECOM, com mobilização social organizada, promovendo o controle social/participação social, exigindo mudanças nas formas de financiamento em saúde nas três esferas do governo.

É oportuno lembrar que o financiamento está atrelado à qualidade dos registros realizados nos sistemas de informação, bem como à não subnotificação dos mesmos; isso porque os registros são essenciais para mostrar a atuação das PICS, incluindo a TCI, o que pode auxiliar na argumentação e justificativas para solicitação de financiamentos e aumento de recursos destinados a essas práticas.

5

REGISTRO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

5.1 Importância do Registro

O registro nos sistemas de informação em saúde (SIS) das atividades realizadas com a Terapia Comunitária Integrativa (TCI) na Atenção Primária do SUS é de extrema importância, pois alimenta o banco de dados nacional do Ministério da Saúde (MS), viabilizando a consulta, pelos gestores e público em geral, de informações sobre a TCI ao longo do tempo em todo o Brasil.

Com base nas informações extraídas dos registros, pode-se dar visibilidade, por exemplo, às atividades que são realizadas na Atenção Primária à Saúde (APS), à abrangência de usuários que se beneficiam desse recurso terapêutico, aos benefícios promovidos na comunidade, à expansão de rodas realizadas e aos profissionais que estão ofertando a TCI. Pode-se também conhecer o número de municípios e o de UBS que ofertam a TCI.

Ademais, as informações decorrentes dos registros viabilizam a construção de indicadores de monitoramento e avaliação da TCI, o que possibilita a promoção de debates para que se possa melhorar sempre a atuação desta prática na APS, bem como a realização de pesquisas a respeito da TCI em nível nacional, estadual e municipal.

5.2 Onde Realizar o Registro da TCI

Os profissionais de saúde devem realizar o registro da TCI nos sistemas e-SUS Atenção Primária à Saúde (e-SUS APS), composto por sistemas de

softwares que instrumentalizam a coleta dos dados que serão inseridos no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). São eles: 1) Coleta de Dados Simplificado (CDS), 2) Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e 3) Aplicativos (App) para dispositivos móveis, como o e-SUS Território e Atividade Coletiva.

Os sistemas e-SUS APS foram desenvolvidos para atender os processos de trabalho da Atenção Primária para a gestão do cuidado em saúde, podendo ser utilizados por profissionais de todas as equipes e unidades da APS, Atenção Domiciliar (AD), além dos profissionais que realizam ações no âmbito de programas como o Saúde na Escola (PSE) e a Academia da Saúde.

Quanto ao SISAB, foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, passando a ser o sistema de informação da Atenção Básica vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica, substituindo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).

O SISAB integra a estratégia do Departamento de Saúde da Família (DESF/SAPS/MS), denominada e-SUS APS, que propõe o incremento da gestão da informação, a automação dos processos, a melhoria das condições de infraestrutura e a melhoria dos processos de trabalho. Com o SISAB é possível obter informações da situação sanitária e de saúde da população do território por meio de relatórios de saúde, bem como de relatórios de indicadores de saúde por estado, município, região de saúde e equipe.

Assim, a razão pela qual o registro da TCI (e o de outras PICS) deve ser realizado no e-SUS APS, é promover um banco de dados robusto e, para isso, os sistemas precisam comunicar-se entre si. Sistemas que não exportam informações ao MS, deixam o banco de dados nacional deficiente de registros, ou seja, subnotificado. Em consequência, há prejuízos para a TCI quanto à sua visibilidade, assim como quanto ao monitoramento e planejamento da

PNPIC como um todo, o que pode dificultar o pleitear de recursos financeiros e de políticas públicas, que ajudam a impulsionar a TCI pelo país.

5.3 Incentivo para a Realização do Registro da TCI

Os municípios, por intermédio de sua gestão e dos coordenadores de PICS da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), devem incentivar continuamente o registro da TCI de forma correta e completa pelos profissionais de saúde envolvidos com a TCI.

5.4 Quem pode Realizar o Registro da TCI

O Terapeuta Comunitário não consta na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) como ocupação profissional. Assim, para que profissionais vinculados ao quadro de funcionários do SUS, com capacitação em TCI, possam realizar o registro de suas rodas nos sistemas de informação em saúde do SUS, é necessário que eles sejam cadastrados no sistema CNES e que seus respectivos CBOs estejam habilitados para a prática da TCI. Profissionais com CBOs não habilitados não estarão aptos a realizar o registro de suas rodas.

A lista dos CBOs habilitados está disponível no Quadro A.1 (Anexo A), assim como no link a seguir.

<http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0101050020/01/2025>

Em alguns municípios, as rodas de TCI realizadas por profissionais voluntários também podem ser registradas nos sistemas de informação em saúde do SUS. Para tanto, os terapeutas comunitários que realizam rodas de TCI em caráter voluntário, devem ser cadastrados no Sistema CNES e, similar aos profissionais do SUS, seus CBOs devem constar da lista dos habilitados para a prática da TCI. No processo de cadastro dos voluntários no Sistema CNES, a opção “voluntário” deve ser selecionada para o tipo de vínculo desses profissionais com o equipamento de saúde.

A Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, dispõe sobre o serviço voluntário. Links para mais informações são fornecidos a seguir.

Sobre a CBO	https://empregabrasil.mte.gov.br/76/cbo/
Sobre o CNES	https://cnes.datasus.gov.br/ https://cnes.datasus.gov.br/pages/downloads/documentacao.jsp http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf
Passo a passo da Prefeitura de São Paulo	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Passo%20a%20passo%20SCNES.pdf
Lei nº 9.608/1998 sobre o serviço voluntário	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19608.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.608%2C%20DE%2018%20DE%20FEVEREIRO%20DE%201998&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20servi%C3%A7o%20volunt%C3%A1rio,Art.

5.5 Como Proceder o Registro da TCI

5.5.1 Passos Iniciais: Registro no CNES

O primeiro passo é verificar se o estabelecimento de saúde que irá ofertar a TCI está cadastrado no Sistema CNES. Se não estiver, deve-se cadastrá-lo. Após concretizar este passo, o segundo passo é o Gestor cadastrar o serviço de TCI no CNES, de acordo com as orientações a seguir.

- Acessar o CNES.
- Acessar o estabelecimento de saúde em que será realizada a prática da TCI.
- No módulo conjunto e na aba “SERVIÇOS ESPECIALIZADOS” incluir o serviço de Práticas Integrativas e Complementares com o código “Serviço 134”.
- Selecionar a classificação correspondente à TCI, que é “PRÁTICAS PSICODINÂMICAS”, código 012.
- Selecionar a opção “CADASTRO-PROFISSIONAIS” e cadastrar os profissionais que realizarão a TCI, segundo suas respectivas CBOs (Classificação Brasileira de Ocupações).

Se o profissional que for realizar a TCI for voluntário, deve-se alterar o tipo de vínculo com a instituição para “trabalho voluntário”. O cadastro é pos-

sível somente para os profissionais voluntários com ocupação que constem na lista dos CBOs habilitados para a prática de TCI (Quadro A.1, Anexo A).

5.5.2 Registro da TCI no e-SUS APS

Uma informação importante para a realização do registro é o código do procedimento atribuído à TCI no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS), que, como pode ser visto na Figura 5.1, é 01.01.05.002-0, com os dígitos, da esquerda para a direita, correspondendo ao grupo, subgrupo, forma de organização, número do procedimento dentro da forma de organização e dígito de controle.

Figura 5.1 – Código do procedimento atribuído à TCI no SIGTAP

■ Procedimento

Procedimento: 01.01.05.002-0 - TERAPIA COMUNITÁRIA

Grupo: 01 - Ações de promoção e prevenção em saúde

Sub-Grupo: 01 - Ações coletivas/individuais em saúde

Forma de Organização: 05 - Práticas integrativas/complementares

Competência: 01/2025

 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia Atenção Domiciliar

Complexidade: Atenção Básica

Financiamento: Atenção Básica (PAB)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 0,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 0,00

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

Descrição	CID	CBO	Leito	Serviço Classificação	Habilitação	Redes	Origem	Regra Condicionada	Renases	TUSS
Descrição PRÁTICA TERAPÊUTICA COLETIVA QUE ENVOLVE OS MEMBROS DA COMUNIDADE NUMA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE REDES SOCIAIS SOLIDARIAS PARA A PROMOÇÃO DA VIDA E MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS E COMPETÊNCIAS DOS INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS E COMUNIDADES.										

Fonte: SIGTAP (2024).

É oportuno mencionar que a Portaria nº 145, de 11 de janeiro de 2017, alterou o código do procedimento da TCI no SIGTAP de 01.01.01.005-2 para 01.01.05.002-0. Ademais, a Portaria SAES/MS nº 2.326, de 06 dezembro de 2024, incluiu novos procedimentos de telessaúde na tabela SIGTAP do SUS. Um deles, o Teleatendimento em Grupo (código 08.04.02.005-1), contemplou a Terapia Comunitária Integrativa (TCI) no formato telepresencial.

O registro da TCI no e-SUS APS pode ser realizado de duas formas:

- 1) Por meio das Fichas de Coletas de Dados Simplificada (CDS), ou
- 2) Pelo Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

Na primeira forma de registro da TCI, as fichas de CDS eletrônicas utilizadas para preenchimento são as descritas no Quadro 5.1.

Quadro 5.1 – Fichas de CDS e respectivas orientações para preenchimento das mesmas

Fichas de CDS	Orientação
Ficha de atendimento individual	Podem ser registradas por profissionais de nível superior. Para registro da TCI deve ser preenchido o campo RACIONALIDADE EM SAÚDE; marcar a opção OUTRA.
Ficha de procedimentos	Para registrar a roda ou grupo de TCI (ou qualquer outro procedimento PICS) procurar a aba “Outros procedimentos” e selecionar o código SIGTAP da TCI (01.01.05.002-0).
Ficha de atendimento odontológico individual	Utilizada apenas pelos profissionais cirurgião dentista, técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde bucal, quando este acompanha o atendimento. Para registrar a roda ou grupo de TCI (ou qualquer outro procedimento PICS) procurar a aba “Outros procedimentos” e selecionar o código SIGTAP da TCI (01.01.05.002-0). Se for o caso, selecionar também o código de outro procedimento PICS realizado.
Ficha de atividade coletiva	Na aba PRÁTICAS EM SAÚDE, selecionar a opção 14 OUTRO PROCEDIMENTO COLETIVO e, a seguir, selecionar o código SIGTAP da TCI (01.01.05.002-0).

Fonte: Os autores (2024).

Quanto ao registro no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), em que modelo é mostrado na Figura 5.2, orientações são descritas a seguir.

Na aba SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano – Acrônimo utilizado em um Prontuário Orientado por Problemas e Evidências), descrever a atividade realizada. Ao finalizar o descritivo da atividade realizada, seguir para a aba “FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO” para registro dos procedimentos na aba PROCEDIMENTO. No caso da TCI, utilizar o código SIGTAP apresentado previamente. Também preencher a aba RACIONALIDADE EM SAÚDE, selecionando “OUTRA”.

Figura 5.2 - Modelo do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)

The screenshot displays the PEC interface for a 44-year-old male patient. The left sidebar contains navigation icons for FOLHA DE ROSTO, SOAP, PROBLEMAS/CONDIÇÕES E ALERGIAS, ACOMPANHAMENTO, ANTECEDENTES, HISTÓRICO, DADOS CADASTRAIS, FICHAS CDS, and FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO. The main area is divided into several sections:

- Finalizar** (top right)
- 44 anos e 5 meses e 29 dias, masculino** (patient info)
- SOAP** (selected tab)
- Procedimentos realizados** (Procedimento, CID10 principal, Confirmar)
- Procedimento** (Procedimento, CID10 principal, Confirmar)
- Procedimentos inseridos automaticamente** (Procedimento, CID10 principal, Confirmar)
- Lista de CID10 inseridos na avaliação** (Código, Descrição)
- Racionalidade em saúde (Exclua alopática / convencional)** (01 - MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, 02 - ANTROPOSOPIA APLICADA À SAÚDE, 03 - HOMEOPATIA, 04 - FITOTERAPIA, 05 - AYURVEDA, 06 - OUTRA)
- Descrição do atendimento** (Liberação cidadã, Retorno à cidade, Agendar consulta)
- Declaração de Comprometimento** (Declaração de Comprometimento)
- Cancelar atendimento** and **Finalizar atendimento** (bottom buttons)

Fonte: Ministério da Saúde. Prontuário Eletrônico do Cidadão (2024).

Recomenda-se preencher os prontuários individuais de cada participante das rodas. Embora isso seja trabalhoso, é importante que seja feito, pois a partir do dado clínico do procedimento, pode-se pesquisar nos prontuários de cada usuário a quantidade de rodas de TCI as quais ele participou em um período de tempo, e quais outras PICS vem utilizando.

Adotar estratégias que facilitem e incentivem o registro correto são necessárias para garantir que todas as informações sejam inseridas no prontuário individual de todos que participaram das rodas. Nesse sentido, recomenda-se que sejam convidadas pessoas da própria Secretaria da Saúde de outros municípios ou estados, com experiência nos registros, para realização de capacitação aos terapeutas comunitários.

Para informações adicionais, consulte os links fornecidos a seguir.

Registrando as PICS no e-SUS AB	https://www.youtube.com/watch?v=NRc4iV22rsk&t=3s
Em busca de um SUS Eletrônico	https://sisaps.saude.gov.br/esus/
Manual de implantação de serviços PICS no SUS	https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pics/publicacoes/manual_implantacao_servicos_pics.pdf/view

5.5.3 Registro da TCI em Sistemas de Informação Próprios

Alguns municípios utilizam sistemas de informação próprios, que apresentem características próprias. Para o registro da TCI nesses sistemas, é importante verificar com o setor de tecnologia da informação dos mesmos a melhor forma de registro, com o maior número de informações possível.

A forma ideal é o registro da TCI como prática coletiva, abrangendo informações sobre o número de rodas realizadas, número de participantes em cada roda, formato de cada roda (se presencial ou on-line), número de profissionais envolvidos, dentre outros, possibilitando também alimentar o prontuário individual de cada participante para que se saiba de quantas rodas ele participou ao longo do tempo.

É imprescindível que os sistemas próprios exportem todas as informações para o sistema e-SUS APS, alimentando o banco de dados nacional do MS sobre a prática da TCI. Ter esse banco de dados atualizado permite a obtenção de informações o mais próximo possível da realidade a respeito da TCI em nível nacional, estadual e municipal, viabilizando o seu monitoramento e avaliação por meio de indicadores e auxiliando o planejamento da PNPIC como um todo.

Os dados de sistemas próprios podem ser exportados utilizando a tecnologia de transporte apache THRIFT. Todos os registros realizados por meio desse transporte, seguindo as regras apresentadas nos modelos de informação do e-SUS, são recebidos pelo Centralizador Nacional e disponibilizados conforme as Regras de Validação. O link de acesso ao manual de exportação de dados é fornecido a seguir.

Manual de exportação de dados	http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/ManualExportacao_e-SUS-AB-v2.0.pdf
-------------------------------	---

5.5.4 Registro de Procedimentos de Telessaúde no e-SUS APS

A Telessaúde consiste na utilização de tecnologias de comunicação para prestar serviços de saúde à distância. Recentemente, a Portaria SAES/MS nº 2.326, de 6 de dezembro de 2024, incluiu novos procedimentos de telessaúde na Tabela SIGTAP. Um deles, o Teleatendimento em Grupo (que recebeu o código 08.04.02.005-1), possibilita o registro de forma padronizada no e-SUS APS de várias ações em grupo já realizadas pelos profissionais no formato telepresencial, como, por exemplo, a TCI no formato on-line.

Segundo o MS, a portaria visa organizar e qualificar o monitoramento das ações de telessaúde, proporcionando informações mais precisas que orientarão decisões estratégicas no âmbito do SUS (Ministério da Saúde, 2025).

Com a inclusão dos procedimentos, as ações de telessaúde já realizadas pelos profissionais passam a ser registradas de forma padronizada, o que repre-

sentam um marco no reconhecimento e valorização dos profissionais que atuam na telessaúde. Esses profissionais agora poderão informar os procedimentos corretamente, aplicando os novos códigos nos sistemas de informação, garantindo o registro oficial de suas atividades. Isso não apenas facilita a avaliação do trabalho realizado, como também assegura maior valorização desses profissionais (Ministério da Saúde, 2025).

Para informações adicionais, acesse os links a seguir.

Portaria SAES/MS nº 2.326 de 2024	https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-saes/ms-n-2.326-de-6-de-dezembro-de-2024-601712939
SUS Digital	https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/meususdigital
Notícias do Ministério da Saúde	https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/ministerio-da-saude-padroniza-as-diversas-modalidades-de-teleatendimento

5.5.5 Sub e Super-registros

Os registros são de fundamental importância para mostrar a realidade em que se encontra a oferta de serviços, como as rodas de TCI, o impacto que isso causou no enfrentamento à saúde mental do município, e a produção realizada em um período de tempo. Com base nas informações geradas pelos registros, pode-se realizar uma boa avaliação, monitoramento e planejamento de ações, além de orientar os gestores sobre a importância de investir na implantação e implementação da TCI no SUS.

Contudo, a falta de registros (sub-registro/subnotificação), ou o registro além da realidade (super-registro), atrapalham a avaliação da evolução da TCI, e das PICS em geral, pois não mostram a realidade e o impacto positivo causado na saúde pública.

O super-registro pode resultar da dificuldade encontrada por alguns terapeutas comunitários ao realizar o registro da TCI. Por exemplo, uma roda

realizada para 10 participantes, acaba, às vezes, sendo registrada como se tivessem ocorrido 10 rodas.

Ademais, o registro da TCI nos sistemas de informação deveria ser sempre realizado em atendimento coletivo, visto tratar-se de uma prática coletiva; contudo, há profissionais de saúde realizando esse registro em atendimento individual. Quando o registro se dá desta forma, os usuários são registrados individualmente, não sendo possível saber quantas rodas de TCI foram realizadas. Já quando o registro se dá em atendimento coletivo, para cada roda de TCI registrada, pode-se realizar o registro individual dos seus participantes. Desse modo, pode-se saber quantas rodas foram realizadas, bem como o total de participações nas mesmas. Para efetuar o registro de um participante em uma roda de TCI, é necessário que ele esteja cadastrado no SUS.

Considerando essa dificuldade, recomenda-se que os terapeutas comunitários recém-formados sejam supervisionados por um tutor, pelo menos até se sentirem familiarizados com o processo de registro da TCI (presencial e telepresencial) nos sistemas de informação, auxiliando, assim, no fortalecimento e sustentabilidade da rede de terapeutas comunitários do município.

6

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA TCI

6.1 Importância do Registro

Os indicadores constituem parâmetros quantitativos ou qualitativos utilizados, em geral, para mensurar o alcance dos objetivos, metas e resultados de um processo de intervenção. Segundo Minayo (2009), são uma espécie de sinalizadores da realidade.

A seleção de indicadores deve ser uma atividade baseada na capacidade que os mesmos terão para fornecer informações que sejam relevantes, consistentes, objetivas e atualizadas.

Para que um indicador cumpra sua função, precisa apresentar algumas propriedades (Brasil, 2010; Jannuzzi, 2012). Dentre elas:

- Validade: Capacidade de representar a realidade;
- Confiabilidade: Qualidade em relação aos dados;
- Simplicidade: Fácil entendimento, comunicação, construção e manutenção;
- Sensibilidade: Capaz de refletir as mudanças decorrentes da intervenção;
- Temporalidade: Permitir o acompanhamento ao longo do tempo;
- Factibilidade: Os dados devem ser possíveis de serem obtidos.

Para eleger indicadores é fundamental que se tenha uma concepção precisa da ação ou processo que se quer gerenciar ou transformar, o que pode apresentar diferentes níveis de facilidade ou complexidade. Assim, os vários tipos de indicadores existem para que seja possível efetuar adequações nos

objetivos, nas metas e até na missão de uma ação ou processo. Os indicadores assinalam tendências. Assim, nenhum indicador pode aportar certeza absoluta quanto aos resultados de uma ação ou de um processo, pois sua função é apenas ser um sinalizador (Minayo, 2009).

No que concerne aos indicadores de saúde, o FortesPICS – Fortalecimento da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde nos Estados – é um projeto de apoio institucional, inicialmente demandado pelo Ministério da Saúde, que está sob gestão do ObservaPICS/Fundação Oswaldo Cruz. Os indicadores de PICS, discutidos em oficina realizada em novembro de 2023, foram pactuados entre este grupo e os estados ali presentes. O monitoramento destes indicadores é de grande importância e é de responsabilidade do ObservaPICS e estados.

Os quatro indicadores pactuados foram: 1) Serviços de Saúde com pelo menos uma oferta de PICS; 2) Atendimentos em PICS na APS do SUS; 3) Atendimentos em PICS na Atenção Especializada do SUS; e 4) Modalidades de PICS ofertadas na APS.

Tais indicadores não podem ser considerados como pactuados pelo Ministério da Saúde (MS) devido à falta de discussão e análise das áreas técnicas envolvidas no processo de construção de indicadores de saúde.

O MS recomenda o indicador utilizado no Plano Nacional de Saúde (PNS) 2024-2027 (Brasil, 2023), mostrado na Figura 6.1, o qual é um marco para a PNPIC, pois nesses 18 anos de história, é a primeira vez que se tem um indicador oficial de PICS pactuado e presente no PNS.

Figura 6.1 – Indicador oficial de PICS presente no Plano Nacional de Saúde 2024-2027

Nº	Meta	Indicador	Índice de Referência (mês/ano)	Previsão 2024-2027
13	Ampliar o registro da oferta de procedimentos de PICS na Atenção Primária à Saúde (APS) para cada mil habitantes cadastrados na APS no período de 12 meses.	Quantidade de procedimentos de PICS registrados no SISAB para cada mil habitantes cadastrados na APS.	11 (dez/2022)	28

Fonte: Plano Nacional de Saúde (PNS) 2024-2027.

Ao eleger um indicador, é usual a elaboração de sua ficha de qualificação, com a finalidade de fornecer informações e orientações. Dentre elas: nome e descrição do indicador, intervenção a qual o indicador se refere, a meta que se deseja alcançar em um determinado período, o método e a periodicidade do cálculo e a fonte pela produção dos dados para o cálculo do indicador.

Modelos de fichas de qualificação podem ser encontrados, dentre outros, em documentos da Rede Interagencial de Informação para a Saúde (RIPSA, 2008), do Ministério da Saúde (Brasil, 2015b), e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG, 2023).

No que diz respeito à TCI, os indicadores de monitoramento e avaliação são essenciais para mensurar o seu progresso, desempenho e impacto.

6.2 Indicadores de Monitoramento da TCI

Quanto ao propósito, foco e periodicidade dos indicadores de monitoramento da TCI, são definidos como segue:

- Propósito: Acompanhar o progresso e o desempenho da TCI ao longo de um intervalo de tempo.
- Foco: Verificar se o desenvolvimento de sua implementação está de acordo com os objetivos e metas inicialmente planejados. Por exemplo: o número de rodas ofertadas, a formação de terapeutas comunitários e a alocação de recursos.
- Periodicidade: São medidos regularmente e em intervalos frequentes.

Alguns indicadores sugeridos para o monitoramento da TCI são:

- 1) Rodas de TCI na Comunidade: Monitorar o número de rodas ao longo de um intervalo de tempo.
- 2) Participação Comunitária: Monitorar o total (ou o número médio) de participantes (usuários) das rodas de TCI em um intervalo de tempo.

- 3) Estabelecimentos: Monitorar o número (ou percentual) de estabelecimentos com cadastro na prática de TCI em um intervalo de tempo.
- 4) Participação Contínua: Monitorar a taxa de participação contínua dos membros da comunidade nas rodas de TCI em um intervalo de tempo.
- 5) Capacitação de Profissionais (Terapeutas Comunitários): Monitorar o número (ou percentual) de profissionais capacitados em TCI ao longo de um intervalo de tempo.

Reforça-se a importância do registro completo e sistemático das rodas de TCI e dos participantes das rodas nos sistemas de informação em saúde (abordado no Capítulo 5), a fim de que os indicadores atendam às propriedades citadas anteriormente.

6.3 Indicadores de Avaliação da TCI

A escolha de indicadores para avaliação deve ser feita em função dos aspectos que se deseja analisar. Por exemplo, medir ou acompanhar a eficiência, a eficácia, a efetividade ou o seu impacto em determinado período. Eficiência diz respeito à boa utilização de recursos financeiros, materiais e humanos em relação às atividades e resultados alcançados. Eficácia refere-se à relação entre as ações realizadas e os resultados obtidos. Efetividade é a observação da incorporação das mudanças geradas pela prática na realidade da população-alvo. O impacto corresponde ao poder de influência e de irradiação de um projeto realizado (Minayo, 2009).

No caso da TCI, os indicadores de avaliação devem resultar do processo de diálogo entre todos os atores (usuários das rodas de TCI, terapeutas comunitários integrativos, dentre outros). Além disso, alguns indicadores, como os de impacto, podem mostrar seu sentido somente em investigações de longo prazo.

De modo geral, o propósito, foco e periodicidade dos indicadores de avaliação dos resultados e impactos da TCI podem ser descritos como:

- Propósito: Mensurar o impacto, a eficácia e a efetividade da TCI em relação aos seus objetivos e resultados finais.
- Foco: Concentram-se nos resultados alcançados e no impacto da TCI sobre os beneficiários ou a comunidade.
- Periodicidade: São medidos em momentos específicos. Por exemplo: após o término da roda de TCI; ou na primeira roda e roda realizada após um período de tempo, para usuários com frequência contínua nas rodas de TCI.

Dentre os vários aspectos associados à TCI os quais pode haver interesse em avaliar com base em indicadores de avaliação, podem ser citados:

- 1) Grau de Satisfação dos Participantes: Realizar pesquisas de satisfação com os usuários da TCI para avaliar o grau de satisfação dos mesmos com a TCI. Por exemplo, quanto à qualidade das rodas, utilidade das estratégias aprendidas e impacto percebido na vida cotidiana.
- 2) Impacto na Saúde Mental: Mensurar mudanças nos indicadores de saúde mental, como redução do estresse, melhoria do bem-estar emocional e aumento da resiliência entre os usuários da TCI.

Mas, como construir indicadores para mensurar características que envolvem conceitos subjetivos, como é o caso da *satisfação do usuário* e do *impacto na saúde mental dos usuários*?

Uma possibilidade é a construção de indicadores qualitativos por estratégias quantitativas, que consiste na construção de escalas que buscam mensurar opiniões, atitudes e comportamentos (Minayo, 2009).

Assim, para avaliar o grau de satisfação dos usuários em relação à TCI, pode-se adaptar escalas já existentes, ou construir e validar uma escala para essa finalidade, com questões (itens) elaboradas, por exemplo, com base na escala

Likert. Do mesmo modo, para mensurar o impacto na saúde mental, pode-se utilizar as escalas de bem-estar psicológico (Ryff, 1989) e de resiliência (Smith *et al.*, 2008), dentre outras. O estudo de Reis *et al.* (2025) ilustra o uso de cinco escalas para essa finalidade. Mais informações sobre esse tipo de indicador qualitativo podem ser encontradas em Williams (1994) e Minayo (2009), dentre outros.

Outra possibilidade, é a construção de indicadores qualitativos por estratégias qualitativas, que expressam a voz, os sentimentos, os pensamentos e as práticas dos diversos atores que compõem o universo da TCI.

Segundo Minayo (2009), as técnicas mais comuns para construção desse tipo de indicadores qualitativos são: Grupos Focais, Delphi e Grupos Nominais. Esses indicadores são construídos com os próprios atores que fazem parte do estudo avaliativo e, a não ser em casos culturais mais ou menos homogêneos, não podem e não devem ser replicados.

Em suma, a construção de indicadores para avaliar a eficácia, a efetividade e o impacto da TCI em relação aos seus objetivos e resultados finais é de extrema importância, pois podem desempenhar um papel muito importante no planejamento e operacionalização da TCI nos serviços de saúde, inclusive no que diz respeito à sensibilização de gestores no investimento e ampliação dessa prática.

6.4 Monitoramento da TCI

Três indicadores de monitoramento da TCI são apresentados nas seções 6.4.1 a 6.4.3. Os resultados, exibidos em tabelas e gráficos, foram obtidos a partir de dados de relatórios públicos gerados nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), em particular no SISAB e CNES.

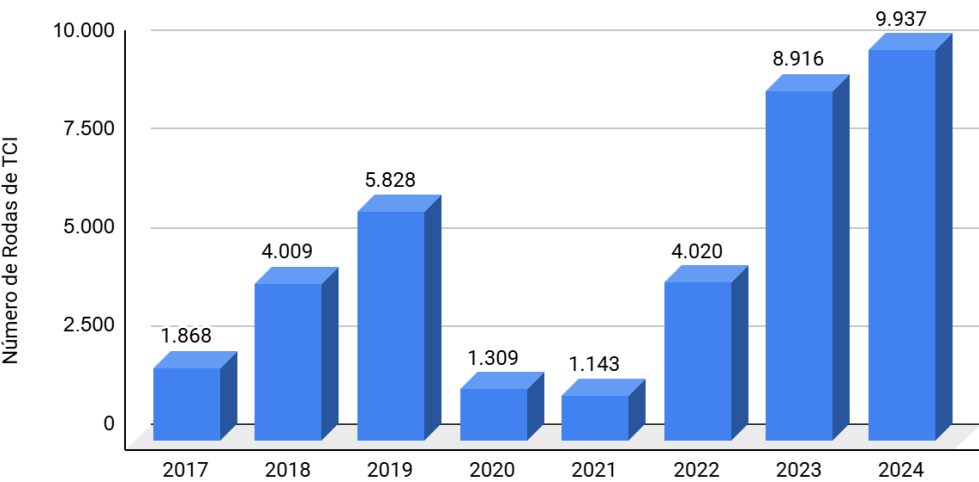
Detalhes de como gerar esses relatórios são apresentados na Seção 6.5.

6.4.1 Indicador 1: Número de Rodas de TCI na APS

Ficha de Qualificação do Indicador 1	
Indicador 1	Número de rodas de TCI na APS
Descrição	Apresenta o número de rodas de TCI registradas na APS do SUS
Periodicidade	Anual, ao fim do ano
Cálculo	Somatório das rodas registradas em Atividades Coletivas no e-SUS APS
Fonte	SISAB / DATASUS

A Figura 6.2 mostra o número de rodas de TCI registradas por ano na APS do SUS, no período de 2017 a 2024. Nota-se que o crescimento desse número foi interrompido nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19, com o crescimento sendo retomado em 2022.

Figura 6.2 – Rodas de TCI registradas na APS do SUS no período de 2017 a 2024



Fonte: Os autores (2024) – Elaborado com dados gerados no SISAB.

A Tabela 6.1 mostra o resultado do Indicador 1 por ano e Unidade da Federação (UF) do Brasil. É oportuno observar que há profissionais de saúde que efetuam os registros da TCI em Atendimentos Individuais, o que, nesses casos, permite o registro somente dos usuários, mas não o das rodas.

Desse modo, o Indicador 1 foi obtido com os registros efetuados em Atendimentos Coletivos. Assim, e devido também à subnotificação de registros, os números para esse indicador são superiores aos apresentados.

Tabela 6.1 – Número de Rodas de TCI por ano e Unidade da Federação de 2017 a 2024

UF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
AC	3	2	7	0	0	4	1	4	21
AL	4	3	15	2	6	0	1	1	32
AP	2	1	2	0	0	1	0	0	6
AM	4	9	20	4	0	2	14	8	61
BA	29	51	156	35	19	42	28	13	373
CE	15	38	50	39	19	56	82	78	377
DF	7	212	520	143	43	346	566	854	2.691
ES	2	4	9	0	0	7	13	9	44
GO	35	70	168	18	7	10	45	35	388
MA	6	6	3	0	0	0	16	40	71
MT	159	105	134	88	3	94	54	262	899
MS	10	198	113	6	17	21	160	69	594
MG	510	1.126	1.447	319	268	1.271	1.733	1.867	8.541
PA	2	22	25	28	12	64	24	26	203
PB	9	34	83	26	6	16	33	6	213
PR	74	106	185	17	3	206	371	352	1.314
PE	85	144	293	21	78	184	114	230	1.149
PI	21	53	59	3	4	5	2	3	150
RJ	10	133	369	124	298	464	590	452	2.440
RN	33	24	42	2	4	10	36	44	195
RS	270	428	616	61	42	339	747	694	3.197
RO	18	13	81	1	6	1	0	2	122
RR	2	0	8	0	0	0	1	1	12
SC	184	150	343	62	61	71	103	85	1.059
SP	286	948	953	279	242	801	4.181	4.797	12.487
SE	20	26	17	9	1	2	0	1	76
TO	68	103	110	22	4	3	1	4	315
Brasil	1.868	4.009	5.828	1.309	1.143	4.020	8.916	9.937	37.030

Fonte: Os autores (2024) – Elaborada a partir de dados gerados no SISAB.

A partir da Tabela 6.1, nota-se a presença de rodas de TCI em todas as UF, mesmo que em pequena quantidade para algumas delas.

Do total de 37.030 rodas de TCI registradas no Brasil, destacam-se as regiões Sudeste e Sul com 23.512 e 5.570 rodas, respectivamente. Nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, foram registradas 4.572, 2.636 e 740 rodas, respectivamente. Vale observar que, até 2024, não havia a opção de informar o formato de oferta da roda de TCI (se presencial ou telepresencial).

De modo geral, as informações produzidas pelo Indicador 1 podem auxiliar na definição de metas para os próximos anos em relação, por exemplo, à oferta de rodas e à necessidade de capacitação de Terapeutas Comunitários Integrativos, dentre outros.

6.4.2 Indicador 2: Número de Atendimentos nas Rodas de TCI na APS

Ficha de Qualificação do Indicador 2	
Indicador 2	Número de atendimentos (usuários) nas rodas de TCI na APS
Periodicidade	Anual, ao fim do ano
Cálculo	Somatório dos usuários registrados em Atendimentos Individuais e dos participantes registrados em Atendimentos Coletivos nas rodas de TCI
Fonte	SISAB / DATASUS

Embora a TCI seja uma atividade coletiva, devendo ser registrada em Atendimentos Coletivos, ainda ocorrem registros indevidos em Atendimentos Individuais. Nesses casos, os profissionais de saúde registram individualmente os participantes das rodas, mas não as rodas, de modo que os dados desses registros correspondem ao número de usuários. Quanto aos registros realizados em Atendimentos Coletivos, os dados extraídos do SISAB fornecem tanto o número de rodas de TCI quanto o de participantes.

Assim, para a obtenção do Indicador 2, foi somado o total de usuários registrados em Atendimentos Individuais com o total de usuários (participantes) registrados em Atendimentos Coletivos (Tabela 6.2).

Tabela 6.2 - Usuários em Atendimentos Individuais (AI) e em Atendimentos Coletivos (AC)

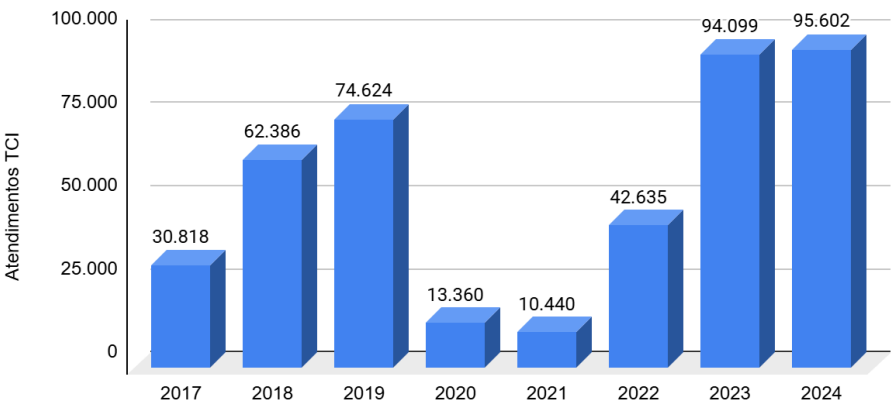
Atendimentos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
AI	5.995	11.890	4.310	219	909	1.362	2.224	3.877	30.786
AC	24.823	50.496	70.314	13.141	9.531	41.273	91.875	91.725	393.178
Total	30.818	62.386	74.624	13.360	10.440	42.635	94.099	95.602	423.964

Fonte: Os autores (2024) – Elaborada a partir de dados gerados no SISAB.

A Tabela 6.2 mostra que o número de registros em Atendimentos Individuais diminuiu, comparado com 2018, o que pode ser devido à qualificação dos preenchimentos dos formulários, no qual o profissional opta corretamente pelo registro em Atendimentos Coletivos.

Em âmbito nacional, nota-se, ainda, um crescimento no número de atendimentos em TCI (isto é, de participantes) de 2017 a 2024 (Figura 6.3), com um total de 423.964 atendimentos realizados no período. O decréscimo para os anos de 2020 e 2021 foi decorrente da pandemia de Covid-19.

Figura 6.3 – Participação nas rodas de TCI no período de 2017 a 2024



Fonte: Os autores (2024) – Elaborada com dados gerados no SISAB.

A Tabela 6.3 apresenta o Indicador 2 por ano e Unidade da Federação. Nota-se a presença de usuários da TCI em todas as UF, com destaque para Minas Gerais, com 110.035 participações, e São Paulo, com 107.601.

Tabela 6.3 – Participação nas rodas de TCI por ano e Unidade da Federação, 2017 a 2024

UF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
AC	23	26	72	0	0	23	1	166	311
AL	128	61	208	13	78	5	9	1	503
AP	192	12	2	0	0	86	0	0	292
AM	92	432	243	33	30	40	273	81	1.224
BA	558	1.321	2.827	585	374	685	437	215	7.002
CE	613	516	752	377	598	643	929	1.077	5.505
DF	114	2.523	5.398	1.299	457	2.854	5.977	9.014	27.636
ES	42	73	87	0	0	48	206	184	640
GO	1.846	6.971	2.862	464	342	663	476	240	13.864
MA	910	65	49	4	2	5	148	415	1.598
MT	2.691	5.076	3.631	1.048	85	625	642	3.086	16.884
MS	213	1.343	1.540	73	116	401	1.598	699	5.983
MG	7.289	14.629	16.306	2.847	2.932	19.225	24.371	22.436	110.035
PA	89	225	273	259	97	452	247	677	2.319
PB	174	453	1.387	321	57	233	421	99	3.145
PR	1.842	3.446	5.588	465	40	1.165	2.060	1.373	15.979
PE	1.487	3.712	4.888	298	905	2.293	1.286	2.442	17.311
PI	436	653	1.384	22	16	57	12	51	2.631
RJ	170	2.240	3.144	797	1.694	3.219	8.153	6.143	25.560
RN	623	348	971	20	68	132	645	599	3.406
RS	3.430	4.435	7.599	668	178	2.154	9.278	6.751	34.493
RO	474	232	1.713	12	63	108	0	98	2.700
RR	55	0	79	0	0	0	60	8	202
SC	2.268	1.735	3.470	610	589	493	1.137	892	11.194
SP	3.524	9.388	8.689	2.814	1.673	6.984	35.728	38.801	107.601
SE	265	326	72	51	10	18	0	15	757
TO	1.270	2.145	1.390	280	36	24	5	39	5.189
Brasil	30.818	62.386	74.624	13.360	10.440	42.635	94.099	95.602	423.964

Fonte: Os autores (2024) – Elaborada com dados gerados no SISAB.

Embora os números não informem sobre a frequência e continuidade dos usuários (participantes) nas rodas de TCI, acredita-se que a assiduidade dos usuários nas rodas da TCI ocorra, o que pode ser confirmado pelos terapeutas comunitários.

6.4.3 Indicador 3: Percentual de Estabelecimentos com Cadastro em TCI

Ficha de Qualificação do Indicador 3	
Indicador 3	Percentual de estabelecimentos com cadastro em TCI
Descrição	Apresenta o total de estabelecimentos com cadastro no CNES para oferta de TCI (classificada em práticas psicodinâmicas) em relação ao total de estabelecimentos com cadastro no CNES para oferta de PICS
Periodicidade	Anual, ao fim do ano
Cálculo	$\frac{\text{Total de estabelecimentos com cadastro em prática psicodinâmicas}}{\text{Total de estabelecimentos com cadastro em PICS}} \times 100$
Fonte	CNES

O Indicador 3 apresenta o percentual de estabelecimentos cadastrados para oferta da TCI na plataforma nacional de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) em relação ao total de estabelecimentos que ofertam PICS.

Ele nos dá uma ideia relativa da presença da TCI dentro da rede já estabelecida de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no geral. Esse se faz um denominador saudável, considerando que se utilizássemos todos os equipamentos da APS, tornaria o indicador pouco sensível, dada a grande diferença existente entre os números do numerador e denominador da equação utilizada para o seu cálculo.

É importante lembrar que há uma defasagem crônica entre os estabelecimentos de saúde cadastrados à esta prática da TCI e os que efetivamente a registram, na qual muitos o fazem sem o devido cadastro, o que gera uma disparidade de informações. Por exemplo, o Estado do Pará registrou atendimentos de TCI no ano de 2020, porém não há nenhum estabelecimento de saúde, no âmbito SUS (públicos ou conveniados), cadastrado no CNES como ofertante de Práticas Psicodinâmicas (classificação correspondente à TCI na plataforma do CNES). Isso dificulta o monitoramento e possíveis ações dire-

cionadoras da gestão. Esse indicador funciona, inclusive, como oportunidade de reconhecer esses *gaps* ou lacunas de informação.

Vale ressaltar que, embora a TCI tenha sido incluída na PNPIC em 2017 (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017), os primeiros estabelecimentos foram cadastrados somente em 2019. A Tabela 6.4 mostra o número de estabelecimentos de saúde com cadastro no CNES em Práticas Psicodinâmicas (aqueles habilitados a ofertarem TCI), por região e Unidade da Federação do Brasil, entre 2019 e 2023.

Tabela 6.4 – Total de estabelecimentos de saúde com cadastro em Práticas Psicodinâmicas no CNES por região e Unidade da Federação (UF) do Brasil no período de 2019 e 2023

Região	UF	2019	2020	2021	2022	2023
Centro-Oeste	DF	–	–	1	2	5
	GO	–	–	–	5	5
	MS	–	1	35	35	35
	MT	–	1	2	2	4
Nordeste	AL	–	2	2	3	3
	BA	–	2	4	17	17
	CE	–	–	1	1	3
	MA	35	35	35	44	43
	PB	–	–	–	–	2
	PE	–	–	1	3	3
	PI	3	3	3	3	3
	RN	3	2	2	2	2
	SE	1	1	2	2	1
Norte	AM	6	6	6	21	22
	AP	–	–	1	1	1
	TO	–	–	1	1	1
Sudeste	MG	–	–	5	34	119
	RJ	–	6	6	8	9
	SP	2	3	4	12	110
Sul	PR	–	–	1	4	4
	RS	2	4	40	88	105
	SC	16	21	33	64	101
Brasil	–	68	87	185	352	598

Fonte: Os autores (2024) – Elaborada com dados de 2023 extraídos do CNES.

Com base nos dados de 2023, tem-se na Tabela 6.5 o resultado do Indicador 3 por região e Unidade da Federação (UF) do Brasil.

Tabela 6.5 – Resultado do indicador percentual de estabelecimentos com cadastro em TCI considerando os dados de 2023 por região e Unidade da Federação (UF) do Brasil

UF por Região	CNES PICS	CNES Psicodinâmicas	Indicador (em %)	UF por Região	CNES PICS	CNES Psicodinâmicas	Indicador (em %)
Norte	669	24	3,59	Centro-Oeste	1.636	49	3,00
AC	47	0	0,00	DF	309	5	1,62
AM	347	22	6,34	GO	380	5	1,32
AP	20	1	5,00	MS	664	35	5,27
PA	158	0	0,00	MT	283	4	1,41
RO	31	0	0,00	Nordeste	3.999	77	1,93
RR	11	0	0,00	AL	133	3	2,26
TO	55	1	1,82	BA	1.020	17	1,67
Sudeste	8.823	238	2,70	CE	434	3	0,69
ES	126	0	0,00	MA	674	43	6,38
MG	3.948	119	3,01	PB	474	2	0,42
RJ	1.571	9	0,57	PE	490	3	0,61
SP	3.178	110	3,46	PI	201	3	1,49
Sul	5.537	210	3,79	RN	338	2	0,59
PR	414	4	0,97	SE	235	1	0,43
RS	260	105	3,90	–	–	–	–
SC	2.433	101	4,15	Brasil	20.664	598	2,89

Fonte: Os autores (2024) – Elaborada com base nos dados de 2023 do CNES.

Em nível nacional, o resultado do Indicador 3 mostra uma relação percentual de estabelecimentos de TCI de 2,89%, comparado ao total de estabelecimentos ofertantes de PICS.

Considerando os indicadores anteriores, que retratam os registros de atendimentos (usuários), percebe-se, de imediato, a disparidade de informações sobre estabelecimentos cadastrados, como já citado, requerendo especial atenção da gestão, o que refletirá na melhoria desse indicador.

Com base nos indicadores apresentados, pode-se, além da análise do recorte temporal, obter algumas informações complementares, como, por exemplo, a média de participantes por roda de TCI. A constância desse número nos fornece uma ideia de frequência e continuidade dos participantes nas rodas. Ainda que não se consiga definir se são os mesmos, pode-se supor a assiduidade de usuários atendidos pela prática, como disposto na Tabela 6.6.

Tabela 6.6 – Número de participantes e de rodas por ano e média de participantes por roda

Brasil / Ano	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Participantes	30.818	62.386	74.624	13.360	10.440	42.635	94.099	95.602
Rodas de TCI	1.868	4.009	5.828	1.309	1.143	4.020	8.916	9.937
Média por roda	16	16	13	10	9	11	11	10

Fonte: Os autores (2024) – Elaborada a partir de dados gerados no SISAB.

Com base nas informações dispostas na Tabela 6.6, percebe-se redução do número de rodas e participantes entre 2020 e 2021, período correspondente à pandemia de Covid-19, quando as rodas de TCI no formato presencial foram suspensas. Nos anos seguintes, nota-se recomposição gradativa de participação nas rodas, com números, em 2023 e 2024, superiores aos de 2019, último ano de crescimento antes da pandemia. Percebe-se, também, aumento da oferta de rodas de TCI, porém com queda do número de participantes. A média de 13 participantes por roda, em 2019, foi reduzida, mantendo-se em torno de 10 a 11 no período de 2022 a 2024.

Os três indicadores apresentados expressam o significado de como a TCI tem sido registrada no âmbito do SUS. Ainda há muito o que avançar, principalmente na qualificação dos registros de informação sobre a TCI, mas esses indicadores fornecem indicativos do estado da arte da TCI no âmbito da APS e de estratégias para o fortalecimento da TCI no âmbito do SUS.

Quanto aos outros indicadores sugeridos neste documento, dados não estão disponíveis no SISAB e CNES para calculá-los, necessitando de pesquisas específicas para quantificá-los.

6.5 Obtenção de Relatórios de Acesso Público

Os sistemas de informações em saúde (SIS) no Brasil referem-se a uma rede complexa de tecnologias, protocolos e processos que coletam, armazenam, analisam e disseminam dados relacionados à saúde da população brasileira por meio dos registros efetuados pelos serviços oferecidos pelo SUS à população. Eles são fundamentais para monitorar indicadores de saúde, planejar políticas públicas, melhorar a qualidade dos serviços de saúde e fornecer informações para profissionais e gestores do setor.

Geralmente, esses sistemas englobam várias subáreas, como epidemiologia, vigilância sanitária, regulação de serviços de saúde, gestão de hospitais e unidades de saúde, entre outras. Além disso, integram diferentes níveis de atenção à saúde, desde atenção básica até procedimentos de alta complexidade.

Nesse contexto, a obtenção de relatórios de acesso público relacionados à TCI, essenciais para o cálculo dos indicadores, é apresentada a seguir para dois sistemas de informação: o SISAB e o CNES.

6.5.1 Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB)

O SISAB, instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, é o sistema responsável pelo gerenciamento dos dados oriundos dos sistemas da APS, integrando a estratégia e-SUS APS.

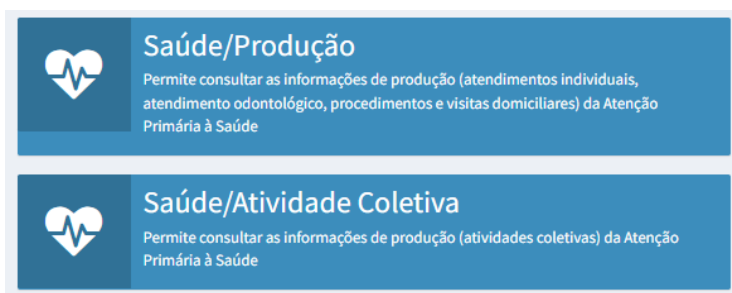
O envio dos dados, pelos municípios, ocorre por meio da Coleta de Dados Simplificada (CDS), em modo on-line ou offline, Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), ou por meio de Sistema Próprio utilizando a tecnologia de transporte apache THRIFT.

Os dados enviados ao Centralizador Nacional são submetidos a um processo de validação para serem disponibilizados nos painéis de relatórios do SISAB; por isso, é previsto a ocorrência de diferenças entre os dados enviados e os disponibilizados.

O SISAB reúne dados sobre diversas áreas da atenção básica, como cadastro de unidades de saúde, informações sobre equipes de saúde da família e equipes de atenção básica, registro de atendimentos e procedimentos realizados, cobertura populacional, dentre outros. Essas informações são coletadas e atualizadas pelas próprias unidades de saúde e, posteriormente, consolidadas no sistema, seja por meio do e-SUS, plataforma principal do sistema, ou formulários padronizados, nos casos de unidades que não disponham de equipamentos informatizados.

Dados de interesse público são disponibilizados no SISAB resguardando a importância da Proteção de Dados Pessoais, conforme a Lei nº 13.709/ 2018, com opção de acesso público e restrito. Para o acesso restrito, é necessário cadastro prévio no sistema e-Gestor AB. Notas técnicas explicativas, que auxiliam na geração dos relatórios de acesso público, estão disponíveis no site <https://sisab.saude.gov.br/>.

O SISAB organiza os registros em duas grandes categorias: Atendimentos Individuais e Atendimentos Coletivos, correspondendo as abas/ícones Saúde/Produção e Saúde/Atividade Coletiva, respectivamente, disponíveis na tela inicial do SISAB, mostradas na imagem a seguir.



Como dito anteriormente, a TCI deve ser registrada em Atendimentos Coletivos. Contudo, há ainda um volume grande de registros em Atendimentos Individuais, sendo necessária a pesquisa nos dois formatos (Individual e Coletivo), somando-os ao final, para consolidação da informação completa.

1) Pesquisa em Atendimentos Individuais no SISAB

Informações dos registros de Atendimentos Individuais podem ser gerados em linhas e colunas, de acordo com as opções Unidade Geográfica e Competência (mês ou período, quando mais de um mês for selecionado) e outros filtros disponíveis para refinar a pesquisa (ex.: Tipo de Equipe, Categoria do Profissional que realizou o atendimento, Faixa Etária, Sexo, Local de Atendimento e Tipo de Atendimento).

A Figura 6.4 mostra a imagem da tela de Atendimentos Individuais do SISAB para o exemplo de opções e filtros mostrados a seguir.

• Acesse https://sisab.saude.gov.br/ e selecione o ícone Saúde/Produção • Utilize as opções e filtros a seguir para gerar o relatório da TCI para o ano de 2023	
Unidade Geográfica: Brasil Linha do Relatório: Estado Tipo de Equipe: nenhum item selecionado Categoria do Profissional: selecionar todas Local de Atendimento: selecionar todos Procedimento: nenhum item selecionado +SIGTAP: (0101050020)	Competência: selecionar JAN/2023 a DEZ/2023 Coluna do Relatório: Práticas Integrativas Complementares Faixa Etária: 0 a 120 anos Sexo: Selecionar todos Tipo de Produção: Procedimento Procedimentos Pics: Terapia Comunitária Como deseja visualizar? Download -> Excel

A seleção de filtros é obrigatória se houver interesse em algum recorte específico. Assim, se o relatório de interesse for o que contém os registros para, por exemplo, todos os sexos e faixa etária, não há a necessidade de preencher os campos correspondentes aos filtros Sexo e Faixa Etária.

Para selecionar os códigos SIGTAP da TCI, deve-se clicar sobre o botão +SIGTAP (Figura 6.4, final da tela).

Figura 6.4 – Tela de Atendimentos Individuais com as opções e filtros do exemplo

SISAB Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica

Ministério da Saúde GOVERNO FEDERAL

Acesso Restrito

Saúde: Atendimento/Visita

Nota Técnica

Selecione as opções para gerar o relatório:

Unidade Geográfica:

Brasil

Competência*:

12 selected

Linha / Coluna

Selecione o que deseja visualizar como linha e coluna:

Linha do Relatório: Estado

Coluna do Relatório: Práticas Integrativas Complementares

Filtros:

Tipo de Equipe:

Nenhum item selecionado

Categoria do Profissional:

Selecionados (26)

Faixa Etária:

De: 0 até 120

☐ Ignorar ☐ Dias ☒ Ano

Sexo:

Selecionados (2)

Local de Atendimento:

Selecionados (10)

Tipo de Produção: Procedimento

Procedimento: Nenhum item selecionado

Procedimentos Pics: TERAPIA COMUNITÁRIA

+SIGTAP

Como deseja visualizar?

Ver em tela Download Gráfico Limpar Filtros

Fonte: SISAB (2024).

Ao clicar sobre o botão +SIGTAP, deve-se procurar por Terapia Comunitária e, então, selecionar os códigos atribuídos à TCI (01.01.01.005-2 e 01.01.05.002-0), como mostrado na Figura 6.5.

Caso o período de busca selecionado na opção Competência não inclua o ano de 2017, pode-se selecionar apenas o primeiro código da Lista SIGTAP (Figura 6.5), visto o segundo código ter sido descontinuado em 2017 (Portaria nº 145, de 11 de janeiro de 2017).

Figura 6.5 – Imagem do filtro correspondente ao SIGTAP da TCI

Lista de SIGTAP

Mostrar 10 registros por página

Procurar: Terapia Comunitaria

SIGTAP

☒ (0101010052) Terapia Comunitaria

☒ (0101050020) Terapia Comunitaria

Exibindo de 1 a 2 de 2 registros

Anterior

1

Próximo

Limpar

Concluir

Fonte: SISAB (2024).

2) Pesquisa em Atendimentos Coletivos no SISAB

Ao selecionar a aba Saúde/Atividade Coletiva, relatório dos registros efetuados pelos profissionais de saúde em Atendimentos Coletivos pode ser gerado em linhas e colunas, de acordo com as opções e filtros disponíveis.

A seguir, tem-se um exemplo de opções e filtros para gerar relatório da TCI no SISAB para o ano de 2017.

• Acesse https://sisab.saude.gov.br/ e selecione Saúde/Atividade Coletiva • Exemplo de opções e filtros para gerar relatório da TCI para o ano de 2017	
Unidade Geográfica: Brasil Linha do Relatório: Estado Tipo de Equipe: Nenhum item Categoria do Profissional: todas Como deseja visualizar? Download	Competência: selecionar JAN/2017 a DEZ/2017 Coluna do Relatório: Qt Atividade Coletiva / N° Participantes Público Alvo: selecionar todos +SIGTAP: (0101010052) Terapia Comunitária (0101050020) Terapia Comunitária

6.5.2 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

O CNES é um sistema de informações gerenciado pelo Ministério da Saúde do Brasil, que tem como objetivo cadastrar e manter atualizados os dados de todos os estabelecimentos de saúde do país, públicos e privados. Esse

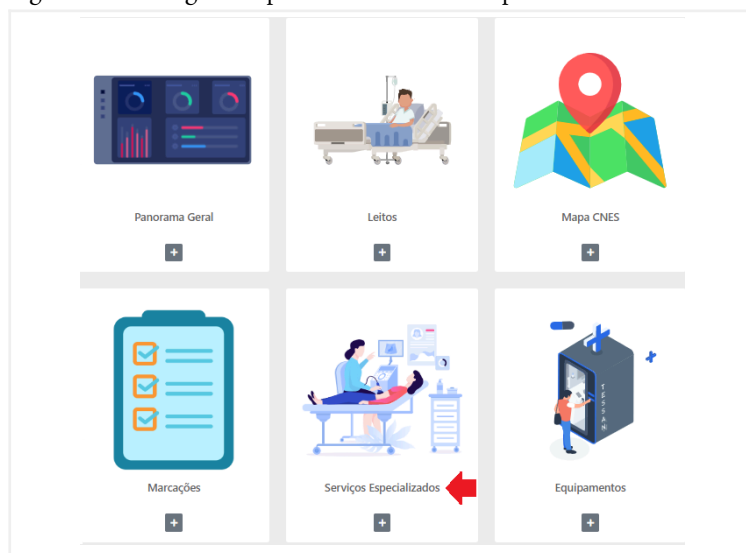
cadastro abrange uma ampla gama de instituições, incluindo hospitais, clínicas, postos de saúde, laboratórios, entre outros.

O CNES desempenha um papel fundamental na organização e gestão do sistema de saúde brasileiro, fornecendo informações essenciais para o planejamento, regulação, monitoramento e avaliação dos serviços de saúde. Entre as informações registradas no CNES estão dados sobre a localização e a estrutura física dos estabelecimentos, os serviços oferecidos, a capacidade de atendimento, os recursos humanos, entre outros aspectos relevantes.

Para o cálculo do Indicador 3, foram utilizados dados do CNES como fonte principal de coleta, em particular a plataforma ElastiCNES, que organiza de forma dinâmica e constante dados provenientes do CNES (link de acesso à plataforma: <https://elasticnes.saude.gov.br/>).

Inicialmente, é necessário compreender o âmbito da pesquisa. Em se tratando de PICS, faz-se necessário a observância dos equipamentos de saúde que oferecem tal serviço, que ficam dispostos no menu da plataforma como “Serviços Especializados” (Figura 6.6).

Figura 6.6 – Imagem de parte da tela inicial da plataforma ElastiCNES



Fonte: Plataforma ElastiCNES (2024).

É importante ressaltar que além da TCI, há outras práticas classificadas no CNES como Práticas Psicodinâmicas. São elas: Bioenergética, Constelação Familiar e Hipnoterapia. Portanto, um estabelecimento com cadastro em Práticas Psicodinâmicas está habilitado a todas elas.

Início > Serviços Especializados

ANO20231

COMPETÊNCIA202312, 202311, 202310, 202309, 202308, 202...12

MACROREGIÃOAny

UFAny

IBGEAny

MUNICÍPIOAny

CNESAny

NOME FANTASIAAny

NOME EMPRESARIALAny

STATUS DO ESTABELEC...ATIVO1

TIPO DO ESTABECIME...Any

SUBTIPO DO ESTABELE...Any

GESTÃAny

CATEGORIA NATUREZA ...Any

NATUREZA JURÍDICAAny

SERVIÇO134 SERVIÇO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E ...1

SERVIÇO CLASSIFICAÇÃO012 PRÁTICAS PSICODINAMI...1

SERVIÇO - CARACTERÍS...Any

SERVIÇO TERCEIROAny

CNES | Serviços Especializados

Serviço | Classificação | Terceiro

Período: 2007/07 → 2024/04

Filtros: Estabelecimentos Ativos

Além do "Serviço" e "Serviço Classificação", pode-se proceder o refinamento da pesquisa de diferentes formas. Por exemplo, "Ano" e "Competência" (Figura 6.7), que referem-se ao período pesquisado. Ressalta-se que os cadastros dos estabelecimentos no CNES são organizados de forma cumulativa, diminuindo raramente ao longo do tempo, a menos que os estabelecimentos sejam desativados. Assim, ao proceder a análise, atentar para possíveis duplicidades de contagem quando observados recortes temporais com mais de 1 ano.

Outras opções de refinamento da pesquisa são: Unidade Federativa, Status do Estabelecimento (Ativo ou Inativo), Tipo e Subtipo de Estabelecimentos, Gestão (Municipal, Estadual ou Dupla), Categoria Natureza Jurídica (Público, Privado ou sem fins lucrativos), dentre outras (Figura 6.7).

É oportuno mencionar que ao restringir a construção da pesquisa no CNES à APS, não se deve selecionar apenas a opção "Público" em "Categoria Natureza Jurídica", visto que alguns estabelecimentos estão cadastrados como privados, mas ofertam serviços na modalidade de Convênio SUS, o que os fazem parte do equipamento público. A seleção desses estabelecimentos, deve ser feita posteriormente no manuseio dos dados extraídos em planilhas.

7

LEGISLAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

7.1 Instrumentos Normativos

Os instrumentos normativos sobre as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) podem incluir vários dispositivos legais e regulamentares, que visam estruturar, organizar e promover essas práticas no contexto das políticas públicas de saúde. Esses instrumentos variam conforme a estrutura administrativa e a legislação local de cada município.

No que concerne à TCI, esses instrumentos incluem, em geral, os apresentados no Quadro 7.1.

Quadro 7.1 – Instrumentos normativos sobre a TCI

(continua)

Instrumentos	Descrição
Leis Municipais	Normas aprovadas pela Câmara Municipal e sancionadas pelo prefeito, que instituem a TCI como parte integrante das políticas de saúde mental do município. Essas leis podem definir a criação de programas de TCI, objetivos, abrangência, e diretrizes gerais para a implementação e execução.
Projetos de Lei	Têm como objetivo regulamentar, promover e integrar a TCI nas políticas públicas de saúde e assistência social. Esses projetos podem ser apresentados em diferentes esferas legislativas, como municipais, estaduais ou federais, e são elaborados com base em estudos, demandas sociais e evidências de eficácia da TCI.
Decretos Municipais	Atos administrativos emitidos pelo prefeito que regulamentam as leis municipais relacionadas à TCI. Esses decretos detalham a aplicação prática das leis, estabelecendo procedimentos específicos, designando órgãos responsáveis, e alocando recursos para a prática da TCI.

Quadro 7.1 – Instrumentos normativos sobre a TCI (conclusão)

Instrumentos	Descrição
Portarias	Emitidas pelas Secretarias Municipais de Saúde ou de Assistência Social, essas portarias detalham aspectos operacionais e administrativos da TCI. Elas podem definir critérios para a formação de terapeutas comunitários, padrões de qualidade do serviço, e procedimentos de avaliação e monitoramento das atividades.
Resoluções	Documentos emitidos por conselhos municipais de saúde ou outras entidades colegiadas, que tratam de aspectos específicos da prática da TCI. Resoluções podem estabelecer diretrizes para a integração da TCI com outros serviços de saúde, definir metas de atendimento, e criar mecanismos de articulação intersetorial.
Instruções Normativas	Atos administrativos que especificam procedimentos técnicos e operacionais para a implementação da TCI. Podem incluir protocolos de atendimento, metodologias de registro e avaliação das sessões terapêuticas, e orientações para a formação continuada dos terapeutas comunitários.
Planos Municipais de Saúde	Documentos estratégicos que definem as prioridades e diretrizes para a política de saúde do município. A inclusão da TCI nesses planos é fundamental para sua institucionalização e para a definição de metas, indicadores de desempenho, e estratégias de financiamento.
Convênios e Parcerias	Acordos firmados entre a administração municipal e outras entidades públicas ou privadas, como universidades, ONGs, e associações profissionais. Esses convênios podem prever a cooperação técnica, capacitação de profissionais, e desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão em TCI.
Regulamentos Internos	Normas internas dos serviços de saúde que detalham a organização e funcionamento das atividades de TCI. Podem incluir horários de atendimento, composição das equipes, e critérios para a seleção de participantes.

Fonte: Os autores (2024).

Os instrumentos normativos são essenciais para garantir a implementação estruturada e sustentável da TCI no município, promovendo a saúde mental e o bem-estar da comunidade por meio de práticas integrativas e complementares em saúde (PICS).

O Quadro 7.2. lista alguns instrumentos normativos sobre as PICS que podem auxiliar na implementação da TCI.

Quadro 7.2 – Instrumentos normativos sobre as PICS

(continua)

Instrumentos	Descrição
Lei nº 8.080 de 19/09/1990	Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
Lei nº 8.142 de 28/12/1990	Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
Portaria GM/MS nº 971 de 03/05/2006	Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS). https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html
Portaria GM/MS nº 4.279 de 30/12/2010	Estabelece diretrizes para a organização da RAS no âmbito do SUS. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
Decreto Federal nº 7.508 de 28/06/2011	Regulamenta a Lei nº 8.080 de 19/09/1990. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm
Portaria GM/MS nº 2.446 de 11/11/2014	Redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html
Portaria SAS/MS nº 145 de 11/01/2017	Estabelece novos procedimentos de práticas integrativas e complementares em saúde na tabela de procedimentos do SUS para atendimento na AB. https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pics/legislacao#:~:text=Portaria%20n%C2%BA%20145%2C%20de%2011,para%20atendimento%20na%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica
Portaria GM/MS nº 849 de 27/03/2017	Inclui a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga à PNPIC. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt0849_28_03_2017.html

Quadro 7.2 – Instrumentos normativos sobre as PICS (conclusão)

Instrumentos	Descrição
Portaria GM/MS nº 2.436 de 21/09/2017	Aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) no âmbito do SUS. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
Portaria GM/MS de Consolidação nº 2 de 28/09/2017	Consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS. https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/10_portaria_de_consolidacao_n_2_2017_contratualizacao_cosems.pdf
Portaria GM/MS nº 702 de 21/03/2018	Altera a Portaria GM/MS de Consolidação nº 2 de 28/09/2017 para incluir novas práticas na PNPIC. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018/prt0702_22_03_2018.html
Portaria nº 1.988 de 20/12/2018	Atualiza os procedimentos e serviços especializados de Práticas Integrativas e Complementares na Tabela de Procedimentos Medicamentos Órteses Próteses e Materiais Especiais do SUS e no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2018/prt1988_31_12_2018.html
Portaria SAES/MS nº 2.326 de 06/12/2024	Inclui Subgrupo de Telessaúde e Formas de Organização no Grupo 08-Ações Complementares e inclui novos procedimentos de Telessaúde na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-saes/ms-n-2.326-de-6-de-dezembro-de-2024-601712939

Fonte: Os autores (2024).

7.2 Políticas Estaduais de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde

O Quadro 7.3 lista os estados formalizando as Políticas Estaduais de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PEPIC).

Ao todo são 12 estados, mais o Distrito Federal, sendo que seis estados (Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais e Rio Grande do Sul) e o Distrito Federal possuem financiamento específico.

Quadro 7.3 – Estados formalizando as Políticas Estaduais de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PEPIC), 2024 (continua)

Estado	Normativa	Financiamento Específico	Link de Acesso
Amapá	Decreto nº 1720 de 17 de maio de 2021 Decreto nº 1.109 de 06 de abril de 2021	Sim	https://editor.amapa.gov.br/publicacoes/SESA_512fed7edcb56ce83125eafabf441f2.pdf https://leisestaduais.com.br/ap/decreto-n-1109-2021-amapa-altera-o-decreto-no-2363-de-31-de-julho-de-2006-que-regulamenta-o-fundo-rotativo-dos-estabelecimentos-de-saude-da-rede-assistencial-pertencente-ao-governo-do-estado-do-amapa
Bahia	Resolução CIB nº 113/2019	Sim	http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/PEPICS-Bahia-2020-Politica-Praticas-Integrativas.pdf
Distrito Federal	Colegiado Gestor da SES-DF (Deliberação nº 01/2014) e pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal (Resolução nº 429/2014)	Sim	https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/2016/page/pdpic_distrito_federal.pdf
Espírito Santo	Resolução CES/ES nº 543/2008	Não	https://saude.es.gov.br/Media/sesa/PI C/SESA_POLITICA%20DAS%20PICS_VERSAO%20FINAL.pdf
Goiás	Lei nº 16.703 de 23 de setembro de 2009	Sim	https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/88436/lei-16703
Maranhão	Portaria/SES/MA nº 1139 de 19 de setembro de 2022	Sim	https://arcadados.fiocruz.br/file.xhtml?persistentId=doi:10.35078/SYRRHB/YUX3YW

Quadro 7.3 – Estados formalizando as Políticas Estaduais de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PEPIC), 2024 (conclusão)

Estado	Normativa	Financiamento Específico	Link de Acesso
Minas Gerais	Resolução SES-MG nº 1885 de 27 de maio de 2009	Sim	https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/2016/page/pepic_minas_gerais.pdf
Paraná	Lei nº 19.785 de 20 de dezembro de 2018	Não	https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-19785-2018-parana-institui-as-diretrizes-para-as-praticas-integrativas-e-complementares-em-saude-no-ambito-do-sistema-unico-de-saude-do-estado-do-parana-sus-pr
Pernambuco	Lei nº 17.970 de 12 de dezembro de 2022	Não	https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=70440#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2017.970%2C%20DE%2012,6%C2%BA%20e%208%C2%BA%20do%20art
Rio de Janeiro	Lei nº 9.345 de 24 de junho de 2021	Não	https://leisestaduais.com.br/rj/lei-ordinaria-n-9345-2021-rio-de-janeiro-cria-o-programa-estadual-de-medicina-tradicional-e-complementar-alternativa-mca?q=INTEGRATIVA
Rio Grande do Norte	Lei nº 10.933 de 17 de junho de 2021	Não	https://www.al.rn.leg.br/storage/legislacao/2021/b4d33yz9attdr247p6675r5bmtt885.pdf
Rio Grande do Sul	Resolução nº 695/13 – CIB / RS e Resolução CES/RS nº 14/2014	Sim	https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/201712/11141920-politica-estadual-de-praticas-integrativas-e-complementares-2015.pdf
Santa Catarina	Lei nº 17.706 de 22 de janeiro de 2019	Não	http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2019/17706_2019_lei.html

Fonte: Ministério da Saúde (2024).

7.3 Documentos Relevantes

Os Quadros 7.4 a 7.6 listam documentos importantes para a implantação da TCI nos serviços públicos de saúde.

Quadro 7.4 – Documentos e Cursos sobre as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde

Documento ou Curso	Link de Acesso
Estratégia da OMS sobre medicina tradicional 2014-2023	https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/95008/9789243506098_spa.pdf;jsessionid=7FA5E1FE9863475CFBED452320CCC36?sequence=1
Manual de Implantação de Serviços de Práticas Integrativas e Complementares no SUS	https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pics/publicacoes/manual_implantacao_servicos_pics.pdf/view
Glossário temático de PICS	https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pics/publicacoes/glossario_pics.pdf/view
Cursos de PICS no Ambiente virtual de Aprendizagem do SUS	https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/cursos.php?search=PICS
Terapia Comunitária Integrativa: Cuidando da Saúde Mental em Tempos de Crise	https://observapics.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/02/Especial-PICS-Covid-TCI-ObservaPICS.pdf
Nota Técnica 02/2020 TCI na Rede de Atenção à Saúde do RS	https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202009/14093602-nota-tecnica-terapia-comunitaria-integrativa-02-2020-docx.pdf https://atencaoprimaria.rs.gov.br/politica-estadual-de-praticas-integrativas-e-complementares

Fonte: Ministério da Saúde (2024).

Quadro 7.5 – Documentos importantes da ABRATECOM

Documento	Link de Acesso
Orientações sobre as certificações chanceladas pela ABRATECOM	https://abratecom.org/certificados/
Passo a Passo para fazer parte da rede ABRATECOM	https://abratecom.org/docs/
Estatuto da ABRATECOM	https://abratecom.org/docs/
Resolução Normativa nº 001/2021 sobre a capacitação híbrida em TCI	https://abratecom.org/docs/

Fonte: ABRATECOM (2024).

Quadro 7.6 – Vídeos sobre a TCI para sensibilização de gestores, profissionais e comunidade

Vídeos	Link de Acesso
Projeto 4 Varas Adalberto Barreto TEDxFortaleza	https://www.youtube.com/watch?v=C9d2SrRyyAc
Terapia Comunitária Integrativa e o Projeto 4 Varas: comunidade que cuida	https://www.youtube.com/watch?v=DnffXB2qtrE
Terapia comunitária tem base científica?	https://www.youtube.com/watch?v=eoQB-qRfnZQ
Terapia comunitária é...	https://www.youtube.com/watch?v=87P4ja-XJAK
356ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde TCI – 38:26 a 58:49	https://www.youtube.com/watch?v=5iEyfpP-A5M https://www.youtube.com/results?search_query=Conselho+Nacional+de+Sa%C3%BAde
1º Seminário Nacional: Importância das PICS no SUS (Conselho Nacional de Saúde) TCI – 2:14:52 a 2:32:43	https://www.youtube.com/watch?v=XwQNrlQ5FoU&t=8126s https://www.youtube.com/results?search_query=Conselho+Nacional+de+Sa%C3%BAde
Adalberto Barreto e Doralice Oliveira Bate-papo sobre a TCI	https://www.youtube.com/watch?v=MO6a92MfnJo

Fonte: Vídeos do YouTube. Disponíveis em: YouTube.com. Acesso em: 24 ago. 2024.

8

COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DOS GESTORES

8.1 Competências Institucionais

As competências institucionais dos gestores federal, estadual e municipal no Brasil em relação às PICS, o que inclui a Terapia Comunitária Integrativa (TCI), estão fundamentadas na legislação e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Cada nível de governo tem responsabilidades específicas que visam garantir a implementação e a eficácia das práticas dentro do SUS.

A seguir são detalhadas as competências de cada nível de gestão.

8.1.1 Competências Federais - Governo Federal

- 1) Formulação de Políticas e Diretrizes: O Ministério da Saúde é responsável pela criação de políticas nacionais de saúde que incluam as práticas integrativas e complementares em saúde, como a TCI.
- 2) Financiamento: Alocação de recursos financeiros para programas de saúde que incluam a TCI, assegurando o repasse de verbas para estados e municípios.
- 3) Capacitação e Formação: Desenvolvimento e promoção de programas de capacitação para profissionais de saúde, garantindo que os facilitadores de TCI sejam devidamente treinados.
- 4) Regulação e Normatização: Estabelecimento de normas e diretrizes técnicas para a prática da TCI, garantindo a padronização e qualidade dos serviços oferecidos.

- 5) Monitoramento e Avaliação: Realização de estudos e pesquisas para avaliar a eficácia e impacto da TCI, promovendo a melhoria contínua dessa prática integrativa.

8.1.2 Competências Estaduais - Governo Estadual

- 1) Implementação das Políticas Nacionais: Adequação das políticas nacionais de saúde às realidades regionais, promovendo a TCI de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde.
- 2) Coordenação e Supervisão: Coordenação das ações de TCI nos municípios, garantindo a integração e articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde.
- 3) Capacitação Regional: Promoção de programas de formação e capacitação para profissionais de saúde a nível estadual, em parceria com instituições de ensino e outras organizações.
- 4) Financiamento Complementar: Destinação de recursos complementares para apoiar a implementação de TCI nos municípios, além dos repasses federais.
- 5) Monitoramento e Avaliação Regional: Realização de avaliações regionais sobre a eficácia e impacto da TCI, fornecendo dados para ajustes e melhorias dessa prática integrativa.

8.1.3 Competências Municipais - Governo Municipal

- 1) Execução das Políticas de Saúde: Implementação das políticas de saúde que incluam TCI no âmbito municipal, adaptando-as às necessidades locais.
- 2) Organização dos Serviços de Saúde: Estruturação dos serviços de saúde para incluir a TCI, promovendo sua integração nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e outros equipamentos públicos.

- 3) Capacitação Local: Realização de treinamentos e capacitações para profissionais de saúde locais, garantindo que a TCI seja praticada por facilitadores qualificados.
- 4) Gestão de Recursos: Gerenciamento dos recursos destinados à saúde, assegurando a alocação adequada para a implementação da TCI.
- 5) Monitoramento e Avaliação Local: Avaliação contínua das práticas de TCI no município, coletando dados e *feedbacks* para ajustes e melhorias nos serviços.

8.2 Integração entre os Níveis de Gestão

Para que a TCI seja efetivamente implementada e alcance seus objetivos, é essencial uma articulação e cooperação entre os níveis federal, estadual e municipal. Essa integração garante que as políticas e diretrizes nacionais sejam adaptadas e aplicadas de forma eficiente e eficaz em todas as regiões do país, respeitando as especificidades locais e regionais.

Cada nível de gestão tem um papel fundamental e complementar no processo de implementação da TCI no SUS. A sinergia entre os gestores federal, estadual e municipal é crucial para assegurar que essa prática contribua para a promoção da saúde e bem-estar da população, proporcionando um cuidado integral e humanizado.

9

REGULAMENTAÇÃO DAS PROFISSÕES DA ÁREA DA SAÚDE

9.1 Resolução dos Conselhos de Classes

Segundo a Resolução dos Conselhos de Classes quanto à Regulamentação da TCI (Quadro 9.1), 46,7% dos conselhos aprovam a utilização da TCI como atribuição profissional, sendo eles: Biomedicina, Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional.

O Serviço Social, conforme Resolução CFESS N° 569 de 25/03/2010, deliberou que a realização de terapias não constitui atribuição e competência do assistente social. Para fins desta Resolução, consideram-se como terapias individuais, grupais e/ou comunitárias: intervenção profissional que visa tratar problemas somáticos, psíquicos ou psicossomáticos, suas causas e seus sintomas; e atividades profissionais e/ou clínicas com fins medicinais, curativos, psicológicos e/ou psicanalíticos que atuem sobre a psique.

Vale destacar que a TCI não é considerada psicoterapia, de acordo com a definição do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde ao defini-la como: Prática terapêutica coletiva que atua em espaço aberto e envolve os membros da comunidade em atividade de construção de redes sociais solidárias para a promoção da vida e mobilização de recursos e competências dos indivíduos, famílias e comunidades. Não é um processo psicoterapêutico, mas, sim, um ato terapêutico de grupo em qualquer contexto e ciclos de vida, sendo os saberes individuais os elementos para a construção de laços sociais, apoio emocional, troca de experiências e diminuição do isolamento social.

Quadro 9.1 – Resolução dos Conselhos de Classe quanto à regulamentação da Terapia Comunitária Integrativa (TCI) (continua)

Conselhos Federais Profissionais da Saúde	Resolução	Ano	Parecer	Práticas	TCI	Total	PNPIC
Biologia (CFBio)	Resolução nº 614	2021	Aprova	Acupuntura e terapias associadas; Auriculoterapia; Apiterapia; Aromaterapia; Ayurveda; Bioenergética; Cromoterapia; Constelação Familiar; Fitoterapia; Geoterapia; Naturopatia; Ozonioterapia; Terapia de Florais e Termalismo Social/Crenoterapia.	Não	14	13 (44,8%)
Biomedicina (CFBM)	Resolução nº 327	2020	Aprova	Acupuntura; Antroposofia; Apiterapia; Aromaterapia; Arteterapia; Ayurveda; Biodança; Bioenergética; Constelação familiar; Cromoterapia; Dança Circular; Fitoterapia; Geoterapia; Hipnoterapia; Homeopatia; Imposição de mãos; Meditação; Musicoterapia; Naturopatia; Osteopatia; Ozonioterapia; Quiropraxia; Reflexologia; Reiki; Shantala; Terapia Comunitária Integrativa; Terapia de florais; Termalismo e Yoga.	Sim	29	29 (100%)
Enfermagem (COFEN)	Resolução nº 739	2024	Aprova	Apiterapia, Aromaterapia, Arteterapia, Auriculoterapia; Bioenergética; Constelação Familiar; Cromoterapia; Dança Circular; Geoterapia; Hipnoterapia; Imposição de mãos (Reiki, toque terapêutico, toque quântico); Massoterapia; Meditação; Musicoterapia; Ozonioterapia; Práticas Corporais da Medicina Tradicional Chinesa; Reflexologia; Shantala; Terapia Comunitária Integrativa; Terapia Floral e Yoga.	Sim	24	21 (72,4%)
Educação Física (CONFEF)	Resolução nº 282	2024	Aprova	Práticas corporais em medicina tradicional chinesa; Terapia Comunitária Integrativa; Yoga; Oficina de Massagem/Automassagem; Arteterapia; Meditação; Musicoterapia; Sessão de acupuntura aplicação de ventosas/moxa, Sessão de acupuntura com inserção de agulhas; Auriculoterapia; Massoterapia e Tratamento Naturopático.	Sim	11	9 (31%)

Quadro 9.1 – Resolução dos Conselhos de Classe quanto à regulamentação da Terapia Comunitária Integrativa (TCI) (continuação)

Conselhos Federais Profissionais da Saúde	Resolução	Ano	Parecer	Práticas	TCI	Total	PNPIC
Farmácia (CFF)	Resolução nº 732 Resolução nº 733 Resolução nº 737 Resolução nº 03	2022 2022 2022 2025	Aprova	Acupuntura; Antroposofia; Apiterapia; Aromaterapia; Arteterapia; Ayurveda; Biodança; Bioenergética; Constelação Familiar; Cromoterapia; Dança Circular; Fitoterapia; Geoterapia; Hipnoterapia; Homeopatia; Imposição de Mãos; Meditação; Musicoterapia; Naturopatia; Osteopatia; Ozonioterapia; Quiropraxia; Reflexologia; Reiki; Shantala; Terapia Comunitária Integrativa; Terapia de Florais; Termalismo e Yoga. Auriculoterapia e Auriculoacupuntura. Hipnoterapia. Aromaterapia; Aromatologia e Óleos essenciais.	Sim	29	29 (100%)
Fisioterapia (COFFITO)	Resolução nº 462 Resolução nº 380 Resolução nº 220	2015 2010 2001	Aprova	Auriculoterapia. Fitoterapia; Práticas Corporais, Manuais e Meditativas; Terapia Floral; Magnetoterapia; Fisioterapia Antroposófica; Termalismo/Crenoterapia/Balneoterapia e Hipnose. Quiropraxia e Osteopatia.	Não	11	9 (31 %)
Fonoaudiologia (CFFa)	Parecer nº 45	2020	Aprova	Acupuntura; Fitoterapia; outras práticas em Medicina Tradicional Chinesa; Práticas corpo-mente; Termalismo/Crenoterapia; Antroposofia aplicada à saúde; Práticas Expressivas; Ayurveda; Práticas Naturais; Práticas Manuais; Práticas Psico-dinâmicas; Aromaterapia e; Imposição de Mãos.	Sim	13	13 (44,8%)
Medicina (CFM)	Resolução nº 2.162 Resolução nº 2.181	2017 2018	Aprova	Acupuntura e Homeopatia. Ozonioterapia (a nível experimental).	Não	3	3 (10,3%)
Medicina Veterinária	Não tem	–	–	Em discussão no conselho.	Não		0%

Quadro 9.1 – Resolução dos Conselhos de Classe quanto à regulamentação da Terapia Comunitária Integrativa (TCI) (conclusão)

Conselhos Federais Profissionais da Saúde	Resolução	Ano	Parecer	Práticas	TCI	Total	PNPIC
Nutrição (CFN)	Resolução nº 679	2021	Aprova	Apiterapia, exceto Apitoxina; Aromaterapia; Arteterapia; Ayurveda; Biodança; Bioenergética; Cromoterapia; Dança Circular; Bomeopatia; Imposição de Mãos/Reiki; Medicina Antroposófica/Antroposofia aplicada à saúde; Medicina Tradicional Chinesa: Dietoterapia/Fitoterapia, Auriculoterapia e Práticas Corporais; Meditação; Musicoterapia; Reflexoterapia; Shantala; Terapia Comunitária Integrativa; Terapia de Florais e Yoga.	Sim	21	21 (72,4 %)
	Resolução nº 680	2021		Fitoterapia.			
Odontologia (CFO)	Resolução nº 82	2008	Aprova	Acupuntura; Fitoterapia; Terapia Floral; Hipnose; Homeopatia e Laserterapia.	Não	5	5 (17,2%)
Psicologia (CFP)	Nota Técnica nº 1	2023	Não recomenda	Constelação Familiar Sistêmica.	Não	1	1 (3,4%)
	Resolução nº 013	2000	Aprova	Hipnose.			
Saúde Coletiva	Não tem	–	–	–	Não	0	0%
Serviço Social (CFESS)	Resolução nº 569	2010	Profbe	Terapias individuais, grupais e/ou comunitárias.	Não	0	0%
Terapia Ocupacional (COFFITO)	Resolução nº 491	2017	Aprova	Arteterapia; Auriculoterapia; Dança Circular/Biodança; Fitoterapia; Hipnose; Magnetoterapia; Medicina Antroposófica; Meditação; Oficina de Massagem/Automassagem; Práticas Corporais, manuais e meditativas; Reiki; Shantala; Terapia Comunitária Integrativa; Terapia Floral e Yoga.	Sim	15	14 (48,2%)

Fonte: Os autores (2024).

10

SENSIBILIZAÇÃO DE GESTORES, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E COMUNIDADE

10.1 Introdução

Para que a Terapia Comunitária Integrativa (TCI) possa se estabelecer com sucesso e de forma eficaz, é fundamental a sensibilização de gestores, profissionais de saúde e da própria comunidade.

Nesse sentido, para que ocorra uma maior divulgação da TCI, é importante que os especialistas e representantes da TCI, constituídos por associações e instituições, dentre outros, intensifiquem a aproximação com gestores das Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais, gerentes de unidades de saúde, pessoas da comunidade do controle social/participação social, bem como com parlamentares.

A participação em congressos na área de Saúde Pública, pode também oferecer uma excelente oportunidade de aproximação com gestores, dentre eles, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS).

Algumas estratégias que podem ser eficazes para alcançar essa sensibilização são apresentadas a seguir.

10.2 Estratégias de Sensibilização

1. Promoção de Educação e Capacitação

- a) Gestores: Promover workshops e seminários para gestores de saúde e políticas públicas, apresentando a TCI como uma ferramenta eficiente para a promoção da saúde mental comunitária.

- b) Profissionais de Saúde: Oferecer formação em TCI para psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros profissionais de saúde, capacitando-os a conduzir rodas de TCI.
- c) Lideranças Comunitárias: Formar líderes comunitários para que possam atuar como facilitadores (terapeutas comunitários) e multiplicadores da TCI dentro de suas próprias comunidades.

2. Demonstração dos Benefícios da TCI

- a) Pesquisas e Estudos de Caso: Apresentar dados e estudos de caso que demonstrem a eficácia da TCI na promoção do bem-estar mental e na redução de sintomas de ansiedade, depressão e outros transtornos emocionais.
- b) Testemunhos: Compartilhar histórias de sucesso de comunidades que implementaram a TCI, mostrando os impactos positivos na coesão social e na saúde dos participantes.

3. Parcerias e Colaborações

- a) Instituições Acadêmicas e ONGs: Estabelecer parcerias com universidades e organizações não-governamentais para a promoção e disseminação da TCI.
- b) Governo e Setor Público: Trabalhar junto a secretarias de saúde e assistência social para incluir a TCI nas políticas públicas de saúde mental.

4. Comunicação e Divulgação

- a) Mídia Local: Utilizar rádios comunitárias, jornais locais e redes sociais para divulgar informações sobre a TCI, seus benefícios e como participar das rodas terapêuticas.
- b) Eventos Comunitários: Realizar eventos abertos, como feiras de saúde e encontros comunitários, onde a TCI possa ser apresentada e experimentada pela comunidade.

Ao promover a sensibilização e o engajamento de gestores, profissionais da saúde e da comunidade como um todo no que diz respeito à TCI, viabiliza-se o fortalecimento da saúde mental coletiva, cria-se redes de apoio sólidas e contribui-se para a construção de comunidades mais resilientes e saudáveis.

11

CONTROLE SOCIAL/PARTICIPAÇÃO SOCIAL

11.1 Introdução

O controle social na saúde se refere à participação da sociedade no planejamento, execução e monitoramento das políticas públicas de saúde, garantindo a transparência e a democratização na gestão do sistema de saúde. Esse conceito está intrinsecamente ligado à ideia de que a população deve ter voz ativa nas decisões que afetam sua saúde e bem-estar, permitindo que suas necessidades e expectativas sejam consideradas. No Brasil, essa participação é formalmente instituída pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que cria os Conselhos e Conferências de Saúde como espaços de deliberação e controle social (Brasil, 1990b).

A importância do controle social reside na sua capacidade de promover a *accountability* e a eficiência no uso dos recursos públicos, além de assegurar que as políticas de saúde atendam às reais demandas da população. Ao envolver os cidadãos no processo de tomada de decisão, o controle social contribui para a construção de um sistema de saúde mais equitativo e inclusivo, em que as ações são direcionadas não apenas por interesses técnicos, mas também pelos valores e necessidades comunitárias. Além disso, fortalece a cidadania ativa e a conscientização sobre os direitos e deveres em relação à saúde pública (Goulart, 2010).

O processo de participação social em saúde no Brasil é inacabado e frágil, especialmente no nível local. Assim, o arejamento e a ampliação das discussões sobre a mesma constituem tarefas essenciais para aqueles que se dedicam a

buscar soluções para a construção e o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, sem deixar de reconhecer que o país tem história acumulada nesta área (Goulart, 2010).

11.2 Controle Social e a TCI

No contexto da participação popular, a TCI é potente para o desenvolvimento sustentável de comunidades, já que possibilita um novo olhar para si mesmo e para o entorno, a partir do compartilhamento de histórias de vida, dor e conflitos, de forma horizontal e circular, abrindo portas para a agregação de conhecimento científico ao saber popular. Como desdobramentos desta tecnologia social vislumbram-se suporte e apoio grupal e/ou comunitário; abertura de espaços de fala sobre sofrimentos e possibilidades de superação dos mesmos; resgate de autoestima; suporte para a prática de mudanças existenciais, além da promoção da saúde inserida na atenção primária em saúde, com incentivo a usar a criatividade das pessoas aproveitando os recursos da própria cultura (Barreto, 2008; Camarotti *et al.*, 2011).

A partir destas reflexões, a TCI pode ser um instrumento estratégico e eficaz na promoção do controle social, pois cria espaços de diálogo e empoderamento no contexto territorial comunitário de facilitação de agregação, mobilização e inclusão social. A TCI facilita a formação de vínculos e a troca de saberes entre os participantes, promovendo a coesão social e a identificação de problemas comuns (Barreto, 2008; Camarotti *et al.*, 2011). Esse processo fortalece a capacidade da comunidade de se organizar e articular demandas, tornando-a mais apta a participar ativamente dos Conselhos de Saúde e outras instâncias de controle social.

Logo, a TCI não só contribui para a saúde mental e emocional dos indivíduos, mas também para o fortalecimento do controle social, ao engajar a comunidade na construção e monitoramento das políticas públicas de saúde.

REFLEXÃO!

- ❖ É possível associar TCI e participação social — uma com propósitos *terapêuticos e construção de vínculos solidários* e outra voltada para a *participação*?
- ❖ A resposta é sim, e a denominação atribuída a essa conexão é *Participação Comunitária Integrativa (PCI)*.

Essa proposta, denominada Participação Comunitária Integrativa — construída por Flávio Goulart e Henriqueta Camarotti — alia princípios de participação social em nível *micro* com a essência da TCI, integrando individual e comunitário; terapêutico e ação política; identificação do sofrimento psíquico; busca de soluções e determinação socioeconômica (Goulart; Camarotti, 2023). Aqui, se aplicaria diretamente o enfoque de *saúde em todas as políticas*, como proposto pela Organização Mundial da Saúde, com definição gradual de prioridades e focos, respeitando o *timing* e a capacidade de compreensão dos participantes.

Na práxis do método de trabalho é preciso, primeiramente, exercer uma condução flexível na busca do interesse real dos participantes comunitários, sem cair nas malhas formais do *poder deliberativo e paridade*. O desencaideamento do processo deve acontecer sob a forma de sessões abertas, não como conselhos restritos e regulados inflexivelmente. Ainda em termos da condução, deve-se contar com a qualificação das pessoas envolvidas com relação a atribuições de mobilização, facilitação, documentação e assessoria técnica. Por último, mas não menos importante, zelar pela produção compulsória e mediante responsabilização definida formalmente de documentos que explicitem os resultados do processo, a serem divulgados de forma acessível, seja como memória impressa, notas na internet, folders, apresentações orais e outros (Goulart; Camarotti, 2023).

A seguir, são descritos alguns passos da proposta de Participação Comunitária Integrativa sugerida por Goulart e Camarotti (2023).

11.2.1 Participação Comunitária Integrativa: uma Proposta para “Fazer Diferente”

Como operacionalizar as contribuições da Terapia Comunitária Integrativa (TCI) na participação social em saúde? Como associar a micro participação (local, em nível de serviços de saúde) e a prática da TCI?

Objetivo: A proposta visa integrar a Terapia Comunitária Integrativa à participação social em saúde, promovendo a inclusão e a valorização das experiências individuais e coletivas nas comunidades locais.

Metodologia:

- A) Participação Grupal: A PCI e a TCI funcionam em grupo, valorizando a diversidade de experiências de vida dos participantes.
- B) Facilitadores: O facilitador atua como um catalisador, promovendo acolhimento, questionamentos, e debates de forma horizontal e circular, respeitando a diversidade e a solidariedade.
- C) Sessões Abertas: As sessões são abertas e flexíveis, conduzidas por facilitadores qualificados que estimulam a participação e a troca de experiências.

Componentes do Projeto Piloto:

- A) Preparação das Unidades de Saúde: Inicia-se com o interesse das unidades de saúde locais, que devem estar abertas à participação de todos os interessados.
- B) Formação dos Facilitadores: Estes podem ser terapeutas comunitários, porém com formação complementar em participação social, ou também mediante formação em TCI adaptada a sua aplicação a *participação integrativa* em saúde.
- C) Localização e Periodicidade: As rodas de TCI serão realizadas em unidades de saúde selecionadas, com periodicidade definida (semanal, quinzenal ou mensal).

Metodologia das Sessões:

- A) Acolhimento: Apresentação das regras e dinâmica de aquecimento.
- B) Escolha do Tema: Os problemas são trazidos pelos participantes e um tema é escolhido.
- C) Contextualização: O problema é detalhado e discutido.
- D) Compartilhamento: Participantes compartilham experiências de superação.
- E) Fechamento: Agradecimentos e reflexão sobre o aprendizado da sessão.

Avaliação e Encaminhamentos:

Facilitadores avaliam as sessões e encaminham as questões levantadas aos órgãos competentes.

Conclusão: A PCI, utilizando a metodologia da TCI, promove uma participação comunitária inclusiva, valorizando as experiências e saberes dos participantes, e direciona as demandas da comunidade para os canais apropriados, com o objetivo de expandir e difundir essa prática para outras áreas e unidades de saúde.

12

INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA TCI

12.1 Introdução

Os instrumentos de gestão da Terapia Comunitária Integrativa (TCI) no Sistema Único de Saúde (SUS) são ferramentas e mecanismos utilizados para planejar, implementar, monitorar e avaliar essa prática terapêutica dentro da rede de Atenção Primária à Saúde. Esses instrumentos garantem que a TCI seja conduzida de maneira organizada, eficiente e eficaz, alinhada com as diretrizes do SUS.

Alguns dos instrumentos de gestão são apresentados a seguir.

12.2 Instrumentos de Gestão da TCI

A) Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)

- Estabelece as diretrizes para a implementação e expansão das práticas integrativas e complementares, incluindo a TCI, em todo o território nacional.
- Define os princípios e objetivos para integrar essas práticas na atenção primária à saúde.

B) Planos de Ação Municipais e Estaduais

- São documentos que detalham as estratégias, metas e ações específicas para a implementação e gestão da TCI em cada município ou estado.
- Incluem a alocação de recursos, formação de profissionais e cronogramas de atividades.

C) Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)

- Fornecem orientações técnicas e científicas para a prática da TCI, assegurando que os procedimentos sejam realizados de forma padronizada e segura.
- Ajudam a guiar os profissionais de saúde sobre como conduzir as sessões de TCI e integrar essa prática com outras formas de cuidado.

D) Sistemas de Informação em Saúde

- Utilizam plataformas como o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e o e-SUS APS para registrar, monitorar e avaliar as atividades de TCI.
- Facilitam a coleta de dados, a análise de resultados e a tomada de decisões baseada em evidências.

E) Capacitação e Educação Permanente

- Inclui programas de formação e atualização para profissionais de saúde que atuam na TCI, garantindo que eles possuam as competências necessárias para a prática.

F) Indicadores de Saúde

- Conjuntos de indicadores específicos que permitem medir e avaliar os resultados e impactos da TCI na saúde da população. Esses indicadores podem incluir métricas de saúde mental, bem-estar social e engajamento comunitário.

G) Supervisão e Monitoramento

- Procedimentos e metodologias para acompanhar de perto a execução das atividades de TCI, garantindo que elas estejam alinhadas com os padrões de qualidade e cumpram os objetivos estabelecidos nos planos de ação.

H) Avaliação de Impacto

- Estudos e pesquisas que analisam os efeitos e benefícios da TCI na saúde das comunidades, fornecendo dados para ajustes e melhorias contínuas nas práticas e políticas.

I) Rede de Apoio e Parcerias

- Estruturação de redes de colaboração entre profissionais de saúde, instituições acadêmicas, organizações não governamentais e outros atores envolvidos na promoção e implementação da TCI.

J) Regulamentação e Normatização

- Leis, portarias e resoluções que estabelecem os parâmetros legais e normativos para a prática da TCI, garantindo que todas as atividades estejam em conformidade com as políticas de saúde pública do SUS.

K) Feedback da Comunidade

- Mecanismos para coletar e incorporar as opiniões e experiências dos usuários sobre a TCI, ajudando a ajustar e melhorar as práticas com base nas necessidades e expectativas da comunidade.

Esses instrumentos de gestão são fundamentais para a integração eficaz da TCI na atenção primária do SUS, promovendo uma abordagem holística e participativa na promoção da saúde mental e do bem-estar das comunidades.

13

PASSO A PASSO PARA A IMPLANTAÇÃO DA TCI NA APS

13.1 Passos para a Implantação da TCI

De modo geral, alguns passos são fundamentais para nortear a implantação da Terapia Comunitária Integrativa na Atenção Primária à Saúde.

Passo 1 – Eleger uma Comissão de Coordenação

A comissão deve ser composta, preferencialmente, por profissionais ligados à Atenção Primária à Saúde (APS) do município, se possível de caráter multiprofissional, e pessoas que tenham experiência com a TCI, ou que pelo menos sejam profissionais, assim como por usuários com interesse no assunto (Brasil, 2018; Santos; Tesser, 2012).

É aconselhável que a coordenação não fique a cargo de uma pessoa exclusivamente, o que pode centralizar política e administrativamente a implantação da TCI, desde que não se trate de municípios de pequeno porte, com escassez do número de funcionários, como sugerem Santos e Tesser (2012). Para estes municípios, caso não haja profissionais elegíveis para atuar na coordenação, pode-se pensar em convidar profissionais experientes na área de municípios vizinhos.

Segundo Santos e Tesser (2012), possíveis atribuições da Comissão de Coordenação de implantação da TCI são:

- a) Discutir com os atores (gestores, profissionais e Conselho Municipal de Saúde), através de reuniões, as diretrizes de implantação;
- b) Definir um plano de ação;

- c) Pactuar um cronograma de atividades e periodicidade de reuniões;
- d) Propor normatização local;
- e) Realizar assessoria técnica, atividades educativas, estudos e pesquisas;
- f) Articular ações intersetoriais para o desenvolvimento das ações pactuadas localmente, entre outras.

O ideal é legitimar o grupo coordenador por um Ato Institucional do gestor municipal, para garantir a continuidade das ações em caráter permanente, evitando a descontinuidade da ação; mas não é fundamental que isso seja feito.

Para o plano de ação, com prazos e metas, deve-se considerar: (a) Análise Situacional, (b) Regulamentação e (c) Implantação, propriamente dita.

Passo 2 – Diagnóstico Situacional do Município

Esta etapa consiste na pesquisa de informações sobre o contexto e a realidade inerente do município, que seja de importância para a implantação da TCI, tais como:

- a) Quais as necessidades em saúde mental que o município apresenta como mais relevantes;
- b) Onde se encontram os grupos mais vulneráveis e demandas específicas, como: principais determinantes sociais, violência contra mulher, alcoolismo, bullying contra adolescentes, dependência química etc.;
- c) Qual a situação do município em relação à TCI? Já existem grupos isolados oferecendo a TCI? Qual a modalidade de oferta: presencial, on-line ou ambas? Ocorrem em Unidade Básicas de Saúde (UBS)? Ou em outras instituições?
- d) Mapeamento dos profissionais: Existem profissionais do SUS no município formados e credenciados em TCI? Estes profissionais estão interessados em ofertar as rodas de TCI na APS? Em qual modalidade?

- e) Existem profissionais interessados em realizar o curso de formação em TCI?
- f) Os profissionais que trabalham com TCI, ou tem interesse nela, estão dispostos a se juntar ao grupo para formar um grupo colaborativo?
- g) Quando não há profissionais formados em TCI ou interessados, quais seriam as possíveis parcerias público-privadas no município, ou a possibilidade de estabelecer consórcios entre municípios?
- h) Qual a opinião dos profissionais da rede sobre a TCI? Indicariam usuários para participar das rodas?
- i) Já existem outras PICS funcionando no município? Onde estão sendo oferecidas? Qual foi o método usado para implantar as práticas?
- j) Existem no município possíveis redes de apoio (intersectorialidades), como associações comunitárias, instituições religiosas, grupos civis etc., para propor parcerias?

Definidos os profissionais interessados em TCI, e com as informações sobre a Análise Situacional do município, pode-se realizar reuniões para abordar temas como:

- a) Quais barreiras para realização de rodas de TCI na APS do município? Quais as possíveis medidas de enfrentamento?
- b) Qual a melhor estratégia de organização do trabalho e do fluxo de atendimento?
- c) Como incorporar as rodas de TCI com a rotina de trabalho dos profissionais, sem os sobrecarregar em suas demandas profissionais na APS?
- d) Quais materiais, equipamentos, insumos serão necessários para a realização das rodas?
- e) Quais os locais mais apropriados onde poderiam ser realizadas as rodas? As UBS têm espaço para as rodas? Em quais outros equipamentos de saúde podem ser realizadas as rodas? Quais outras localidades poderiam abrigar as rodas, como salão paroquial ou igrejas, templos, salão comuni-

tário da associação de moradores, escolas, CAPS, praças, parques. Existe a possibilidade de convênios com instituições privadas, como empresas, indústrias, fábricas?

Após todas as informações coletadas, deve-se realizar um relatório de Análise Situacional, que direciona os próximos passos da implantação. É importante definir metas e objetivos. A ajuda das Agentes Comunitárias de Saúde pode ser de grande valia na busca de informações da análise situacional.

Ao final, é recomendado levar o relatório de análise situacional para apreciação do Conselho Municipal de Saúde para conhecimento, discussão e aprovação.

Passo 3 – Regulamentação

Esta etapa é importante para que o trabalho de implantação e implementação não seja perdido em decorrência, por exemplo, de uma possível mudança de gestão, garantindo a continuidade das ações em caráter permanente. Também é importante para legitimação profissional e institucional, garantindo que sejam promovidas as atividades inerentes à prática da TCI na APS.

A regulamentação pode ser por uma política municipal ou, ainda, por um simples ato institucional do gestor, que esteja em consonância com a PNPIC e enfatizando a oferta da TCI, como acesso aos usuários, organização da demanda, estruturação dos serviços, estruturação do processo de trabalho, registro do trabalho realizado, participação social, dentre outros julgados relevantes (Santos; Tesser, 2012).

Todas estas ações são modelos propostos, podendo ser adequados à realidade do município conforme necessário.

Por fim, é importante a inclusão da oferta da TCI no Plano Municipal da Saúde e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município, definindo, assim, recursos orçamentários e financeiros (Brasil, 2018).

Outras ações de regulamentação são necessárias, como o registro no SCNES, cadastro de PICS no Ministério da Saúde e cadastro de profissionais atuantes com a TCI no município. Para mais informações, acesse o Capítulo 5 sobre Registros da TCI.

Passo 4 – Plano de Implantação da TCI

O plano de implantação não deve ser rígido para toda a APS do município. Pode ser personalizado para cada UBS ou local onde acontecerão as rodas, uma vez que cada território possui as suas características próprias e necessidades específicas, favorecendo uma maior chance de sucesso (Santos; Tesser, 2012).

De acordo com as informações levantadas no Diagnóstico Situacional, deve-se indicar os objetivos, as metas, e definir as ações a serem realizadas, estabelecendo-se os prazos, as ferramentas necessárias e os atores responsáveis por cada ação.

1) Recursos Humanos para a TCI

- a) Definir quais profissionais, já formados em TCI, ofertarão as rodas no município. Promover a formação de novos terapeutas comunitários integrativos, dentre os profissionais atuantes na APS que tenham interesse. Para isso, deve-se verificar as fontes de financiamento disponíveis (abordado no Capítulo 4), para a viabilização de convênios com as instituições formadoras (Rede de Polos Formadores credenciados pela ABRATECOM) para a oferta do curso no município. Os Capítulos 2 e 9 fornecem informações sobre o curso de capacitação, carga horária, Polos Formadores e os conselhos de classe da área da saúde que, até então, aprovaram a atuação como terapeuta comunitário.
- b) É importante sensibilizar os profissionais já formados em TCI no município para que possam ajudar na capacitação.

- c) Contratar profissionais terceirizados, caso não haja demanda de profissionais da rede, ou consórcio intermunicipal para ter profissionais habilitados.
- d) Definir a estratégia para os terapeutas comunitários atuarem: horários e turnos de atuação (tempo integral/parcial dedicado para a TCI); se haverá incentivo financeiro/função gratificada etc. A estratégia pode ser personalizada para cada profissional.
- e) Promover um programa de Educação Permanente em Saúde, que deve ser iniciado após a implantação da TCI, através de parcerias com os Governos Federal e Estadual, ou com associações e instituições, como a ABRATECOM e Polos Formadores. Estabelecer assuntos relevantes e atividades educativas para Educação Permanente dos atores da TCI no município.
- f) O apoio matricial é importante para ser realizado dentro do município, em que um terapeuta mais experiente auxilia outros terapeutas recém formados na condução das rodas. Pode-se também solicitar o apoio matricial de outras instituições para auxílio.
- g) Criação de grupo para troca de experiências entre os atores atuantes com a TCI no município, para compartilhamento de ações bem-sucedidas, discussão de dúvidas e promoção de melhorias na prática da TCI no município.

2) Locais e Estruturas Físicas

- a) Dentre os locais possíveis de implementar as rodas de TCI, definir quais locais serão usados.
- b) Definir como serão as rodas: descentralizadas (acontecendo em vários locais do território) ou centralizadas? O ideal é que as rodas ocorram no território em que a pessoa vive (se possível), utilizando UBS, salão paroquial, escolas etc.

- c) Definir a periodicidade das rodas.
- d) Realizar capacitação para os terapeutas no que diz respeito à forma de registro das rodas (consultar o Capítulo 5 sobre registro da TCI).

3) Avaliação e Monitoramento

- a) Avaliar os indicadores propostos com a finalidade de monitorar as ações da TCI (consultar o Capítulo 6 sobre indicadores)
- b) O grupo coordenador deve manter contato com os terapeutas comunitários, avaliando seus relatos, necessidades e dificuldades encontradas, para nortear o aprimoramento das rodas futuras e discutir as novas demandas, superando as barreiras surgidas durante a implantação e implementação da TCI.
- c) Realizar reuniões com periodicidade a ser definida pelos atores, a fim de trocar experiências, avaliar e monitorar a prática da TCI na APS do município.
- d) O objetivo deve ser o de uma gestão participativa, construção da integralidade, busca da resolubilidade, incentivo ao autocuidado, atuando como complementar ao modelo biomédico vigente.

4) Viabilização de Insumos para a Prática da TCI

- a) A equipe de coordenação, em conjunto com os profissionais que atuarão nas rodas, devem elencar e providenciar os insumos necessários, de forma a otimizar os recursos e garantir a obtenção dos insumos realmente necessários para a realização das rodas de TCI.

5) Divulgação do Início da Oferta da TCI na APS

- a) Promover a divulgação do início das rodas. Usar meios de divulgação contendo informações sobre o que é a TCI, a quem se destina, como funciona e os benefícios para os participantes. Usar meios de comunicação, como folders, flyers, cartazes, divulgação em rádios locais, e outros meios que possam se aproximar da linguagem cultural de cada grupo,

como Hip Hop, literatura de cordel, quadrinhos, entre outros. Divulgar os locais e horários das rodas.

- b) Solicitar o apoio dos profissionais das UBS, principalmente dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), fazendo o vínculo com a comunidade.

6) Iniciar as Rodas de TCI

- a) Colocar em prática as rodas de TCI, beneficiando os usuários do SUS com este recurso terapêutico tão valioso para o enfrentamento da saúde mental.
- b) Iniciar as ações de monitoramento e avaliação, em conjunto com a Gestão, corrigindo eventuais falhas que possam estar ocorrendo, visando sempre o melhor fluxo da TCI no município.

14

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

14.1 Introdução

A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) baseia-se em uma sólida base de evidências científicas. Estudos têm indicado que essa prática pode melhorar significativamente a saúde mental e o bem-estar dos participantes, promovendo um espaço seguro para o compartilhamento de vivências e a construção de redes de apoio. Além disso, a TCI é eficaz na redução de sintomas de ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental, proporcionando uma abordagem complementar aos tratamentos convencionais (Silva *et al.*, 2021).

14.1.1 Acesso a Recursos e Pesquisas

Para quem deseja aprofundar o conhecimento sobre a TCI e outras Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), sugere-se acessar a plataforma de busca Mendeley.

Mendeley

https://www.mendeley.com/search/?query=terapia+comunit%C3%A1ria+integrativa&dgcid=md_homepage

Em 2024, Maria Lucia de Andrade Reis e Anamélia Lins e Silva utilizaram esta plataforma de busca para realizar um levantamento de artigos, teses, dissertações e livros publicados sobre a TCI abrangendo o período de 2006 a 2023. O resultado encontra-se disponível no site da ABRATECOM no link <https://abratecom.org/cientifica/>.

Ademais, é essencial consultar bases de dados de pesquisa reconhecidas para garantir a confiabilidade e qualidade das informações. Dentre elas:

- a) OMS: Publicações
- b) ObservaPICS: Fiocruz
- c) BVS MTCTI: Biblioteca Virtual em Saúde - MTCTI
- d) Cabsin: Cabsin
- e) Cochrane Library: Cochrane Library
- f) Scopus: Scopus
- g) Lilacs: Lilacs
- h) Embase: Elsevier
- i) Banco de Tese da CAPES: Catálogo de Teses
- j) Pubmed: Pubmed

14.1.2 Cuidados na Divulgação de Informações sobre a TCI

É crucial que a disseminação de informações sobre a TCI e demais PICS seja feita com responsabilidade e fundamentada em evidências científicas rigorosas. Deve-se evitar a propagação de *fake news* e informações baseadas em preconceitos culturais.

A participação de pesquisadores e profissionais da saúde é essencial para garantir uma discussão baseada em evidências, sem vieses pessoais. As informações divulgadas devem ser sempre verificadas e embasadas em estudos científicos para evitar desinformação e garantir a segurança dos pacientes.

A Nota Técnica, assinada pela RedePICS Brasil, ABRATECOM e Associação Brasileira de Naturologia, disponível em <https://abratecom.org/>, trata sobre as Evidências Científicas em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e destaca algumas PICS, entre elas, a TCI.

A TCI, amplamente reconhecida ao longo dos anos por seus impactos positivos no cuidado coletivo biopsicossocial, foi certificada, em 2024, como

uma tecnologia social e está sendo sistematizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Tanto a certificação como a sistematização reforçam seu caráter de inovação social e a repercussão comunitária, apresentando-a como uma prática que vai além dos cuidados terapêuticos tradicionais, pois há a participação comunitária em prol da busca pela saúde e bem-estar.

Essas diretrizes são fundamentais para promover a adoção segura e eficaz da TCI e das PICS, garantindo que essas práticas complementem, e não substituam, os tratamentos médicos convencionais.

ANEXO A

Quadro A.1 – Profissionais da saúde, com capacitação em TCI, habilitados a registrar rodas de TCI nos sistemas de informação do SUS (continua)

CBO	Profissional da saúde	CBO	Profissional da saúde
221205	Biomédico	223515	Enfermeiro de bordo
2231A1	Médico broncoesofalogista	223520	Enfermeiro de centro cirúrgico
2231F8	Médico em medicina preventiva e social	223525	Enfermeiro de terapia intensiva
2231F9	Médico residente	223530	Enfermeiro do trabalho
2231G1	Médico Cardiologista Intervencionista	223535	Enfermeiro nefrologista
223204	Cirurgião dentista - auditor	223540	Enfermeiro neonatologista
223208	Cirurgião dentista - clínico geral	223545	Enfermeiro obstétrico
223212	Cirurgião dentista - endodontista	223550	Enfermeiro psiquiátrico
223216	Cirurgião dentista - epidemiologista	223555	Enfermeiro puericultor e pediátrico
223220	Cirurgião dentista - estomatologista	223560	Enfermeiro sanitaria
223224	Cirurgião dentista - implantodontista	223565	Enfermeiro da estratégia de saúde da família
223228	Cirurgião dentista - odontogeriatra	223570	Perfusionista
223232	Cirurgião dentista - odontologista legal	223580	Enfermeiro estomaterapeuta
223236	Cirurgião dentista - odontopediatra	223605	Fisioterapeuta geral
223240	Cirurgião dentista - ortopedista e ortodontista	223625	Fisioterapeuta respiratória
223244	Cirurgião dentista - patologista bucal	223630	Fisioterapeuta neurofuncional
223248	Cirurgião dentista - periodontista	223635	Fisioterapeuta traumatológico-ortopédica funcional
223252	Cirurgião dentista - protesiólogo bucomaxilofacial	223640	Fisioterapeuta osteopata
223256	Cirurgião dentista - protesista	223645	Fisioterapeuta quiropraxista
223260	Cirurgião dentista - radiologista	223650	Fisioterapeuta acupunturista
223264	Cirurgião dentista - reabilitador oral	223655	Fisioterapeuta esportivo
223268	Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial	223660	Fisioterapeuta do trabalho

Quadro A.1 – Profissionais da saúde, com capacitação em TCI, habilitados a registrar rodas de TCI nos sistemas de informação do SUS (continuação)

CBO	Profissional da saúde	CBO	Profissional da saúde
223272	Cirurgião dentista de saúde coletiva	223611	Técnico em orientação e mobilidade de cegos e deficientes visuais
223276	Cirurgião dentista - odontologia do trabalho	223710	Nutricionista
223280	Cirurgião dentista - dentística	223810	Fonoaudiólogo geral
223284	Cirurgião dentista - disfunção temporomandibular e dor orofacial	223905	Terapeuta ocupacional
223288	Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais	224105	Avaliador físico
223293	Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família	224110	Ludomotricista
223405	Farmacêutico	224115	Preparador de atleta
223415	Farmacêutico analista clínico	224120	Preparador físico
223420	Farmacêutico de alimentos	224125	Técnico de desporto individual e coletivo (exceto futebol)
223425	Farmacêutico práticas integrativas e complementares	224130	Técnico de laboratório e fiscalização desportiva
223435	Farmacêutico industrial	224135	Treinador profissional de futebol
223440	Farmacêutico toxicologista	224140	Profissional de educação física na saúde
223445	Farmacêutico hospitalar e clínico	225103	Médico infectologista
223505	Enfermeiro	225105	Médico acupunturista
223510	Enfermeiro auditor	225106	Médico legista
225109	Médico nefrologista	225255	Médico mastologista
225110	Médico alergista e imunologista	225260	Médico neurocirurgião
225112	Médico neurologista	225265	Médico oftalmologista
225115	Médico angiologista	225270	Médico ortopedista e traumatologista
225118	Médico nutrologista	225275	Médico otorrinolaringologista
225120	Médico cardiologista	225280	Médico coloproctologista
225121	Médico oncologista clínico	225285	Médico urologista
225122	Médico cancerologista pediátrico	225290	Médico cancerologista cirurgico
225124	Médico pediatra	225295	Médico cirurgião da mão

Quadro A.1 – Profissionais da saúde, com capacitação em TCI, habilitados a registrar rodas de TCI nos sistemas de informação do SUS (continuação)

CBO	Profissional da saúde	CBO	Profissional da saúde
225125	Médico clínico	225305	Médico citopatologista
225127	Médico pneumologista	225310	Médico em endoscopia
225130	Médico de família e comunidade	225315	Médico em medicina nuclear
225133	Médico psiquiatra	225325	Médico patologista
225135	Médico dermatologista	225330	Médico radioterapeuta
225136	Médico reumatologista	225335	Médico patologista clínico / medicina laboratorial
225139	Médico sanitarista	225340	Médico hemoterapeuta
225140	Médico do trabalho	225345	Médico hiperbarista
225142	Médico da estratégia de saúde da família	225350	Médico neurofisiologista clínico
225145	Médico em medicina de trânsito	226105	Quiropraxista
225148	Médico anatomopatologista	226110	Osteopata
225150	Médico em medicina intensiva	226305	Musicoterapeuta
225151	Médico anesthesiologista	226310	Arteterapeuta
225154	Médico Antroposófico	226315	Equoterapeuta
225155	Médico endocrinologista e metabologista	226320	Naturólogo
225160	Médico fisiatra	234410	Professor de educação física no ensino superior
225165	Médico gastroenterologista	234415	Professor de enfermagem do ensino superior
225170	Médico generalista	251505	Psicólogo educacional
225175	Médico geneticista	251510	Psicólogo clínico
225180	Médico geriatra	251515	Psicólogo do esporte
225185	Médico hematologista	251520	Psicólogo hospitalar
225195	Médico homeopata	251525	Psicólogo jurídico
225203	Médico em cirurgia vascular	251530	Psicólogo social
225210	Médico cirurgião cardiovascular	251535	Psicólogo do trânsito

Quadro A.1 – Profissionais da saúde, com capacitação em TCI, habilitados a registrar rodas de TCI nos sistemas de informação do SUS (conclusão)

CBO	Profissional da saúde	CBO	Profissional da saúde
225215	Médico cirurgião de cabeça e pescoço	251540	Psicólogo do trabalho
225220	Médico cirurgião do aparelho digestivo	251545	Neuropsicólogo
225225	Médico cirurgião geral	251550	Psicanalista
225230	Médico cirurgião pediátrico	251555	Psicólogo Acupunturista
225235	Médico cirurgião plástico	251605	Assistente social
225240	Médico cirurgião torácico	322105	Técnico em acupuntura
225250	Médico ginecologista e obstetra	322115	Técnico em quiropraxia
322120	Massoterapeuta	322425	Técnico em saúde bucal da estratégia de saúde da família
322125	Terapeuta holístico	322430	Auxiliar em saúde bucal da estratégia de saúde da família
322205	Técnico de enfermagem	352210	Agente de saúde pública
322210	Técnico de enfermagem de terapia intensiva	515105	Agente comunitário de saúde
322215	Técnico de enfermagem do trabalho	515110	Atendente de enfermagem
322220	Técnico de enfermagem psiquiátrica	515115	Parteira leiga
322225	Instrumentador cirúrgico	515120	Visitador sanitário
322230	Auxiliar de enfermagem	515125	Agente indígena de saúde
322235	Auxiliar de enfermagem do trabalho	515130	Agente indígena de saneamento
322240	Auxiliar de saúde (navegação marítima)	515135	Socorrista (exceto médicos e enfermeiros)
322245	Técnico de enfermagem da estratégia de saúde da família	515140	Agente de Combate às Endemias
322250	Auxiliar de enfermagem da estratégia de saúde da família	5151F1	Agente de Combate às Endemias
322405	Técnico em saúde bucal	516220	Cuidador em saúde
322415	Auxiliar em saúde bucal		

Fonte: SIGTAP (2025).

Referências

- ABRATECOM – Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa. *Resolução Normativa nº 001/2021*. Estabelece as normas que regem a criação, o reconhecimento e o funcionamento da capacitação híbrida em TCI. Curitiba: 2021. Disponível em: <<https://abratecom.org/docs/>>. Acesso em: 22 jul. 2024.
- ALVAREZ, E. K.; HENRICHS, J. A. *Consórcios públicos intermunicipais: como e para que cooperar?* Brasília: CNM, 2020. Disponível em: <https://cnm.org.br/storage/biblioteca/2023/Cons%C3%B3rcios%20P%C3%BAblicos%20Intermunicipais%20Como%20e%20para%20que%20cooperar_publicada.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2024.
- BARRETO, A. P. *Terapia comunitária: passo a passo*. 4. ed. Fortaleza: Gráfica LCR, 2008.
- BARRETO, A. P.; BARRETO, M. C. R.; OLIVEIRA, D.; BARRETO, I. C. H. C.; ABDALA, M. P. *Terapia comunitária integrativa na ESF/SUS*. Ministério da Saúde, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, 2011. Disponível em: <https://www.academia.edu/22384738/Terapia_Comunit%C3%A1ria_Integrativa_na_ESF_SU>. Acesso em: 22 jun. 2024.
- BARRETO A. P.; SILVA, M. Z.; HORTA, M. L. M; FERREIRA FILHA, M. O.; DIAS, M. D.; SVOBODA, W. K. *Terapia comunitária integrativa: cuidando da saúde mental em tempos de crise*. Recife: Fiocruz-PE; ObservaPICS, 2020. Disponível em: <<https://observapics.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/02/Especial-PICS-Covid-TCI-ObservaPICS.pdf>>. Acesso em: 02 jul. 2024.
- BRANDEN, N. *O poder da auto-estima*. São Paulo: Saraiva, 1994.
- BRASIL. Senado Federal. *Constituição Federal*. Brasília: 1988.
- BRASIL. Presidência da República. *Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990*. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 20 set. 1990a. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 31 mai. 2024.
- BRASIL. Presidência da República. *Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990*. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 31 dez. 1990b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm>. Acesso em: 15 abr. 2024.
- BRASIL. Presidência da República. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Diário Oficial da União, 23 dez. 1996. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC-SUS*. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpic.pdf>>. Acesso em: 30 mai. 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *O SUS e a terapia comunitária*. Org.: Luiz Odorico Monteiro de Andrade, Ivana Cristina de H. C. Barreto, Adalberto Barreto. Fortaleza: 2008.
- BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI. *Indicadores de programas: Guia Metodológico*. Brasília: MP, 2010.

BRASIL, Ministério da Saúde. *Política Nacional de Atenção Básica*. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: <<http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf>>. Acesso em: 25 mai. 2024.

BRASIL. Presidência da República. *Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014*. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Brasília: Diário Oficial da União, 01 ago. 2014. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113019.htm>. Acesso: 02 mai. 2024.

BRASIL. Presidência da República. *Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015*. Altera a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Brasília: Diário Oficial da União, 15 dez. 2015a. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113204.htm> Acesso em: 30 mai. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. *Qualificação dos Indicadores do Manual Instrutivo para as equipes de Atenção Básica (Saúde da Família, Saúde Bucal e Equipes Parametrizadas) e NASF*. Brasília: Ministério da Saúde, 2015b. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/qualificacao_indicadores_manual_instrutivo_equipes.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. *Portaria nº 849, de 27 de março de 2017*. Inclui a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Brasília: Diário Oficial da União, 28 mar. 2017. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt0849_28_03_2017.html>. Acesso em: 30 mai. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Manual de implantação de serviços de práticas integrativas e complementares no SUS*. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pics/publicacoes/manual_implantacao_servicos_pics.pdf/view>. Acesso em 30 mai. 2024.

BRASIL. Presidência da República. *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021*. Lei de licitações e contratos administrativos. Brasília: Diário Oficial da União, 01 abr. 2021. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/14133.htm>. Acesso em: 30 mai. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Plano Nacional de Saúde 2024-2027*. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/gestao-do-sus/instrumentos-de-planejamento/pns/plano-nacional-de-saude-pns-2024-2027/view>>. Acesso em: 14 jul. 2024.

CAMAROTTI, M. H.; FREIRE, T. C. G. P.; BARRETO, A. P. *Terapia comunitária integrativa sem fronteiras*. Brasília: MismecDF, 2011.

DECS. *Descritores em Ciências da Saúde 2024*. São Paulo: BIREME /OPAS/OMS, 2024. Disponível em: <https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=60077&filter=ths_termall&q=terapia%20comunit%C3%A1ria%20integrativa>. Acesso em: 31 mai. 2024.

FERREIRA FILHA, M. O.; LAZARTE, R.; BARRETO, A. P. Impacto e tendências do uso da terapia comunitária integrativa na produção de cuidados em saúde mental. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, v. 17, n. 2, p. 172-173, 2015.

FUNDAÇÃO BB (BANCO DO BRASIL). *Terapia comunitária integrativa*, 2024. Disponível em: <<https://transforma.fbb.org.br/tecnologia-social/terapia-comunitaria-integrativa>>. Acesso em: 24 mar. 2024.

GIFFONI, F. A. O. *Saber ser, saber fazer: terapia comunitária, uma experiência de aprendizagem e construção da autonomia* [Tese de Doutorado]. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2008.

GIOVANELLA, L.; MENDONÇA, M. H. M. *Atenção primária à saúde*. In: GIOVANELLA, L.; ESCOREL, S.; LOBATO, L. V. C.; NORONHA, J. C.; CARVALHO, A. I., eds. Políticas e sistemas de saúde no Brasil [online]. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012, p. 493-545. DOI: <https://doi.org/10.7476/9788575413494.0019>.

GOULART, F. Dilemas da participação social em saúde no Brasil. *Saúde em Debate*, v. 34, n. 84, p. 18-32, 2010. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/4063/406341770003.pdf>>. Acesso em: 19 ago. 2024.

GOULART, F.; CAMAROTTI, M. H. *Participação em saúde: é preciso chegar de fato ao nível local*. 2023. [Internet, Blog de Goulart, F: A Saúde no Distrito Federal tem jeito!]. Disponível em: <<https://saudenodf.com.br/2023/05/12/participacao-em-saude-e-preciso-chegar-de-fato-ao-nivel-el-local/>>. Acesso em 19 set. 2024.

ITS BRASIL. *Caderno de debate: Tecnologia social: direito à ciência e ciência para a cidadania*. São Paulo: ITS, 2004. Disponível em: <<https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5172>>. Acesso em: 21 jun. 2024.

JANNUZZI, P. M. *Indicadores sociais no Brasil*. 5. ed. Campinas, SP: Editora Alínea, 2012.

MACEDO, J. P.; TESSER, C. D.; LUZ, M. T. (2020). Terapias integrativas e complementares: promoção de saúde, prevenção de agravos e o cuidado na atenção básica. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 11, p. 4717-4726, 2020.

MERHY, E. E. *Saúde: a cartografia do trabalho vivo*. São Paulo: Hucitec, 2002.

MINAYO, M. C. S. Construção de indicadores qualitativos para avaliação de mudanças. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 33, Supl. 1, p. 83-91, 2009.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. *Relatório de monitoramento das práticas integrativas e complementares em saúde nos sistemas de informação em saúde do SUS: 2017-2023*, Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/2024/relatorio-de-monitoramento-nacional-das-praticas-integrativas-e-complementares-em-saude.pdf>>. Acesso em: 20 fev. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. *Ministério da Saúde padroniza as diversas modalidades de teleatendimento* [Internet]. Publicado em: 08 jan. 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/ministerio-da-saude-padroniza-as-diversas-modalidades-de-teleatendimento>>. Acesso em: 14 fev. 2025.

MISMEC-CE - Movimento Integrado à Saúde Mental Comunitária. *Comunidade que cuida*. Portfólio Projeto 4 varas. Fortaleza, CE, 2020.

MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. *Manual Técnico do Plano Plurianual 2024-2027*. Governo Federal, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/planejamento/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/manual-do-ppa-2024-2027/pdf/view>>. Acesso em: 05 jul. 2024.

REIS, J. F. U.; COLATUSO, F. D.; BARRETO, A. P.; REIS, M. L. A.; GIOLO, S. R.; SILVA, M. Z.; PECHARKI, G. D. Online integrative community therapy: promoting mental health during the COVID-19 pandemic in Brazil. *Research, Society and Development*, v. 14, n. 1, p. e6314148035, 2025. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v14i1.48035>.

RIBEIRO, J. M. R.; COSTA, N. R. Regionalização da assistência à saúde no Brasil: Os consórcios municipais no Sistema Único de Saúde. *Planejamento e Políticas Públicas*, n. 22, p. 173-220, 2000. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4020/6/PPP_n22_Regionalizacao.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2024.

RIPSA – Rede Interagencial de Informação para a Saúde. *Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações*. 2. ed. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf>>. Acesso em: 05 jul. 2024.

RUIZ, J. E. L.; Silva, M. Z.; Martini, M. G. P. *et al.* A Terapia Comunitária Integrativa: criação, ação e reinvenção de uma associação brasileira em tempos de pandemia. In: Trajetórias das práticas integrativas e complementares no SUS – Volume I / organizado por Katia Machado... [et al.]. Rio de Janeiro: IdeiaSUS/Fiocruz, 2021. Disponível em: <<https://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/trajetorias-praticas-integrativas-complementares-sus.pdf>>. Acesso em: 30 jun. 2024.

RYFF, C. D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, v. 57, n. 6, p. 1096-1081, 1989. DOI: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069>.

SANTOS, M. C.; TESSER, C. D. Um método para a implantação e promoção de acesso às Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária à Saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 17, n. 11, p. 3011-3024, 2012.

SILVA, B. A. B.; PEREIRA, F. A. R.; OLIVEIRA L. F. A. *et al.* Contribuições da terapia comunitária integrativa na promoção da saúde: Revisão integrativa. *Revista de Pesquisa Online: Cuidado é Fundamental*, v. 13, p. 843-848, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v13.9238>.

SILVA, M. Z.; BARRETO, A. P.; RUIZ, J. E. L. *et al.* O cenário da terapia comunitária integrativa no Brasil: História, panorama e perspectivas. *Temas em Educação e Saúde*, v. 16, n. esp. 1, p. 341-359, 2020. DOI: <https://doi.org/10.26673/tes.v16iesp.1.14316>.

SILVA FRANCO, A. L.; SILVA, M. Z.; RUIZ, J. E. L.; MURCIA, M.; DE SOUZA, T. B.; MUZZETI, L. R. O valor da terapia comunitária integrativa (TCI) no Brasil e no mundo: possibilidades, impactos e perspectivas. *Temas em Educação e Saúde*, v.16, n.esp.1, p. 232-238, 2020. e-ISSN 2526-3471. DOI: <https://doi.org/10.26673/tes.v16iesp.1.14303>.

SMITH, B. W.; DALEN, J.; WIGGINS, K.; TOOLEY, E.; CHRISTOPHER, P.; BERNARD, J. The brief resilience scale: assessing the ability to bounce back. *International Journal of Behavioral Medicine*, v. 15, n. 3, p. 194-200, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1080/10705500802222972>.

STARFIELD, B. *Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia*. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: <<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/0253.pdf>>. Acesso em: 21 jun. 2024.

TESSER C. D.; SOUZA I. M. C.; NASCIMENTO, M. C. Práticas integrativas e complementares na atenção primária à saúde brasileira. *Saúde Debate*, v. 42, n. spec1, p. 174-188, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042018S112>.

WILLIAMS, B. Patient satisfaction: a valid concept? *Social Science & Medicine*, v. 38, n. 4, p. 509-516, 1994.



EDITORA ABRATECOM
Rua Profeta Isaías, 456, Pirambu
60333-765 - Fortaleza - CE - Brasil
Tel.: +55 (35) 99978-5508

CONVÊNIO



INSTITUIÇÕES COLABORADORAS



INSTITUIÇÕES APOIADORAS



Terapia Comunitária Integrativa

***Envolve a gente, bem aqui presente.
Encontra o corpo de alma consciente.
Ressoa e embala a comunidade que aqui vós fala.***

***Escuta presente que ativa e não mente.
Acolhe e integra o que passou e passa.
Comunica em som, ação e vibração a comunidade
que aqui se sente, sendo bem envolvente.***

***A TCI é espaço, é colo, é tudo que está na gente,
mesmo que às vezes um pouco ausente, abrindo
alas pra dores e risos, carentes e contentes,
integrando e revelando vida a cada encontro tão
latente, tão potente!***

Vitória Figueiredo Barreto.